古方医案选編

中·下集

戴佛延 编著

古方医案选编

中、下集

戴佛延　著

成都中医学院

一九八〇年九月

《古方医案选编》中集
《金匮要略》方医案目录

括蒌桂枝汤证案1例……（1）
葛根汤加味证案2例……（2）
大承气汤证案1例……（6）
麻黄加术汤证案1例……（7）
麻杏薏甘汤加味证案1例……（8）
越婢汤合防已黄芪汤加减证案2例……（9）
甘草附子汤证案1例……（11）
白虎加人参汤证案2例……（12）
百合地黄汤加减证案4例……（14）
甘草泻心汤加减证案2例……（20）
升麻鳖甲汤加味证案一例……（25）
鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸证案2例……（27）
白虎加桂法案4例……（30）
侯氏黑散证案1例……（33）
防已地黄汤加味证案1例……（35）
桂枝芍药知母汤证案1例……（37）
桂芍知母汤加味证案2例……（38）
乌头汤证案1例……（41）
黄芪桂枝五物汤加味证案1例……（42）
桂枝加龙骨牡蛎汤证案1例……（43）

加味桂枝加龙牡汤证案1例……（45）
天雄散证案1例……（46）
小建中汤证案4例……（47）
黄芪建中汤证案3例……（50）
黄芪建中汤加减证案2例……（52）
酸枣仁汤加味证案2例……（54）
大黄䗪虫丸证案1例……（57）
甘草干姜汤证案4例……（59）
射干麻黄汤加减证案5例……（62）
厚朴麻黄汤证案1例……（67）
麦门冬汤证案1例……（68）
葶苈大枣泻肺汤证案1例……（69）
桔梗汤加味证案1例……（71）
越婢加半夏汤证案1例……（72）
越婢加半夏汤加味证案1例……（73）
奔豚汤证案1例……（75）
括蒌薤白白酒汤证案1例……（75）
括蒌薤白半夏汤加味证案1例……（76）
橘枳生姜汤加味证案1例……（79）
乌头赤石脂丸加减证案1例……（81）
厚朴七物汤证案1例……（82）
附子粳米汤加味证案1例……（84）
厚朴三物汤加减证案1例……（85）
大建中汤加减证案2例……（86）
大黄附子汤证案1例……（87）
当归生姜羊肉汤加味证案1例……（88）

乌头桂枝汤证案1例……（89）
乌头桂枝汤加减证案1例……（90）
加味旋复花汤证案4例……（91）
肾着汤证案1例……（93）
苓桂术甘汤加味证案2例……（95）
甘遂半夏汤证案2例……（97）
十枣汤证案1例……（99）
术防己汤加茯苓证案1例……（100）
白术泽泻汤证案2例……（101）
己椒苈黄丸证案1例……（103）
小半夏加茯苓汤证案1例……（104）
苓甘五味姜辛半夏汤证案1例……（105）
括蒌瞿麦丸加味证案1例……（105）
蒲灰散证案1例……（106）
越婢加术汤证案1例……（107）
越婢加术汤法证案1例……（108）
茵陈蒿汤加味证案1例……（109）
茵陈五苓散加味证案1例……（111）
侧柏叶汤证案1例……（112）
黄土汤加味证案4例……（113）
半夏泻心汤加味证案1例……（116）
大半夏汤证案2例……（118）
橘皮竹茹汤加减证案2例……（119）
桃花汤加减证案4例……（121）
白头翁汤加减证案1例……（124）
大黄牡丹汤合薏苡附子败酱散证案3例……（125）

大黄牡丹汤证案4例……（128）
大黄牡丹汤加味证案4例……（130）
蜘蛛散证案1例……（132）
甘草粉蜜汤证案1例……（133）
桂枝茯苓丸加味证案4例……（133）
芎归胶艾汤加味证案4例……（139）
当归芍药散加味证案3例……（143）
干姜人参半夏丸证及加味证案5例……（147）
当归贝母苦参丸加味证案1例……（152）
竹叶汤加味证案1例……（153）
半夏厚朴汤证案1例……（154）
半夏厚朴汤加减证案5例……（155）
甘麦大枣汤证案6例……（158）
温经汤证案2例……（164）
温经汤加味证案2例……（166）
大黄甘遂汤证案1例……（168）
大黄甘遂汤合桂枝茯苓丸加减证案1例……（169）
肾气丸证案2例……（171）
肾气丸加骨碎补证案1例……（172）

《古方医案选编》下集
《千金》、《外台》方医案目录

（一）《千金》方医案

小续命汤加减证案2例……（174）
生脉散加味证案2例……（175）
生脉散合八味地黄汤证案1例……（177）
犀角地黄汤证案1例……（179）
犀角地黄汤加味证案2例……（180）
麦门冬汤证案1例……（181）
麦门冬汤加减证案1例……（182）
苇茎汤加味证案1例……（184）
苇茎汤合甘桔法证案2例……（185）
半夏茯苓汤减味证案1例……（187）
神秘汤加麻黄证案1例……（188）
温胆汤加味证案4例……（189）
温胆汤法证案1例……（192）
鲤鱼汤证案2例……（194）
备急丸证案4例……（199）
独活寄生汤证案3例……（202）
独活寄生汤加味证案1例……（203）
独活寄生汤加减证案2例……（205）
驻车丸证案2例……（209）

驻车丸加味证案1例……（210）
硝石丸证案1例……（211）
温脾汤证案4例……（212）
漏芦汤加减证案6例……（215）

（二）《外台》方医案

桔梗白散证案2例……（220）
茯苓饮加减证案2例……（222）
黄连解毒汤证案1例……（224）
黄连解毒汤加味证案3例……（225）
黄连解毒汤合普济消毒饮证案1例……（227）
解急蜀椒汤证案1例……（229）
秦皮汤加味证案1例……（230）

栝蒌桂枝汤证案

柔　　痉

丁××，男，半岁。

症状：1931年初夏，身热、汗出、口渴、目斜、项强、角弓反张、手足搐搦、指尖发冷、指纹浮紫、舌苔薄黄。

诊断：伤湿兼风，袭入太阳卫分，表虚液竭，筋脉失荣。

疗法：拟用调和阴阳、滋养营液法，以栝蒌桂枝汤主之。

处方：栝蒌根6克　桂枝　白芍各3克　甘草0.24克　生姜2片　红枣2枚　水煎服。

三剂各证减轻；改投：当归　川贝　秦艽各3克　生地　白芍　栝蒌根　忍冬藤各6克　水煎服，四剂而愈。

自按：风湿化热，血液被灼、筋脉失荣、成为柔痉。桂枝汤外证得之可以解肌和荣卫；内证得之可以补虚调阴阳。佐以栝蒌根之生津，所以取效迅速。录自（蒲园医案）

延按：栝蒌桂枝汤方见《金匮·痉湿暍病脉症》篇，案中身热、汗出，为桂枝汤主症，故用桂枝汤，半岁幼儿，因汗热口渴，病势已从热化，而致伤阴劫津，致呈现角弓反张、手足抽搐、项强、目斜等症状，故加栝蒌根以生津液，滋润筋脉。次诊用养血生津通络豁痰之品以善后，方药对症，所以收到良好效果。

葛根汤加味证案（二例）

刚　　痉

流行性脑脊髓膜炎，是西医的病名，但从其症状的表现，类似中医的痉病，按痉病由风引起，但风有内风和外风之别。内风多由温邪化火，内窜厥阴，迫动风阳；或由阴虚血少，木失涵养，肝风扇动，窜筋入络而成。外风多由太阳中风或重感寒湿，经脉痹阻所致；而风寒经久，每易热化。关于太阳中风的痉病，仲景又有刚痉柔痉之分。

痉病的病机：《素问·至真要大论》说："诸风掉眩，皆属于肝。诸痉项强，皆属于湿。诸暴强直，皆属于风。"指出了痉病一症，其病在肝，其因为风为湿。《金匮》又以恶寒无汗与汗出不恶寒的不同症状，分为刚痉柔痉，并指出了痉病有在表在里的不同，有偏太阳或阳明经的区别。……我们从治疗流行性脑脊髓膜炎的临床症状来看，与《金匮》的太阳中风，重感寒湿而发痉很相符合。……因此宗仲景法施治，均能获效。

治疗方法：

在临床诊断时，发现病属于风寒束表，卫阳被遏，兼之季节虽在三春，而阴雨连绵，气候寒冷似冬，与刚痉症状相符，因此以葛根汤为主方，每日夜服两剂，昏迷口噤者用鼻饲。一般在服药十小时之后，神识昏迷者转烦躁，由烦躁而

转清醒，面色由苍白转红润，此时阴症转阳，营卫得和，若药后能够得汗者，其效更速，无汗者清醒较慢；但得汗很不容易，剂量上须重用麻黄，再加羌、防，盖得汗之后，阳气通达，较易恢复。呕吐者加吴萸、半夏。在治疗过程中，症状消失最慢者是项强，所以葛根、桂枝在方中比较用得多。如果病症由阴转阳之后，有见动风之象，因入内之邪化热窜入经脉，就须加入平肝熄风之药。但此病变化多端，必须详细观察，随机应变，灵活施用。

典型病例：

1.宋林林，男，12岁，8月19日上午入院。家长代诉：患者昨夜突然起病，恶寒发热无汗，头痛剧烈，颈项强直，旋即昏迷不醒，入院时情况，面色灰白，目呆口噤，呕吐肢冷，脉紧而迟，舌润苔白，病由风寒袭于肌表，阳气阻遏于内，扰乱神明，邪犯太阳阳明经脉。

处方：麻黄　桂枝　葛根　生姜　甘草　羌活　藁本　半夏　桔红

服药一剂后，得微汗，身温肢和，昏迷转烦躁，面色转红润。

夜间处方：原方去桔红，加吴萸、莒卜、胆星。

3月20日，神志半醒，呕吐告止，口渴多饮，邪郁于里，将化为火，扰乱神明，而表邪未除，法宜疏邪于外，安神于内。

处方：麻黄　桂枝　葛根　白芍　甘草　半夏　莒卜　至宝丹

夜间处方：原方去至宝丹，加全蝎、枳实、菊花。

3月21日，烦躁已安，神志有时尚糊，口渴引饮，大便不解，脉搏细濡，外邪渐入于里，将转阳明府实证。

处方：葛根　羌活　菊花　半夏　胆星　全蝎　朱茯神　甘草　石决明　生军　芒硝

3月22日，大便解后，口渴已减，但神志有时尚糊，头痛项强仍然，腑实虽去，经脉未和，内邪引动肝阳，挟以痰浊，蒙蔽清宫，阻滞经络，转从平肝熄风，豁痰宁神。

处方：葛根　全蝎　地龙　勾藤　菊花　甘草　白芍　石决明　朱茯神　胆星　枳实

上方服两剂，神志完全清楚，头痛项强亦除，诸症消失，停药观察四天，精神恢复，化验室报告趋正常，于3月28日出院。

2.顾锡珍，女，11岁，3月19日上午，由双桥保健站转来。家长代诉：昨日突然发病，初起畏风无汗，头痛项强，即昏迷不醒，呕吐口噤。……诊断为脑膜炎，面色㿠白，四肢尚温，脉紧而细，舌苔白滑，克匿氏征（＋），巴宾氏征（＋），颈项强直，脑脊髓穿刺取液外观混浊，协同西医内科诊断，初步印象为流行性脑脊髓膜炎，中医诊断为刚痉。盖入春以来，阴雨连绵，气候寒冷，患儿感受寒邪，客于太阳阳明之经，阳气为之窒闭，治当从太阳阳明达邪。

处方：麻黄　桂枝　葛根　生姜　甘草　羌活　藁本　吴萸　半夏　全蝎　玉枢丹

服药后三小时，呕吐得止，昏迷转烦躁，而色转红润。

夜间处方：原方去半夏、吴萸、玉枢丹，加石决明、勾藤、菊花、菖卜、胆星。

3月20日，神志清醒，烦躁亦安，已能知饥欲食，但仍

头痛项强，风邪窜入筋脉，再从效方踪进。

原方去石决明、加白芍。

3月21日，头项强痛已除，其它症状消失，知饥欲食，行动谈笑自如，停药观察，3月25日治愈出院。

结　　语

用葛根汤治刚痉，乃系《金匮》法则，本无报导价值，但是对流行性脑脊髓膜炎的中医治疗，无分阴阳，一般初起便采用平肝熄风者为多，用辛温法治疗者殊少。我们根据当时流行病的类型和气候情况，以及病人所表现的症状脉象和舌苔，属于阴寒，采用葛根汤治疗后，收到良效，这是中医辩证论治的优点，……所以介绍出来。录自（《江苏中医》1964，11，“用葛根汤治疗流脑的临床介绍”。许良培）

延按：本案运用葛根汤为主治疗刚痉，这种实践经验很好，足资启发。但本方用治外感寒湿致痉较合宜。若病郁久化热，或兼痰热蒙蔽窍隧，则应在本方基础上加入清热息风豁痰宣窍药品。案中治例即在中医辩证论治理论的指导下来立法处方而获得治疗效果的。关于伤寒发痉与温热发痉之鉴别，《温热经纬》湿热病篇中论痉条后的注释，谈得非常明白晓畅，值得一读。前辈医家徐洄溪认为金匮治痉诸方，后世用之见效绝少，当系指温热发痉而言，所以医者应掌握辩症规律和气候变化，石家庄治疗“乙脑”经验，用于北京即不见效，亦同此理。

大承气汤证案

痉　病

里海辛村潘塾师之女，八九岁。发热面赤，角弓反张，谵语，以为鬼物。符录无灵，乃延余诊。见以鱼网蒙面，白刃拍桌，而患童无惧容。予曰：此痉病也。非魅！切勿以此相恐，否则重添惊疾矣。投以大承气汤，即下两三次，病遂霍然。

按：“痉以强急得名，乃脑脊髓膜炎、破伤风诸病而言，《巢源》、《千金》，所载可考也。千金云：太阳中风，重感于寒湿，则变痉也。痉者，口噤不开，背强而直，如发痫之状，摇头马鸣，腰反折。案千金所云：为脑脊髓膜炎破伤风共有之症。惟脑脊髓膜炎初起即恶寒发热，故千金冠以太阳中风。”（金匮要略今释卷一）录自1958,7，《广东中医》（36）庇留医案）

延按：大承气汤，本治阳明府实之峻下方剂。金匮用之以治里实的发痉。良由热盛劫烁津液，不能濡养筋脉，形成角弓反张，四肢挛急，较一般痉病为剧烈，故又称为剧痉。《金匮·痉湿暍病脉症治》篇：“痉为病，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必齘齿，可与大承气汤。”案中所述主要症状，与金匮条文基本相符，都由里实热盛所致，用本方为釜底抽薪之法，所以服药后下两三次，病即告愈。

麻黄加术汤证案

伤湿兼寒

黄君，年卅余。素因体肥多湿，现因受寒而发，医药杂投无效，改延余诊。其症手脚迟重，遍身酸痛，口中淡，不欲食，懒言语，终日危坐。诊脉右缓左紧，舌苔白腻，此《金匮》所谓湿家身烦疼，可与麻黄加术汤也(注)。遵经方以表达之，使寒湿悉从微汗而解。

处方：带节麻黄2.4克，桂枝2.1克，光杏仁4.5克，炙甘草1.5克，苍术3克，连投二剂，诸症悉平而愈。

注：《金匮，痉湿暍病脉症》

麻按：此为湿之属表无汗者而设，盖麻黄得术，虽发汗而不为多汗，术得麻黄，行里湿而并可行表湿，止此一味加入，所谓方外之神方，法中之良法也，宜其一方即愈。录自《金国名医验案类编·萧琢如》

延按：考原方中之术系白术，且剂量较重，是只取微汗以去病之意。本案是用的苍术，加入麻黄汤中，则发汗之力较峻，其所以如此用药，想系根据其舌脉，而知患者为寒湿素盛之体质。如果其人寒湿不重，似仍以用白术为宜。

麻杏薏甘汤加味证案

风湿热痹

农人汤瑞生，年40。夙患风湿关节病。每届严冬辄发，今冬重伤风寒，复发尤剧。证见发热恶寒，无汗咳嗽，下肢沉重疼痛，腓肌不时抽掣，日晡增剧，卧床不能起，舌苔白厚而燥。但从病情观察，则以风湿之成分居多，且内郁既久，渐有化热趋向，而不应以严冬视为寒重也。法当解表宣肺，清热利湿，舒筋活络，以遏止转化之势。此证风湿已渐化热，当用麻杏薏甘汤为对证，再加苍术、黄柏、忍冬藤、木通以清热燥湿疏络则比较清和，且效力大而更全面。上方服三帖，汗出热清痛减，再于原方去麻黄、加牛夕、丹乡、络石藤之属，并加重其剂量，专力祛湿通络。日服二帖，三日痛全止，能起床行动，食增神旺。继进行血益气药，一月遂得平复。录自《赵守真治验回忆录》

延按：观此案可见运用古方如能化裁得法，更可增强疗效。初方为麻杏薏甘汤合二妙散加银花芏、木通，考张锡纯《衷中参西录》木通解下，谓一味木通汤治痛痹有效。次方去麻黄之走表，加入通络活血去瘀之牛夕、丹乡、络石芏，以病久势将由气及血也。

越婢汤合防己黄芪汤加减证案

风水水肿

郭××，男，成年。1971年2月3日初诊：脸肿恶风，咳嗽身痛，左肋痛，脉浮微数，舌上有黑苔。此内有水气，表虚为风所乘，宜从风水论治，用越婢汤加减。

麻黄6克　黄芪12克　防已9克　杏仁9克　生姜2片　大枣3枚　甘草3克　三剂

2月13日二诊：服上方三剂后，诸症缓解，后因又伤风邪，恶风咳嗽之症又发，且兼全身浮肿，手指关节，亦微肿胀，咳嗽时牵引左肋作痛，牙痛，食少，腹胀，脉浮，舌上苔黄，此风邪乘肺，水湿化热之征。用越婢合防已黄芪汤加减。

麻黄6克　石羔15克　白术9克　黄芪12克　厚朴9克　杏仁9克　生姜2片　大枣3枚　甘草3克　四剂

2月19日三诊：身肿已消，畏风，咳嗽，肋痛，牙痛亦解，饮食增进。目前尚余咽痛，脸微肿，腹胀，指关节痛。脉已不浮，舌上有黄腻苔，是湿热未尽之象，用开泄兼清利法以善其后。银花　连翘　板兰根　豆卷　杏仁　厚朴各9克　桔梗　木通各6克　刺蒺藜　金铃炭各12克　桑枝30克　甘草3克　四剂

按：《金匮·水气病脉症并治》说："风水其脉自浮，外症骨节疼痛恶风。""风水恶风一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热者，越婢汤主之。""风水，脉浮身重，汗

出恶风者，防己黄芪汤主之。”本例恶风，脸肿，肋，身痛，手指关节疼痛肿胀，脉浮等，显系风水见症。此症由于外受风寒，内有水气所致，故用越婢合防已黄芪汤而奏效。咳嗽者，外受风寒也，舌上黑苔者，水气也。故初诊以麻黄、杏仁发散风寒兼以止咳，用防已以渗水气，用黄芪以固表虚，姜、枣、甘草和中补脾，故诸症因之缓解。由于邪尚未尽，复受风邪，风为阳邪，使水湿蕴热，不但原症复发，且出现牙痛食少腹胀，苔黄等湿热之症。故二诊时，在原方基础上，加石羔以清热，白术以燥湿，厚朴行脾以消腹胀，使诸症又得好转。三诊时，从现症咽痛脸微肿腹胀，指关节痛，脉不浮，舌苔黄腻等观察，是风水之邪已不甚重，而内蕴湿热之邪尚不了了，故用银花、桔梗以开之，刺蒺藜、金铃炭以疏之，杏仁、厚朴以降之。用连翘、板兰根以清热，豆卷、桑枝、木通以利湿，由是而湿热之邪得解，风邪亦得宁息。录自（《李斯炽医案》第一辑）

延按：李老案中初诊时，因有表虚之恶风，水气不化之苔黑脸肿，但无内热壅阻迹象。故于越婢汤中去石羔之寒，而加黄芪、防已之补卫固表，利水除湿，因兼咳嗽，故加杏仁，此体现随症加药之法。二诊：诸症虽得缓解，但有牙痛，腹胀气阻热壅现象，故于方中加石羔、以清热，厚朴以消胀，用以运转芪、术之滞气助火，因咳嗽未减，故不去杏仁，如此标本兼顾，深得古方化裁之妙。三诊：出现咽痛、腹胀，舌苔黄腻等，是水湿郁久化热，阻滞气机，故采用叶、薛二氏开泄清利之法（叶天士外感温热篇有，“或透风于热外，或渗湿于热下”、“胃中宿滞挟浊秽郁伏，当急急开泄”，薛生白湿热病篇有“曾开泄下夺”。之语）以善

后。可见内伤杂病与温热病治法，本可相互勾通，应该灵活掌握，正不必机械地把它截然划分。

甘草附子汤证案

风湿相抟

高汉章，得风湿病，遍身骨节疼痛，手不可触，近之则痛甚，微汗自出，小水不利，时当初夏，自汉返舟求治，见其身面手足俱有微肿，且天气颇热，尚重裘不脱，脉象颇大，而气不相续。其戚友满座，问是何证。予曰：此风湿为病，渠曰：凡驱风利湿之药，服之多矣，不惟无益，而反增重。答曰：夫风本外邪，当从表治，但尊体表虚，何敢发汗；又湿本内邪，须从里治，而尊体里虚，岂敢利水乎。当遵仲景法，处甘草附子汤，（甘草　附子　桂枝　白术），一剂如神，服至三剂，诸症悉愈。录自《谢映庐医案》

延按：本方一见于《伤寒论》太阳篇下180条，一见于《金匮，痉湿暍病脉症》，本证既属风湿相抟，余意应在《金匮》中论述。案中述列症状，与条文所载基本相符，所以用之获效。

白虎加人参汤证案（二例）

热渴伤津

《金匮·痉湿暍病脉症》篇："太阳中热者，暍是也。汗出恶寒，身热而渴，白虎加人参汤主之。"按人参方书认为有"益气生津"作用，吉益东洞谓："人参主治心下痞坚痞硬支结也……（见《药征》）

汤本求真对于白虎加参汤，更有以下见解，并可参考："本方（指白虎加参汤。笔者），之用途，虽无不明，然与白虎汤之区别，尚难判然，故宜参照吉益东洞以本方为治白虎汤证而心下痞硬者之定义。学者能深究此说与师论，则本方可应用矣。"见（《皇汉医学》）

笔者综合以上诸说，以白虎加参汤用治白虎汤证而汗出多，渴、饮程度均强者。临床上心下痞硬"证，亦作为一定参考条件来掌握使用的。兹举大热汗出渴饮并剧的病案一例于下：

1.杨××，男，32岁，公社社员，1963年9月2日出诊。病人体质营养良好，发病已三日，发热，体温39.8℃，大汗，口渴饮冷，皮肤湿润灼热，口干舌燥。主诉：烦热，有轻度恶风，脉见滑数兼芤，心下痞，为处白虎加人参汤，次日体温正常，有头痛口渴，续服前方二日，数日后随访，言服药二日后已复常。

《金匮要略·消渴篇》："渴欲饮水，口干舌燥者，白

虎加人参汤主之。”此种患者体温既属正常，或仅有热感，无大热、大汗等症状，脉象当然也不会出现像上述急性热病那样典型的洪大滑数。笔者这时仅根据患者异常的“口干”及强烈的“渴”感和大量饮水等证候，遵照《金匮》条文指示作为用方目标。

“阳明内热”证的急性高热病人，小便当然少；但在消渴病人，小便次数多，尿量多时应用本方亦无妨。此时病人多近于常脉，或呈比较的洪大滑实的脉；而有时只要不是沉细、沉迟无力，即可应用本方。

2.周××，男，39岁，农民，1963年10月4日住院。发病已两月余，现病史为口渴多饮逐渐加重，有难忍的饥饿感，食量增多，倍于常人，饮水量住院时一昼夜达15磅，尿多，体容削瘦，面色红润，眼光有神充血，左侧下颌部有已愈疮痕一处，凹陷一厘米，脉诊近于正常，细审稍洪有力，精神焦虑，有疲劳感，心下痞硬。为处白虎加人参汤五日量，从开始限制食量为每餐软米饭一大碗（米重150克），未作严格食疗，三日后渴减，饮水量相应减少，一周后在限制食量下已无饥感，以后，渴、饮、尿量续减，续服前方一个月，自觉症状接近消失，出院后，惜其未能坚持服药，五个月后随访，劳动力仍未恢复。

结　语

白虎汤及白虎加人参汤的应用是多方面的，尽管它在“证”的表现上有如何的不尽一致，但是，它的病理是相同的，只有“内热”一个。研究本方证时，如果能通过临床现象，掌握这个本质，灵活、巧妙而又是有原则的来使用它，

它是能够解决很多疾病的，而其“证”的表现，当然不限于以上所论。笔者仅不过是结合个人实践心得，择平素所常见的略作粗论而已。录自（《中医杂志》1964年第11期“白虎汤及白虎加人参汤临床运用体会。”雷声）

延按：白虎汤，白虎加人参汤，同为清法方剂，用白虎汤要点，在里热未实，表寒已解。（见《伤寒论类方汇参》白虎汤类），用白虎加参汤要点，在于内热过盛，热盛伤津耗气，故于白虎汤加参以益气泻热生津止渴。案中两例治法，都本金匮条文并参考日本医家意见来处方用药的。因为运用得当，所以能收到治疗效果。

百合地黄汤加减证案（四例）

1.百合病

张石顽治内翰孟端士之母，虚火不时上升，自汗不止，心神恍惚，欲食不能食，欲卧不能卧，口苦小便难，溺则洒淅头晕，凡医每用一药，辄增一病。……时时欲人扶掖而走，惟日用人参钱许，入粥饮和服，聊藉支撑。交春虚火倍剧，火气一升，则周身大汗，神气骎骎欲脱，惟倦极少寐，则汗不出而神气稍甯。觉后少顷，火气复升，汗亦随至，较之盗汗迥殊。诊之其脉微数，而左尺与左寸倍于他部，气口按之似有似无，此本平时思虑伤脾，脾阴受困，而厥阳之火，尽归于心，扰其百脉致病，病名百合。此证惟仲景《金匮》言之甚详，原云诸药不能治，所以每服一药，辄增一病，惟百合

地黄汤为之专药。奈病久中气亏乏，复经药误而成坏病，姑用生脉散，加百合、茯苓、龙齿以安其神，稍兼黄、连以折其势，数剂少安，即令勿服以养胃气，但令日用鲜百合煮汤服之。交秋天气下降，火气渐伏，可保无虞，迨至仲秋，果勿药而愈。录自《名医类案》

延按：本案与《金匮，百合狐惑阴阳毒病症治》所述脉症基本相符，意拟用百合地黄汤主治，但考虑患者病久中虚，复经如许药误，所以仅师其法而不尽用全方，并针对病情而增入对症之药。迨病势稍衰，即专与一味百合以清养，复借天时之助而病始瘳。

又按：陆渊雷氏在其所注《金匮要略今释》一书中说："本病以百合地黄汤为正治方，并认为医药多起于单方，单方多病人所自发明，病后神经衰弱者，偶食百合而愈，传之同病，屡试辄验，于是确定百合能治此病，病状既恍惚难名，乃以药名名之为百合病耳。又说：百合病医案，所见甚少，石顽此案，亦未以百合竟全功，录之以备参考而已。"

2.百合病

詹龙臣，高邮人，为某厂之劳动工友。1954年6月6日初诊：劳工苦力伤气，加以病后失调，正元难复，消化则影响胃肠，喘息则累及肺脏，久久未愈，其间时轻时重，洵至神经衰弱，心绪不宁，坐卧失序，一如金匮百合病篇之所述，惟多一音哑，为金匮所未有，且知为用钩虫下药，而有此症，经用百合地黄汤加味，拟方缓以图之，屏去思虑，先以精神疗法坚其信心，乃可有为。

处方：蒸百合　怀山药各12克　生地黄15克　带皮芪

（蜜炙） 云茯苓 大麦冬各9克 红枣10枚 陈小麦30克（先煎）

1954年6月27日二诊：前进百合地黄汤加味之方，渐有向愈之机，饮食较多，声音微响，面色亦较佳。惟大便干燥，此津液未复之故。

处方：蒸百合 生地黄各12克 带皮芪 柏子仁 怀山药 空沙参 大麦冬各9克 陈小麦30克（先煎）

1954年7月23日三诊：进剂渐见好转，面色较华，步履亦较健，惟声音尚未全复，近日来舌苔稍厚，中夹浊滞，致大便仍觉不爽。

处方：空沙参 带皮苓 肥知母 怀山药 火麻仁 炒白术 大麦冬 杏仁泥各9克 带皮芪（蜜炙）6克（按）此时新百合已上市，即令其日以百合煮烂，加糖食之，早晚各一次，故方中未用蒸百合。

1954年8月7日四诊：原为久病神经衰弱，经治之大见进步，惟近数日来，天气炎热，新秋尚有暑热之邪，胸中烦热闷塞，治当舍本治标。

处方：香薷6克 槟榔 福曲 藿香 姜皮 苏梗 花粉各9克 制夏7.5克 生姜2片 竹叶40片 叩仁4.5克 此方连服三帖，新感邪去，仍接服第三方，至十月初，而病愈音复。

厂中见其病已痊愈，促其早日上工，病者犹有惧心，询之于予，予令其再休养一二月，厂方疑其狡猾，复令就厂医诊之，为之证明，乃为有效。讵厂医检验，仍谓其有钩虫，再度令服杀钩虫及泻下之药，一服之下，泻下四次，而前症复作，音亦复哑。……复求予诊，予觉再度反复，不同前

症，在无可奈何中，仍用前精神疗法，使病者去其惧心，再为之处方，依前加减，令其安心服之，迨服之既久，亦即缓缓收效，又凡三易其方，而渐全愈。

再治全案

1955年2月14日初诊：客年重笃之百合病，即神经衰弱证，久病不愈，经用百合地黄汤加味方，渐见好转，约四阅月而愈。惟久病体弱，正元尚未十分恢复，近以他医谓有钩虫，用杀虫药及下药，病又反复如初，又变失音。拟方再求合辙，惟一再药误，恐较前为难治耳。

处方：蒸百合　生地黄各12克　大麦冬　朱茯苓　带皮芪（蜜炙）　酸枣仁各9克　远志肉7.5克　陈小麦30克（先煎）

1955年2月29日二诊：进剂幸渐转平，夜眠亦较佳，饮食亦较多。惟两腿尚觉无力，大便软溏，喉音未复，拟方再求进步，仍宜屏去思虑，事事乐天，则更易见功。

处方：蒸百合　生地黄各12克　空沙参　补骨脂　淡玉竹　酸枣仁　朱茯苓　带皮芪（蜜炙）各9克　远志肉7.5克　陈小麦30克（先煎）

〔按〕此方连服至四月底，体渐复元，喉音渐响，至五月中旬，音亦完全复旧。录自（余无言《翼经经验录》）

延按：王孟英先生在其《温热经纬》仲景疫病篇百合病条下，雄按："此病仲景以百合主治，即以百合名其病，其实余热逗留肺经之证，凡温暑湿热诸病后皆有之，不止疫也。肺主魄，魄不安，则如有神灵，肺失肃清，则小便赤，百合功专清肺，故以为君也。忆辛丑暮春，于役兰溪，在严

州州次，见一女子患此症，其父母以为祟也，余询其起于时症之后，察其脉数，第百合无觅处，遂以苇茎、麦冬、丝瓜子、冬瓜皮、知母为方，服之一剂知，二剂已。”观此则百合病应以治肺为主，得孟英先生的阐述和通过其治验证明，更使人心目了然。

3.百合病

一、林××，女，30余岁，莆田人，农民。于暑期内患热性病20余天，初经西医治疗已热退病除，但觉神疲无力，精神倦怠，数日后渐觉精神冲动，兴奋知觉过敏，对事怀疑，对人恐惧常误解人语，口渴，小便短赤，大便秘结，头痛，心悸不宁，视力不清，喜静畏烦，食欲不振，饮食无味，日渐加剧，甚至自笑自语，时歌时泣。有时言语行动自若，如常人。检查身无寒热（37.3℃），脉数而软（五至余），唇焦舌红，津液缺乏，营养不良，精神憔悴，卧床不起。

治疗经过：第一次处方：百合15克，滑石18克，生地24克，玉竹9克，寸冬15克，石决明9克，苡仁15克，用水连煎两次，混合后分三次服，每三小时一次，一昼夜连服三剂，另以苡仁、苇根、天花粉等药煎汤频服。第一次服药后数分钟即吐出，后俟其口渴索饮时给药，遂不吐，次日复诊神气已清，小便亦长，诸症均减退，惟食欲不振，倦怠嗜卧。仍照原方去生地、滑石、石决明，各药分量亦减轻，再加生谷芽、淮山药，每日一剂，连服三日，已能下床行走，并嘱再用地瓜粉、百合粉、牛乳等清凉滋养之品为调养饮料，很快恢复健康。

二，林××，男，莆田人，20余岁，农民。患者于夏秋之际，患热性病如肠伤寒状，因家内乏人照料，未延医治，迁延月余，始得渐愈，愈后自能照常劳动，惟渴不除，小便仍赤，饮食无味。一日突然悲哭不休，继即精神错乱，胡言乱语，时发愤怒，撕破衣襟，有时欢笑，歌声清朗，有时默然不语，状如痴呆，有时辗转反复，状如虚烦，有时神志清晰，似无病时，经过十余天，大便闭，意识不清，脉数而虚，舌红津干。

治疗：初诊处方：百合18克，知母9克，生地、麦冬各24克，元参、滑石各18克，竹叶9克，牡蛎、天花粉各15克，石决明12克，玉竹9克，水煎二次，混合后分三次服，四小时一次，日服一剂。另用鲜芋根、苡仁、天花粉等品煎水，稍加冰糖置于床侧，任其自饮。

复诊：病减，口不甚渴，诊时对答清楚，但默默然呈无欲状态，意似疲劳，体温正常，脉搏数亦减，小便较长还带赤，舌上津回，大便未下。

二天复诊处方：照前方略有加减，百合、生地、麦冬各15克，元参、竹叶、玉竹、石决明各9克，水煎，服法同前，连服三天。

四天复诊，诸病均除，惟尚有微咳，食欲未复，大便仍闭，改用益胃汤加味。

处方：沙参、百合各9克，麦冬、生地各15克，玉竹6克，石斛9克，水煎后，加蜜一两，分二次服。服后自早至晚相继下结粪三次，完全痊愈。录自（福建中医药1958年10月，“二例百合病治验简介”，林善星）

延按：本案两例所述主要症状，均与《金匮》百合病基

本相符。例一，第一次处方，系百合地黄汤，百合滑石散合方，加入清养肺气药品，因食欲不振，换方加入甘淡实脾，健胃生津之淮药、生谷芽，并用清凉滋养食品以调理善后因之获愈。例二，初诊处方为百合地黄汤，百合知母汤，百合滑石散，括蒌牡蛎散四方合用，再加以清养肺胃药品。最后用益胃汤加味以恢复胃肠津液，故药后因结粪畅行而告全愈。观此治案足以证明王孟英医学前辈所说余热逗留肺经以清肺为主的见解，是信而有征的。

甘草泻心汤加减证案（二例）

狐　惑

1.焦　×，女，41岁，干部，1962年6月初诊。患者于廿年前因在狱中居处潮湿得病，发冷发烧，关节疼痛，目赤，视物不清，皮肤起有大小不等之硬斑，口腔、前阴、肛门均见溃疡。廿年来，时轻时重，缠绵不愈。近来月经先期，色紫有块，有黄白带，五心烦热，失眠，咽干，声嗄，手足指趾硬斑，日久已呈角化，肛门周围及直肠溃疡严重，不能正坐，口腔粘膜及舌面也有溃疡，满舌白如粉霜，便干结，小溲短黄，脉滑数。诊断为狐惑病，即予治惑丸、甘草泻心汤加减内服，苦参煎水熏洗前阴，并以雄黄粉熏肛。肛门熏后，见有蕈状物突出肛外，奇痒难忍，用苦参汤洗涤后，渐即收回。服药期间，大便排出恶臭粘液多量，阴

道也有多量带状浊液排出，病情日有起色，四肢角化硬斑亦渐消失。治疗四个月后，诸症消失，经停药观察一年余，未见复发。

2.夏××，男，30岁，干部，1961年8月17日初诊。患者自1959年以来，时有发烧。1959年下半年舌尖发现溃疡，1960年3月阴囊发现溃疡，渐觉目赤、视力减退、四肢皮肤有结节性硬斑，历经治疗均属无效，在外院诊断为白塞氏综合症。诊见面色黑暗（据云病后始见此色），口腔粘膜有米粒至黄豆大之凹陷型溃疡，上有伪膜复盖，易剥落，并有白色分泌物，咽干、舌白，皮肤有多型性硬斑，目赤，视物不清（西医诊为前房积脓），阴囊有黄豆大之溃疡二处，阴茎亦有绿豆大之溃疡二处，其上均有白色分泌物渗出。诊断为狐惑病，即予甘草泻心汤加减及治惑丸、石斛夜光丸内服，并以苦参水熏洗阴部，雄黄熏肛外治。药后大便排出多量粘液。同年8月31日检查，前房积浓吸收，视力好转。同年10月14日溃疡均告消失，皮肤红斑消退，迄今未见复发。

诊断依据

本病为一综合症候群，在诊断上主要依靠症状观察，常见症状如下：

1.喉、舌、牙龈、口腔粘膜溃疡：本病初起，溃疡多在舌之底面，或唇颊粘膜、牙龈等处，重者满舌皆白腐，悬雍垂亦可累及。

2.前阴溃疡：常发部位为妇女大小阴唇、男子阴茎、龟头、肾囊等处。疮面凹陷，大小不等，上被伪膜，易脱落，

局部疼痛或肿痛。梅毒血清反应概属阴性，亦非梅毒、下疳所致。

3.肛门粘膜溃疡：有的直肠末端溃疡，突出肛外；有的肛门周围及会阴部等处溃疡，无瘘管。

4.眼部症状：初起即见眼症状的比较少见，多发生在迁延不愈反复发作二、三年以后患者。临床表现有目赤、云翳肿痛等，视力亦随之而损害；也有只觉视力减退者。如或失治，多至瞎盲。

5.恶寒发热、关节疼痛：本病虽发冷发热、关节疼痛，但项不强、脉不浮紧、不为汗解，易与伤寒鉴别。脉至可数，但临床也有脉虽数而身无热，或虽身热而脉不数者。关节疼痛常多见于膝、踝与腕关节等处。

6.皮肤损害：皮肤症状大致可归纳为四个方面：①呈结节性硬斑状，多见于四肢。暗紫色，大如黄豆或蚕豆，按之硬而疼痛，不化脓；②呈角化性结节性硬斑状，常见于四肢手足肘关节等处，坚硬呈角质状，不化脓；③呈结节性化脓性斑状，多发于面唇、背部，易化脓渗液；④呈粟粒型结节性红斑状，多见于腋下、鼠蹊部及胸肋部，呈粟粒样片状，红赤痒痛，亦不化脓。此外，本病于针灸或注射针眼处，恒有发炎或化脓表现，是为本病之特征。

7.其它症状：如面色易有异样改变，在病情严重时常可见之；口干为常有之症状；它如汗出、卧起不安或默默欲眠、声音嘶哑、口鼻出气灼热、恶心厌食、心烦失眠等，均可见之。

以上口腔溃疡、前阴或肛门溃疡、发冷发热、皮肤损害等为本病之主症，结合持续呈周期性增剧及缓解而无真正完

全消失症状的病史特点，即可确诊。

治疗方法

分内服外治两方面：

1.内服方药

①**甘草泻心汤**（《金匮要略》方）：生甘草、黄芩、干姜、人参、制半夏、黄连、大枣。不欲饮食加佩兰12克；喉咽溃疡加升麻4、5、广犀角3克；口渴去半夏加花粉15克；目赤加赤芍、夜明砂各9克；口鼻出气灼热加生石羔30至60克、知母15克；胸肋满痛加柴胡9克；湿偏胜加赤苓、木通各9克；热偏胜以生姜易干姜；便秘加酒川军9克；五心烦热加胡黄连6至9克。

本方为治本病之主药，方中以甘草甘平泻火为主，而且量须大，一般用18到36克，生、炙各半。伍以连、芩之苦寒清热，除湿解毒；姜、夏之辛燥，开阴凝而祛湿；参、枣甘平佐甘草扶正祛邪，具有清热解毒，化湿扶正之功效。至加减药味，应随症参伍，灵活掌握。

②**治癥丸**（自拟验方）：槐实、苦参各60克，芦荟30克，干漆（炒令烟尽）0.18克，广木香、桃仁（炒微黄）各60克，青箱子、明雄黄（飞）、广犀角各30克。上九味，共研极细末，泛水为小丸，滑石为衣，每服3至6克，每日二至三次。

本方系以苦参、槐实、芦荟为主药。以肝为厥阴之脏，木为生火之原，以其湿热蕴蒸，故投此三药直入厥阴以清其

源，兼以燥湿凉血、清瘀化滞。方中伍以干漆以逐肠胃有形之积；桃仁破血行滞；青葙子清肝明目；犀角清心除烦；雄黄辟邪解毒；并以木香之行气通滞，统领诸药而竟其功，具有清热祛湿、杀虫解毒之效，为治本病不可缺少之药。服药期间，忌食大蒜、猪头肉、无鳞鱼。

甘草泻心汤与治惑丸二者合用，可以提高疗效。作者经验，服用治惑丸后，病者常有轻度腹痛，随后由大便排出大量粘液便，妇女或由前阴排出浊液，或白粘如带，或乌褐如血，诸症亦常随之而轻解（见病案1）

2.外用药物：

①**苦参汤**（《金匮要略》方）：苦参30克，水煎，外洗用。

苦参苦寒无毒，入少阴、厥阴经，功擅泻火燥湿，治前阴溃疡，每日洗之；如有阴痒，加蛇床子15克，同煎洗之。

②**雄黄散**（《金匮要略》方）：雄黄9克，研末，烧令熏肛用。

雄黄性温，长于杀虫解毒。但雄黄粉不能燃着，须用艾叶作团，将雄黄粉撒于其上，然后用一铁筒将火罩住，令患者蹲坐其上，针对肛门溃疡处熏之。熏前必须将肛门洗净，熏后保持局部清洁。每日三、四次。

本病过去认为是临床罕见病例，据作者三年来的观察，本病发病率并不很低。与现代医学之白塞氏综合症颇相近似。三年来，有些病例曾在外院诊断为白塞氏综合症而转来求治，统按治狐惑病法治疗，颇有效验，如本文病案2，即为近期痊愈一例。录自（1963年第11期《中医杂志》“狐惑

病的治疗经验介绍”。王子和）

延按：本案所叙述一系列症状，与《金匮·百合狐惑阴阳毒病症治》篇内容基本相符，治疗方药亦以《金匮》为依据，因其病情有变化，故内服方药有加减，并自制治惑丸配服以提高疗效。至其结合现代医学的诊断用中医方法处理，对于中西医结合进行临床研究，亦颇有参考价值。

升麻鳖甲汤加味证案

虚性紫癜

江××，女，54岁，月经仍有来潮，但一年多来先后无定，来时淋漓甚则崩漏，经期每每持续十余天，于1972年春，发生过鼻衄、齿衄2次，继而发现皮下出血，以四肢为多，躯干较少，小如钉帽，大如银元。经西医诊断为血小板减少性紫癜，先后采用中西药物治疗三个多月，疗效不显，紫癜反复出现。来我院就诊时，患者皮下多处出血，两大腿内侧紫斑更甚，右侧一处斑块约半手掌大，色泽青紫而皮质硬。

主诉：头眩心悸，经常失眠，腰酸如折、四肢酸楚，甚则抽筋。观其面色白而无华，舌质淡而胖润，脉象细弱，诊为虚性紫斑。拟方升麻鳖甲汤加味。

处方：当归　升麻　鳖甲　炙甘草　白芍　熟地　阿胶　丹皮　服2剂后，患者感觉症情好转，再服2剂，数天后复

诊，右大腿内侧最大紫斑已软化消退一半，诸症也显明好转。但脉象仍沉弱，按上方去丹皮，加参、术出入数剂，治疗半月，紫癜消沉，经血比前大减，经期明显缩短，皮下仅见针尖大血点少许，头眩心悸亦减，夜能入睡，腰肢酸楚好转，脉象较前有力。为调其善后，宗上方合归脾丸加减化裁制蜜丸一服。处方：当归　升麻　鳖甲　炙草　党参　黄芪　白术　茯苓　枣仁　元肉　龟版　女贞子　阿胶　后经多次追踪观察，紫癜未见复发，月经正常，已照常参加劳动。

原案后结语：本例系肝不藏血，脾不统血，致血不能归入经隧，形成屡屡崩漏不止，患者既经失血于前，今又出现紫斑于后，结合脉症，断为虚性紫斑，故以调补肝脾，益气摄血而奏效。录自（《新中医》1973年4期，刘树鉴、江惠芝整理）

延按：升麻鳖甲汤方见《金匮·百合狐惑阴阳毒病症治》篇中，药品组成：升麻　鳖甲　当归　甘草　雄黄　蜀椒等六味。治感受毒厉之气蕴于血脉而致的阴阳毒，方中升麻、甘草解毒、鳖甲、当归逐瘀行血，雄黄、蜀椒为解毒杀虫之峻药，本案借用此方，仅取升麻、甘草、当归、鳖甲四味以解毒逐瘀行血，加白芍、熟地、阿胶、丹皮于补血之中兼凉血，俟症情好转，脉仍沉弱，即去丹皮之凉血，加入参、术之补气，善后用本方合峻补气血药收功。用药进退得法，处处针对病情，师古而不泥古，可称善治。案中不用雄黄、蜀椒者，以本病属气血虚损所导致，治法重在益气摄血，所以不需此类猛峻药物，避免耗伤正气也。

鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸证案（二例）

肝脾肿大

本人于1956年7月参加了上海支援浙江防治血吸虫病医疗工作，三个月中，曾采用金匮鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸治疗晚期血吸虫病，治疗后患者一般症状及体征均有明显改善，从而创造了锑剂治疗条件。

典型病例

1.陈××，女，45岁，农民。

主诉：自知腹部痞块已有一年多，腹胀时痛，食欲减退。

病史：患者为乡间农民，经常有河水接触史，一年前发觉腹内有痞块，逐渐增大，食后每感腹胀不舒，时有腹痛，大便带脓血，里急后重，一日3—6次不等，半年来精神逐渐疲乏，劳动力渐显著减退，无呕血、吐血、黑粪史。

体检：发育完全，营养不良，面容萎黄，皮肤干燥，听诊在二尖瓣区有Ⅱ级收缩期吹风样什音，腹软，肝肿在剑突下6公分，边缘整齐，表面平滑，质软有轻度压痛，脾肿大在左侧乳头腹肋下9公分，坚度中等，有压痛，腹壁静脉不显露，无转移性浊音。

化验：血色素56%，赤血球295万，白血球4.500，中性细胞58%，淋巴细胞24%，酸性细胞16%，单核细胞2%，

大便孵化毛蚴阳性。

治疗效果：6月28日开始服药，药后12天，检查脾肿在左侧乳头腺肋下3.5公分，较服药前缩小5.5公分，肝肿完全消失，患者一般情况好转，食欲增加，食后胀闷消失，大便恢复正常，7月10日转入锑剂治疗，按期按量结束疗程，于7月27日出院。

2.朱××，女，24岁，农民。

主诉：食后上腹胀闷，大便带脓血年余。

病史：患者为乡间农民，经常有河水接触史，一年前即觉上腹部有块，食后胀闷，有时大便带脓血，里急后重，便次增多，一日2—4次不等，间或伴有发热，无荨麻疹史，半年来精神疲乏，劳动力显著减退。

体检：营养不良，贫血面容，心肺阴性，肝肿剑突下13公分，压痛显著，硬度中等，边缘整齐，表面平滑无结节，脾脏未扪及。

化验：血色素78%，赤血球410万，白血球7,000，中性细胞58%，淋巴细胞28%，酸性细胞14%，大便孵化毛蚴阳性。

治疗效果：7月10日开始服药，16天后，检查肝肿软化缩小在剑突下11公分，压痛减轻、腹痛便脓血消失，食欲增加，无胀闷不适，精神转佳，于7月27日转入锑剂治疗，三日疗法，按期按量结束疗程，于8月4日出院。

药物、剂量及服法

（一）金匮鳖甲煎丸（照古方稍有改变）

鳖甲54克　人参　葶苈子各3克　黄芩　厚朴　石苇各9克　丹皮15克　蜂房12克　朴硝36克　射干　阿胶　干姜　大黄　桂枝　鼠妇　紫葳各9克　柴胡18克　地鳖虫15克　䗪螂虫18克　瞿麦　桃仁各6克　法半夏3克　白芍15克共为细末，用鳖甲裙边同酒煮如胶，合药末为丸，如梧桐子大。每日用量1.5—2克。

（二）阿魏消痞丸

阿魏30克　白术　厚朴　广皮　香附　木香　半夏　当归　山查　枳壳　砂仁　鳖甲各60克　上药先将阿魏用火焙干存性，再合群药研细末，水泛为丸如梧桐子大，晒干。每次用量3—5克。

二方混合服用，每日三次，饭前半小时服。如患者有高度腹水，可配合逐水利尿剂。

疗程、反应及禁忌

23天为一个疗程，服后无任何不适反应，（但孕妇禁用）在服药期间，忌生冷食物，最好给予低盐食物。

结　　语

金匮鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸对晚期血吸虫病肝脾肿大有显著缩小及软化作用，其有效率达80%以上。有腹水者，配合逐水利尿剂，疗效亦佳，同时对大便脓血，里急后重，食后饱胀等均能很快的消失。服用亦颇简便，不但没有任何不适反应，并且服药后均有腹部较舒适的感觉，病人乐于服用。

录自（1957年4期《浙江中医杂志》“金匮鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸治疗晚期血吸虫病肝脾肿大41例疗效观察”。李凌台）

延按：鳖甲煎丸系治疟母之方，有破血、消瘀、软坚、理气破滞的作用。方载《金匮·疟病脉症并治》篇中，此案之肝脾肿大虽有血吸虫的因素，亦由气滞血瘀所导致，故可借用本方，但既用鳖甲煎丸为何还要配合阿魏消痞丸呢？余意第一方重在破血化瘀软坚，惜行气之力不足，本证既有腹胀不舒，或食后胀闷感觉，足见气机壅滞，故再辅以第二方，因方中有厚朴、广皮、香附、木香、枳壳、砂仁等芳香行气健胃药，本气行则血行之旨，所以更能增强第一方的疗效。

白虎加桂法案（四例）

1.疟久阴伤、痰阻营卫

久咳屡次见红，痰阻营卫，阴阳不能交通，寒热三日而至。其营卫郁勃之气，欲借阳经泄越，间有衬交，气血由此凝滞，偏左有形，脉象弦滑而带微数，阴气有渐伤之虑，欲和阴阳，当通营卫之痹。拟白虎加桂法，参宣通搜络之品。

处方：川桂枝　肥知母　生甘草　云茯苓　枳实　杏仁泥　广郁金　石羔粉　当归　鳖甲煎丸　录自《清代名医医案精华，张聿青医案》

2.疟疾伏邪，痰湿互阻

间日疟先寒战而后壮热，热盛之时，烦躁胸闷诂语，自午后至夜半，得汗而解。已发七八次，纳少神疲。脉弦滑而数，苔薄腻而黄。伏邪痰湿互阻，阳明为病，营卫循序失司。拟桂枝白虎汤加味，疏解肌邪而清阳明。

处方：川桂枝　陈皮　熟石羔　生甘草　炒谷芽　半夏　川象贝　煨草果　肥知母　佩兰　生姜　红枣　甘露消毒丹（滑石、茵陈、黄芩、石菖卜、川贝、木通、霍香、射干、连翘、卜荷、白邙）录自《清代名医医案精华，丁甘仁医案》

3.暑　　疟

杨国梁，年45岁。因暑热内伏，被新凉外触而发。其疟先寒后热，每日一发，寒少热多，口渴心烦，汗多气粗，病名暑疟。脉象洪数，右部尤甚，舌苔黄腻。此由暑热内蕴阳明，新感逗引而外溃也。治宜急清暑热，以顾津液，延恐津液干枯，变症百出，势已燎原，非辛凉重剂不能见效。拟桂枝白虎汤加味。

处方：桂枝0.9克　生石羔30克（研细）　知母12克　银花9克　连翘9克　天花粉9克　生甘草1.5克　生粳米1撮　一剂知，二剂效，三剂愈。

廉按：桂枝白虎，为治暑疟之正方，叶氏谓此方二进必愈，洵不诬也。案中阐明治则，要言不烦。录自《全国名医验案类编·丁佑之》

4.温疟痰厥

吴氏妇，年28岁。肺素有热，先伤于寒，后伤于风。其症先微寒，后大热，寒时则厥，神昏肢冰，半时许吐痰数口，则厥回而热，大渴大汗，气促面赤。《金匮》论温疟与内经互异，然阴气伤为瘅疟，肺有热为温疟，乃是定论。不必拘于微寒与不寒也。此疟先微寒，后大热，脉右洪苦薄白者，温疟也。然来时则厥，吐痰则醒，明有宿痰内蕴，乘疟窃发，互相为患，故断为温疟兼痰厥。

治法：桂枝白虎汤加减。以羔、知、芦根清透伏热为主药，花粉、石菖卜、玉枢丹豁痰开窍为辅药，佐桂枝以辛散外寒，使甘草以调和诸药也。

处方：川桂枝1.2克 天花粉9克 鲜菖卜1.3克（剪碎生冲）活水芦根30克（去节），生石羔15克（研细），肥知母9克 玉枢丹6克（磨汁研冲），生甘草1.5克，一剂知，二剂已。惟痰未尽除，用《外台》竹沥饮加减（淡竹沥两瓢，生姜汁二三滴，梨汁两瓢，加水略滚，温服）调理以善后，服三剂，痰除胃动而愈。

廉按：温疟兼痰厥，在老年往往一厥不醒，内闭外脱而毙，此案幸在壮年，犹可辛寒泄热、豁痰开窍而甦，然亦险矣。药从汉方加减，切合病情，故能效如桴鼓，可见古方学派，不可不悉心研究也。录自《全国名医验案类编，过允文》

延按：以上四案，均以白虎加桂枝汤为基础方。例一；气血凝滞，偏左有形，脉又弦滑微数。故于方中去粳米之

滞，加枳实、杏仁、茯苓、郁金、当归、鳖甲煎丸，以增强疏通气血瘀滞，通络软坚之力。例二；患疟，胸闷脉弦滑数，苔薄腻而黄，都足以说明疟邪久伏，痰湿互阻之象，故于方中去粳米、加半、贝、陈皮、谷芽、草果、佩兰、生姜、大枣、甘露消毒丹等清宣温化，豁痰开窍之品，惟方中石羔应用生者，大枣甘腻更胜粳米，似应减去较妥。例三：暑疟，由暑热内蕴阳明，新感逗引而外溃，故于方中再加银、翘、花粉辛凉轻透兼顾津液药品。例四：温疟兼痰致厥，用桂枝白虎去壅补之粳米，加清热生津豁痰开窍之花粉、鲜菖卜、芦根、玉枢丹，并佐《外台》竹沥饮加减搜剔未尽之痰以善后。观此四案，足见其运用古方，化裁恰当，故能收到满意的效果。

侯氏黑散证案

肠风下血

王惠阶，年壮形伟，大便下血，医治半载，以平素嗜酒，无不利湿清热以止血，如地榆、柏叶、姜、连之类，服之不应。厥后补中，胃风，四神之属，投亦罔效。求治于余。诊脉小弦，大便或溏或泄，不及至圊，每多自遗。其血清淡，间有鲜色。更有奇者，腹中无痛，但觉幅幅有声鼓动。因悟此必虚风内扰，以风属无形有声，与经旨“久风成飧泄。”①吻合。且脉弦者肝象也，肝风内动，血不能藏故

耳。因与玉屏风，重防风、加白术，乃扶土制木之意，更加葛根辛甘属阳，鼓舞胃气，荷叶仰盂象震，挺达肝风，叠投多剂，其症一日或减，越日复增，轻重无常。予思虚风内动，按症投剂，疾不能瘳者，何故？潜思累夕，不得其解，忽记经有虚风邪害空窍之语。②盖风居肠间，尽是空窍之地，非补填窍隧，旧风虽出，新风复入，无所底止，故暂退而复进。乃从《金匮》侯氏黑散驱风堵截之义悟出治法，填塞空窍，将原方加入龙骨、石脂，兼吞景岳玉关丸，不数日果获全瘳。侯氏黑散：菊花、防风、白术、桔梗、人参、茯苓、当归、川芎、干姜、桂枝、细辛、牡蛎、矾石、黄芩。

玉关丸：灰面、枯矾、文蛤、五味、诃子（张景岳方）

注：①《素问，风论篇》"久风入中，则为肠风飧泄。"

②《素问，移精变气论》"贼风数至，虚邪朝夕，内至五脏六府，外伤空窍肌肤。"

录自《谢映庐医案》

延按：喻嘉言《医门法律》中风门谓："驱风之中，兼填空窍，空窍一实，庶风出面不复入，其病瘳矣。古方中有侯氏黑散，深得此意，仲景取为主方。"谢案当本《素问》理论及喻氏学说得到启发而借用此方，再加龙骨、石脂，佐入景岳玉关丸，以增强其填塞空窍之作用，因而收到良好效果。

防己地黄汤加味证案

心　风

刘肃一，年二旬。其父叔皆大贾，雄于资，不幸先后逝世，丧停未葬，君因自省休学归，店务猬集，不谙经营，业大败，折阅不知凡几，以致债台高筑，索债者络绎于门，乃支身走湘潭收旧欠，又兴讼，不得直，愤而归。遂心志失常，时而抚掌大笑，时而歌哭无端，俄而正性复萌，深为愧悔，医以为癫，进加味温胆汤吞白金丸，吐涎少许，证未少减。诊脉细数，舌绛无苔，胸中痞闷，夜不安卧，小便黄短，是为志拂郁而不伸，气横逆而不降，心神耗损，肾水亏乏，火气妄凌，痰涎泛溢，有癫之意不若癫之甚，所谓"心风"证也。治以益血滋阴安神调气为主。拟《金匮·防已地黄汤加味。》

处方：生地60克（捣汁兑），甘草6克，防已9克，桂枝3克，加香附9克，首乌、竹沥各15克，兼吞安神丸12克，日服二剂。三日复诊，神志渐清，潮发减少，随进滋阴安神汤，（生地、芍药、川芎、党参、白术、茯神、远志、南星、枣仁、甘草、黄连）服后略觉头胀心闷，微现不宁，审由余热未清，难任参术之补，故证情微加，乃改用清心养神，略佐涤痰，晨服清神汤（黄连、黄芩、柏子仁、远志、菖卜、枣仁、甘草、姜汁、竹沥）晚进二阴煎，（生地、麦冬、枣仁、元参、茯苓、木通、黄连、甘草、灯心、竹

叶）每日各一剂，如是者四日，遂热不再潮，人事清悉，诊脉细数有神，余热似尽，而参术之补，现犹所忌，尚有余焰复燃之虑，处天王补心丹作汤服，（生地、人参改洋参、元参、丹参、茯神、桔梗、远志、天、麦冬、枣、柏仁、五味、当归）送服磁朱丸补心滋血，安神和胃，嗣即精神健好，食纳增进，又调理半月，改用栀麦归脾汤，仍吞服磁朱丸，善后补养，再一月而身健复元。录自《赵守真治验回忆录》

延按：本案为治心风立法。查心风一词，见《素问，风论篇》又考《中国医学大词典》在"心风"条下谓："心气不足而癫也。此症精神恍惚，喜怒不常，语无伦次，有癫之意，无癫之甚，多由思虑伤脾，致谷气寖少，血液日亏，心神散漫神不守舍所致。"此症当本此意而立法处方的。至所用防已地黄汤方载《金匮，中风历节病脉症并治》治病如狂状妄行，独语不休，无寒热，其脉浮。药为防已、防风、桂枝、甘草、生地，方中生地分量最重，是以养血为主，防已等分量较轻，是以熄风为佐。再加入香附、首乌、竹沥安神调气豁痰之品，由此可见本证属心肾阴亏，虚火上炎，气机拂郁，病源属虚的因素较多。开始医用温胆汤吞白金丸，是虚以实治，故无效。继用滋阴安神调气涤痰之品而效始显。

又按：本症属阴血虚而兼拂郁，所以方中一用壅补之参术，即有胀闷之反应，可见处方用药，必须针对病情，善于化裁得当，始能获得满意的效果。

桂枝芍药知母汤证案

历　　节

曹颖甫治一戴姓妇，妊八月，为其夫病求医，抱而乘车，病人身重，将腹中小儿压毙，夫病愈而妻病腹痛，乃求医，医药而堕之，腐矣。妊妇本属血虚，死胎既下，因贫不能善后，湿毒留顿腹中，久乃旁溢肢节，死血与寒湿并居，因病历节。手足拘挛，入夜手足节骱剧痛，旦日较缓，其为阴寒无疑。盖二年矣。予因用桂芍知母汤原方以每30克折为6克，用熟附块12克，二剂不应。二诊改用生附子，汗乃大出，两剂，肢节便可屈伸，足肿亦消，独手发出大泡，有脓有水，将成溃烂。予用丁甘仁法，用大小蓟各15克，丹皮30克，地骨皮12克以清血热，二剂而痂成，四剂而痂脱，遂与未病时无异。忽然阴痒难忍，盖湿毒未尽而下注也。予因令其用蛇床子煎汤（金匮方）熏洗，良瘥。未几，入市购物，卒然晕倒，诸恙退而血虚之真象见，予乃用大熟地30克，潞党参15克，川芎、当归各12克，龙骨、牡蛎各30克，凡廿余剂而愈。录自（曹颖甫《金匮发微》）

延按：曹案对本方方义认为方中“惟知母一味主治欲吐，余则桂、芍、甘草、生姜以通阳而解肌，麻黄、附子、白术以开表而去湿，防风以祛风，方治之妙，不可言喻。”又云：“所治代姓妇案，病因与仲景所举大有不同，乃知肢节疼痛，仲师特下一诸字，正以其所包者广也。”案中所治

系死血与寒湿并居，因病历节，初用熟附无效（原方中系附子炮），二诊改用生附效乃显，此为颖甫先生之实践经验，值得诊视。继因病情转变。已有化热趋势，乃改用丁甘仁先生清血热法。终因病去而血虚，遂用大补气血兼镇摄药品以善后，足见前辈医家博采众长，择善而从，非拘执古方，泥古不化者可比。

桂芍知母汤加味证案（二例）

1.风寒湿痹

康翁，经商外地……不间寒暑，冒风露以行。1946年冬往商零陵，中途突发风湿关节病，不利于行，视其身沉重，手足拘急，关节痛处微肿，走注疼痛，如虎啮，如针刺，刻不可忍，有时发寒热，但无汗，脉沉紧，舌苔白润，气息难续。《金匮》更详叙其方证谓："诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。"①但其夜痛加剧，则又兼及血分，宜此方与张锡纯之活络效灵丹②配用，始可一鼓而奏肤功。

处方：桂枝、芍药各45克，麻黄18克，乌附24克，知母12克，防风、当归、丹参各30克，乳香、没药各 9 克，苍术、白术各18克，每日一剂，酒水各半煎，分早中晚三次服。夜间汗出遍身，痛楚略减，又续进五剂，兼吞小活络丹，每次4.5克，夜间均有微汗，痛逐减轻，脉见缓和，手

足能屈伸，关节肿消，尚不能起床。以其人思虑多，气血虚，乃师前人攻衰其半之旨，改拟攻补兼施之三痹汤（独活寄生汤去寄生、加黄芪、续断），加防已、蚕沙、海风苋、银花苋等疏络活血药，一日二剂，步履如常。再用十全大补汤加电、鹿、虎三胶服，逐次复元，更佐以荣养调摄，数年未发，且无他病。

注：①《金匮，中风历节病脉症并治》

②（《医学衷中参西录》，治气血郁滞肢体疼痛方）录自《赵守真治验回忆录》

2.鹤膝风

周奠章，年二旬。因远行汗出，跌入水中，风湿遂袭筋骨而不觉。其症始则两足酸麻，继而足膝肿大，屈伸不能，兼之两手战掉，时而遗精，体亦羸瘦，疗治三年罔效，几成废人。诊脉左沉弱，右浮濡，脉症合参，此鹤膝风症也。由其汗出入水，汗为水所阻，聚而成湿，湿成则善流关节，关节者，骨之所凑，筋之所束，又招外风，入伤筋骨，风湿相抟，故脚膝肿大而成为鹤膝风。前病见病者，手战遗精，误认为虚，徒用温补，势濒于危，岂知手战者，系风湿入于肝，肝主筋，而筋不为我用，遗精者，系风湿入于肾，肾藏精，而精不为我摄，溯其致病之由，要皆风湿阶之厉也。设非驱风去湿，其病终无已时。择用桂芍知母汤，桂、芍、甘草调和营卫，麻黄、防风驱风通阳，白术补土去湿，知母利溺散肿，附子通阳开痹，重用生姜以通脉络，间服芍药甘草汤补阴以柔筋，外用麻黄、松节、芥子包患处，开毛窍以去

风湿。

处方：桂枝12克，生白芍9克，知母12克，白术12克，附子12克（先煎），麻黄6克，防风12克，炙甘草6克，生姜15克。

次方：生白芍18克，炙甘草9克。

外用方：麻黄、松节、芥子各30克，研匀，用酒和调，布包患处。

服前方半日许，间服次方一剂，其脚稍伸，仍照前法再服，半月其脚能立，又服一月，渐渐能行，后守服半月，手不战，精不遗，而足行走如常，今已廿余年矣。

廉按：足胫渐细，足膝渐大，骨中酸痛，身渐瘦弱，此鹤膝风症也。其症有二，一本于水湿之入骨，重而难移，痛在一处而不迁。一本于风湿之入骨，轻而可走，其痛移来移去而无定，二者因症不同，治亦随之各异。此案病因，系风湿内袭筋骨而成，法宗仲景，方亦对证，药既瞑眩，厥疾自疗，真古方学派之佳案也。录自《全国名医验案类编，易华堂》

延按：例一，根据本案表现的症状，与《金匮》历节病基本相符，故用桂芍知母汤。因其夜痛加剧，故又加乳、没、当归、丹参、苍术等以增强活血通络镇痛之力，善后用峻补气血药收功，更见考虑周到。例二，风湿所致之鹤膝风，择用驱风去湿之桂芍知母汤，间用补阴柔筋之芍药甘草汤，并外用开毛窍去风湿之麻黄、芥子、松节等和酒包患处，如此内外兼治，则风湿当无地自容矣。

乌头汤证案

寒湿脚气

梁盛南，港商，乃子章成，15岁。因得脚气症返自香江，四肢瘫痪，医辈齐集，纷无定见，患者面色青白，气逆上喘，腿部胫骨疼痛，麻木不仁，脉细小而浮，重按无力，此乃白虎历节重症，金匮以乌头汤主治。余用其方重加麻黄15克，群医哗然，麻黄发汗，夫谁不知，未加杏仁，汗源不启，小青龙治喘所以去麻加杏者，恐麻杏合用发汗动喘耳，今本方主乌头以降麻黄，不用先煎，何至发汗？……果尽一剂，麻木疼痛立减，略能舒动，因照前方连服十余帖，麻木疼痛全失，已能举步于行，惟尚觉脚筋微痛，关节屈伸不利，改用芍药甘草汤以荣阴养血，方中白芍、甘草均用60克，连服八帖，应手奏效。

按：脚气之因乃内有湿热外感风寒而成，今此案症见麻木不仁疼痛，乃寒湿之偏盛也，盖寒胜则痛，湿胜则不仁，病至筋结则屈伸不利，故用治寒湿之剂，最为合拍。《金匮》云："乌头汤方，治脚气疼痛，不可屈伸"。尤在泾云："此治寒湿历节之正法也，寒湿之邪，非乌头麻黄不能去，而病在筋节，又非皮毛之邪可一汗而散去，故以黄芪之补，白芍之收，甘草之缓，牵制二物，俾得深入而去留邪"。所以重加麻黄者，盖以气逆上喘，寒水射肺之故也，肺乃水之上源，肺之气化能行则水精四布，通调水道有赖，故重用

麻黄，以其能走太阳寒水之经，功先入肺，性则偏温，寒饮稽留，藉味辛而宣散，痰哮喘逆，仗苦力以搜除，是故加用之。

芍药甘草汤，乃仲师治误汗伤血则厥逆脚挛急之剂，今此案之关节屈伸不利，究属血营濡养不常所致。故取用之以营阴养血之善后剂是矣，两症根由虽异，惟终结同为脚挛急，故可借用之也。录自（1962年1期《广东中医》“乌头汤治愈脚气重症”程祖培医案）

延按：乌头汤治寒湿脚气的具体脉症，案中已叙述周详，对药物组合作用，引尤注作说明，很恰当。至重加麻黄和用芍甘汤善后的意义，也在按语中发挥尽致，真古方佳案也。

黄芪桂枝五物汤加味证案

中　风

韩妇，24岁，1965年3月22日。

初诊：心悸头晕约二年之久。于1963年8月仆倒后，左半身不遂，口眼喎斜，至今未愈。形体消瘦，言蹇舌强，头晕头痛，脉象沉细，舌赤无苔，证属气血两亏，瘀阻脉络，以益气养血，通经活络为法：

处方：当归　川芎　赤芍　地龙　没药　橘络各15克　生地20克　桃仁　甘草各10克　红花5克　桂枝7.5克，生芪25克

水煎服。

二诊：服药后，头晕头疼略减，左侧肢体略温，上下肢稍灵活。脉舌同前，原方续进。

三诊：服药六剂后，半身麻木减轻，手足活动较灵活。惟咳吐血痰。前方去桂枝辛温发散，加鸡血藤活血通络。二剂后咳血止，舌动灵活，言语清晰。方去橘络，加丝瓜络15克，并用五灵脂、生卜黄各50克研细末，匀20包，每日中午一包，以助化瘀之力。三年痼疾，竟告全愈。

按：中风一候，于神志清醒后，每有后遗证。《金匮》云："邪在于络，肌肤不仁"，此之谓也。多因气血亏虚，经络不通，古方黄芪桂枝五物汤、补阳还五汤等，都以益气养血，通经活络为主。本案即取二方之意，随证化裁，使病获愈。录自（辽宁中医1977年试刊号"老大夫医案选"孙允中）

延按：黄芪桂枝五物汤为《金匮》方。补阳还五汤为《医林改错》方。本症既属久病气血皆虚，又兼瘀阻脉络，故取二方之意，注重攻补兼施。

桂枝加龙骨牡蛎汤证案

伤风吐血梦泄

张路玉治沈懋甫仲子，年十七，每伤风，即吐血梦泄，此肝脏有伏火，火动则招风也。盖肝为藏血藏魂之地，肝不

藏则血随火炎，魂不宁则精随梦泄，遂与桂枝汤加龙骨、牡蛎(注)，四剂而表解血止。桂枝汤主和营散邪，加龙、牡以镇肝安魂。封藏固则风不易入，魂梦安则精不妄动矣。若以其火盛而用知、柏之属，鲜有不成虚损者。

注：《金匮·血痹虚劳病脉症并治》

震按：伤风是轻病，然有伤风不醒即成痨之说，今人犯此者甚多，大约喜于色欲及常多梦泄之辈。《素问，评热病论》谓："劳风法在肺下，太阳引精者三日，中年者五日，不精者七日，咳出青黄涕如脓，不出则伤肺死。"盖引精者肾脏充固，太阳引少阴内守而自为外拒，邪从痰出，不致内留伤肺也。不精即冬不藏精之义，肾脏亏乏，太阳馁而无援，邪留难出，伤风所由不醒也。昧者峻用发散，不知人愈虚，邪更易入也。或竟用滋补，不知邪未清，补之适以助长也。此中之权衡，在于医者，此际之调理，在于本人耳。录自《古今医案按》

延按：张案对伤风致吐血梦泄既不用发散，又不用知、柏，而用桂枝龙牡取效。其识见自高人一等。案后俞震引《素问》劳风之说以阐明病理，足资启发。

又按：张案肝脏有伏火之说，此火当系指虚火而非实火，故用龙牡镇摄收敛。

加味桂枝加龙牡汤证案

遗　精

黄子靖，青工，恣情纵欲，又因劳动不节，致精神不固，心火妄炎，夜不安寐，寐则梦遗，头晕身倦，气短息低。诊脉尺寸皆虚，左关独弦而细数，口苦心烦，有潮热，小便黄等症象。所谓肾水亏于下，君火炎于上，劳倦伤脾，肝气横逆，故水愈亏而火愈旺，肝愈逆而土愈虚，水火不济，升降失调，而梦遗之证成。惟患者羸孱如斯，拟先用金锁固精丸，安神丸合剂（改汤），固精宁神，滋阴清火，以治其标。三剂烦热口苦悉退，而夜梦犹多，遗无虚夕，再进固精丸（改汤），药为：牡蛎、菟丝、韭子、龙骨、五味、桑螵蛸、白石脂、茯苓等，遗尤甚。改处清心饮（党参、当归、干地黄、甘草、朱茯神、枣仁、莲肉、远志、黄连），仍无效。思《金匮》桂枝加龙牡有治失精之明文，因用此方加茯神、辰砂末，服三四剂效乃显，除仍服原汤外，早晚用莲心、金樱子煎汤，送服妙香散五钱，以增强镇心固精力量，半月精不遗。善后固本方，为拟归脾汤吞都气丸，持续一月，神旺体健，大异往昔。录自《赵守真治验回忆录》

延按：本案先后选用安神丸，清心饮，固精丸之类固精宁神，滋阴清火之品无效。继用桂枝龙牡再加茯神、辰砂末以增强宁心镇静安神之力而效始显。足见本症遗精不仅阴虚，阳气亦因久泄而亏损，所谓阴损及阳也。用本方则阳能

固，阴亦能守，精就不致外泄了。故效。其用妙香散、归脾汤吞都气丸，是注重镇惊开郁，增强心脾肾的功能，作善后巩固疗效之计。至于阐述病源，分析病理，原案已详，细读之自明。

天 雄 散 证 案

肾虚头痛

刘××，男，42岁，汽车司机。

主诉：头痛已一年多，时轻时重，最近头痛增剧，痛时觉头部空虚不能动，动则痛甚，并影响吃饭睡眠。大便时溏，小便多。曾经西医检查诊为神经性头痛，治疗无效。转中医治疗，服药时疼痛稍减，停药即痛。

初诊：舌质淡红，苔薄白而润，脉沉弦细，重按无力，诊为血虚头痛，用加味八珍汤治疗。服药三剂，症状未减，并有遗精，自诉过去亦常遗精，约3～4天一次，时有腰痛，夜尿多。后诊为肾虚头痛，改用天雄散治疗。

处方：炮附子18克　白术24克　桂枝　龙骨各18克　煎水至八分，与米酒壹两同服，三剂。

复诊：头痛大减，喜甚，继服药23剂，头痛消失。

按：程师对此病例，初诊为血虚头痛，用八珍加味治疗，是取其平稳，以作试诊，复诊无效，并见遗精，即诱导患者诉说肾虚症状，与脉色合参，确诊为肾虚头痛。患者体

虚精亏，肾阳虚衰，精气不能上营而致头痛，故用天雄散温补肾阳，收涩肾精，阳回阴固，肾气复，精气足，脑髓充，头痛自愈。录自（《广东医学》祖国医学版1964年6期，程祖培医案，毛海云整理）

延按：天雄散方见《金匮·血痹虚劳病脉症并治》篇。考天雄散之功效，陆渊雷医学前辈在其所著《金匮今释》中引吉益民之说云："天雄散《金匮要略》载在桂枝加龙骨牡蛎汤条后，而不载其证。而李时珍作本草纲目曰，此仲景治男子失精之方也，然则旧有此证而今或脱也。男子失精，女子梦交，桂枝龙骨牡蛎汤主之下，当云天雄散亦主之……。"本案有常遗精、腰痛、夜尿多等症状，自属肾虚无疑，根据肾主骨髓，脑为髓海，因肾阳虚衰，精气不上达而致的头痛，并本此理论指导来立法处方治疗此症，是非常恰当的。

小建中汤证案（四例）

吐　血

1.赵，劳伤吐血，脉双弦，金匮谓大则为虚，弦则为减，虚弦相抟，其名曰革，男子失精亡血，诸虚不足，小建中汤主之。

处方：白芍18克　炙甘草9克　生姜5片　桂枝12克　胶饴30克（去渣后化入上火二三沸）　大枣去核2枚　水五碗，煎取两碗，渣再煮一碗，分三次服，轻者日一帖，重则

日再服。

2.胡，劳伤吐血，汗多足麻，六脉弦细不数，小建中汤主之。

处方：白芍18克　炙甘草9克　生姜5片　桂枝12克　胶饴30克后入　大枣去核3枚　煮三杯，去渣后，将胶饴化入上火二三沸搅令匀，分三次服。

汗减足麻愈，食少，加原方再服。

前药已服十四帖，诸症皆愈，惟咳嗽未止，于前原方加云苓、半夏。录自《吴鞠通医案》

腹　痛

1.传妇，脉来弦紧而沉，有凝滞之状，腹中必有宿食，秋深恐成痢疾。以四君子汤加枳壳一剂，服下腹中略响，正邪气缓散之征，讵妇女辈闻余言有积滞，竟私煎服浓姜茶二汤一碗，下咽之后，腹中绞痛难堪，下利数十行，头身大热，十指微冷，而既已误治惹动其邪，无如乘其元气未败，再与疏通尽驱其邪，更以小剂行气之品一剂，泻下腹痛略减，但潮热指冷不除，次早复诊，问所下何物，视之一团白沫，隐然秋深肠澼之征，此时人事困顿，脉仍弦紧，是知当理阳气，与金匮小建中汤一剂，其症悉愈。录自《谢映庐医案》

3.顾右，产后，月事每四十日一行，饭后则心下胀痛，日来行经，腹及少腹俱痛，痛必大下，下后忽然中止，或至明日午后再痛，痛则经水又来，又中止，至明日却又来又去，两脉俱弦，此为肝胆乘脾脏之虚，宜小建中加柴、芩。

处方：桂枝9克　生白芍15克　炙草6克　软柴胡9克　酒芩3克　台乌4.5克　生姜5片　红枣12枚　饴糖90克

拙巢注：一剂痛止，经停，病家因连服二剂，全愈。

按：余初疑本证当用温经汤加查曲之属，而吴兄凝轩则力赞本方之得。师曰：大论云："伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，若不差者，小柴胡汤主之。"我今不待其不差，先其时加柴胡以治之，不亦可乎？况妇人经水之病，多属柴胡主治，尔侪查诸云云。翌日据报，病向愈矣。录自（曹颖甫《经方实验录》）

延按：小建中汤方，一见于《伤寒论，太阳中篇》102，105条。一见于《金匮，血痹虚劳病篇》和《妇人杂病脉症篇》本案四例。吴案两例为劳伤吐血，系根据金匮男子亡血失精，为诸虚不足，本劳者温之之意而立法处方。腹痛两例，谢案由体虚误用疏利积滞汤药，伤其中阳所致，故用建中以小小建立中气。曹案因经行腹痛，脉弦，认为肝乘脾，故用建中以治脾，加柴、芩以疏利肝胆，且二味为小柴胡主药，弦又为少阳主脉，与伤寒论102条之旨相符，加台乌，因痛则不通，增入此味，则行气止痛之力更强，又与金匮治妇人腹中痛之旨相合。请与本书上集小建中汤证条合参。

黄芪建中汤证案（三例）

1.泄泻不食

胡晓鹤孝廉尊堂，素体虚弱，频年咳嗽，众称老痨不治。今春咳嗽大作，时发潮热，泄泻不食。诸医进参、术之剂，则潮热愈增，用地黄、鹿胶之药，而泄泻胸紧尤甚，延医数手，无非脾肾两补，迨至弗效，便引劳损咳泻不治辞之。时值六月，始邀余诊，欲卜逝期，非求治也。诊之脉俱迟软，时多歇止，如徐行而息，偶羁一步之象，知为结代之脉，独左关肝部弦大不歇，有土败木贼之势，因思诸虚不足者，当"补之以味"①，又"劳者温之"，"损者益之"②，但补脾肾之法，前辙可鉴，然舍补一着，又无他法可施，因悟各脏俱虚之脉，独肝脏自盛……此病肝木自盛，脾土不胜，法当补土制肝，直取黄芪建中汤与之。盖方中桂、芍微泻肝木之胜，甘、糖味厚，重实脾土之不胜，久病营卫行涩，正宜姜、枣通调，而姜以制木，枣能扶土也，用黄芪补肺者，盖恐脾胃一虚，肺气先绝，连进数剂，果获起死回生，但掌心微热不除，咳泻虽止，肝木犹强，原方加入丹皮，重泻肝木之胜，再进而安。

处方：黄芪建中汤　黄芪　芍药　肉桂　甘草　煨姜　饴糖　大枣

注：①《素问，阴阳应象大论》

②《素问，至真要大论》

2.劳伤中气

聂安生，腹痛下痢，红多白少，诸医以腹痛为积，又以红多为热，屡进消导不应，更与芩、连、归、芎，服之潮热时起，下坠难支，欲进巴霜丸，疑而未决。余为诊视，左关弦大之至，唇舌虽红，然不喜茶水，脉症相参，知为劳伤中气，以致营卫不调。盖营虚则血不藏，卫虚则气不固，而为下利红白也。加之苦寒迭进，致使阳虚外扰而潮热，中气内伤而下坠，意拟理中焦之阳，使气血各守其乡，但脉无沉细，且有弦大，又兼腹痛，据症按脉，斯补土，制木，提气三法，在所必须，与黄芪建中汤加姜炭，四剂始安，后与附桂理中加故纸、鹿茸、十剂而健，孰谓下利脓血定为热耶。

3.中虚血寒

吴显余内人，小产后腹痛，夜热咳嗽，医者作瘀血治之，遂尔腰屈不伸，痰多食减，又以理中，四物之属投之，致令夜热大作，少腹极痛，脉来迟紧带弦。因谓之曰，此中虚而血寒也。四物泥腻，非痰多食减者所宜，理中壅燥，岂夜热咳嗽者能任，遂疏黄芪建中汤，叠进而安。录自《谢映庐医案》

延按：黄芪建中汤，见《金匮，血痹虚劳病脉症并治"虚劳里急诸不足"立一温养之法，深合内经"劳者温之"，"损者益之"之旨。但此法仅可施于纯虚无热之体，若后世所患之痨瘵，症见潮热盗汗，五心烦热，咳嗽咯血，脉细数，舌质红绛，枯萎少津等现象，多属阴虚火旺之体，则宜

用清滋之法，应在葛可久《十药神书》中选择对症方剂，必须鉴别清楚，不可妄施。徐洄溪《兰台轨范》虚劳门曾论及之，可参阅。

黄芪建中汤加减证案（二例）

1.胃　　痛

常姓，男，32岁。

主诉：患十二指肠球部溃疡已三年，过去常服西药未效，最近半年来疼痛加剧，痛呈阵发性，空腹痛甚，得食则减，喜热畏凉。口和便调，偶有轻微吐酸，平日不能食硬物，仅能用稀饭。

检查：剑突下有压痛，但不拒按，舌苔薄白，脉象虚缓，大便潜血有时阳性。中医诊断为虚寒型胃脘痛，方用黄芪建中汤加炒川栋、香附、乌贼骨等出入，先服八剂，疼痛减轻，服至21剂，疼痛基本消失，可以吃硬食物，服至24剂后造影复查，证明十二指肠球部已无明显异常，充盈尚整，无激惹现象，体部正常。大便潜血阴性。遂停药观察两月未复发，后经追访已可以吃硬饭，并已照常上班。

2.胃　　痛

杜姓，男，33岁。

主诉：患溃疡病八年之久，曾经多次住院治疗，经X线

胃肠造影为十二指肠球部溃疡，近数月来因饮食不当，症状加重，自觉上腹部疼痛，饥饿时严重，进食即缓解；多发作于夜晚，放射至腰部亦痛；畏凉，喜热按，尤怕生冷硬物，痛时兼有吐酸、呕恶，胸胁胀满，饮食少纳；大便尚正常，无潜血，舌苔淡白，脉虚弦。腹诊上腹部有压痛，但不拒按。中医诊断为虚寒型胃脘痛兼有肝胃不和之标症。治用黄芪建中汤治本，加乌贼骨、煅瓦楞、左金丸止酸，半夏、旋复花止呕，炙乳、没、川楝子舒肝镇痛，神曲、麦芽、山查、代代花和胃健脾治标，服药五剂，痛已间断，饮食增加，吐酸亦减，但仍胸满而痛，原方减半夏、神曲、麦芽、山查，加郁金，先后共服18剂，疼痛和兼症相继消失，遂停止服药。本例即在治本基础上照顾标症，终于取得满意疗效，该患者已上班工作。

治疗方法

处方：黄芪建中汤加减。

黄芪　白芍　桂枝　甘草　炮姜炭

本方适用标准及加减法：虚寒型胃脘痛，其症状表现为：胃痛日久，痛处喜按，饥饿则痛，得食则减，喜热畏凉，舌苔薄白，脉虚而缓；如有肝胃不和之兼症，如吐酸、嗳气、呕逆、胀满等，则在本方基础上略事加味，例如：①吐酸嘈杂者加左金丸、乌贼骨、煅瓦楞；②呕吐苦水者加旋复花、竹茹、黄连；③呕吐清水者加吴茱萸、半夏、干姜；④胀满者加厚朴、砂仁、广木香；⑤痛甚者加川楝子、炙乳没；⑥四肢逆冷者加炙附子；⑦心下有水声者加二陈

汤；⑧食少纳呆者加代代花、厚朴花、谷芽。

服法：每日一剂，用水煎成400毫升，分早晚两次服，症状减轻后，改用建中散（即本方加乌贼骨、煅瓦楞、川栋子配成散剂）巩固疗效。

讨　论

我们通过临床实践，证明黄芪建中汤用来治疗虚寒型溃疡病，确属有效，据初步体会掌握本方在辨症时必须抓住几个临床特点，即：日久胃脘痛，痛处喜按，空腹痛甚，得食则缓，喜热怕凉，脉多虚缓或虚弦，舌苔淡白，如符合这一类型，用本方治之自能见功。本文内容过长，作了部分删节。录自（1963年第3期《中医杂志》"黄芪建中汤治疗溃疡病的临床体会。"刘善元）

延按：案中对虚寒型胃痛的脉症，叙述较全面，在方后的八项加减法中，体现了标本兼治的灵活性，并扩大了本方的使用范围。

酸枣仁汤加味证案

自　汗

许××，48岁，女，已婚，干部。1960年9月20日初诊。患者素有头晕，目眩，汗多，一星期前突然昏倒，不省

人事，当时血压80／20毫米汞柱。经医务所大夫急救，很快即醒，是后仍有心慌、气短、头晕、目眩、嗜睡、汗多，以夜间汗出更甚，食欲尚佳，二便及月经正常。曾经针灸治疗过二月余，并服过归脾汤加川断、巴戟天、牡蛎、浮小麦、枸杞子、小茴香等，未见显效，脉两寸尺沉细有力，两关弦数，舌质正常无苔，认为属肝热阴虚，肝阳不潜，兼心血不足，治宜滋阴潜阳，兼养血宁心。酸枣仁汤加味。

处方：酸枣仁9克　知母　川芎各3克　茯神6克　炙甘草3克　白蒺藜9克　珍珠母（打）12克　石决明（打）12克　女贞子9克　怀夕、地骨皮各6克　龟板（打）12克　连服数剂。

10月6日二诊：服药后诸症见好，汗出大减，尚有心慌及疲乏感，饮食及二便正常。改为丸剂以滋阴养血为主而缓治之。

处方：柏子仁（炒）60克　枸杞子30克　麦冬24克　当归18克　石菖卜18克　玄参30克　茯神18克　干地60克　炙甘草18克地骨皮　炒枣仁各30克　共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各一丸。以后渐愈，恢复正常。

按：本例汗症，素体阴虚，故头晕目眩，甚则昏倒，是后汗多，以夜间更甚。由阴虚而营阴不固，肝阴既虚，肝阳则不潜，加之心血不足。汗为心之液，今肝热心虚而汗出，所以用滋阴潜阳，养心安神之剂，而收敛汗之功。录自《蒲辅周医案》

延按：酸枣仁汤见《金匮·血痹虚劳病脉症并治》中，系治虚劳虚烦不得眠之方。本案于酸枣仁汤的基础上，再加入滋阴潜阳药品，借用以治自汗。因本症汗出，不仅心血

虚，兼有肝阳不潜，故不但治心兼治肝。最后汗出大减，尚有心慌及疲乏感，就用专滋阴养血药为丸缓治以收功。

酸枣仁汤加味证案

虚烦不眠

何××，女，32岁。

症状：1936年仲冬，因久患失眠，诸药无效。形容消瘦，神气衰减，心烦不寐，多梦纷纭，神魂不安，忽忽如有所失。头晕目眩，食欲不振，脉象弦细，舌呈绛色，两颧微赤。

诊断 素禀阴虚，营血不足。营虚无以养心，血虚无以养肝，心虚神不内守，肝虚魂失依附，更加虚阳上升，热扰清空所致。

疗法 议用养心宁神法，以酸枣仁汤增减主之。

处方 北野参 知母 百合花各9克 朱茯神 白芍 夜交藤各12克 炒枣仁 珍珠母各24克 川芎 甘草各3克 水煎；另用老虎目睛0.15克研末冲服。连服十三剂，便能酣卧，精神内守，诸症豁然。

自按：此虚烦不得眠症也。由于营阴素亏，内热躁扰。故方中用枣仁之酸苦，以泻胸中郁热；知母之苦寒，以滋肾脏之真阴；茯神之甘平而助宁静；川芎之苦辛而主疏达；珍珠母之潜以安魂；老虎目睛之静以定魄；百合花朝开暮合，具昼夜之机宜；夜交藤左右相交，取阴阳之交感；白芍可敛

戢肝阳；人参能补益心气；加以甘草协和诸药，俾其金壮水清，而木平火降，神魂不扰，则梦寐安宁。录自（蒲园医案）

延按：本案用酸枣仁汤以治虚烦不眠，与《金匮》条文内容基本相符。并配合许学士真珠圆法，再加入百合花、夜交藤、白芍等品，柔养滋潜，更见组方周密，非杂药乱投可比，故能愈此沉痼之疾。考虎睛定魄之说，见《普济本事方》真珠圆后附董生案例。百合花朝开暮合之说，见张隐庵《侣山堂类辩》百合紫苏条下。惜此二物都不易觅，余意可改用百合和琥珀粉代之，当亦不悖原意。

大黄䗪虫丸证案

干血痨

陈镜湖，万县人，半业医，半开药铺，有女年十七，患干血痨。经停逾年，潮热，盗汗，咳逆，不安寐，皮肉消脱，肌肤甲错，腹皮急，唇舌过赤，津少，自医无效，住医院亦无效，抬至我处，困惫不能下轿，因就轿边诊视。脉躁急不宁，虚弦虚数，予曰：脉数，身热，不寐，为痨病大忌，今三者俱全，又加肉脱皮瘪，几如风消，精华消磨殆尽，殊难着手。渠乃为敷陈古今治痨方治，略以金匮以虚劳与血痹合为一篇颇有深意，仲景主小建中汤阴阳形气俱不足者调以甘药，唐·孙氏又从小建中悟出复脉汤，仲景用刚中

之柔，孙氏用柔中之刚，功力悉敌，究之死血不去，好血无由营周，干血不除，新血无由灌溉，观大黄䗪虫丸，多攻破逐瘀之品，自注缓中补虚，主虚劳诸不足，乃拟方：白芍18克，当归、生地各12克，鳖甲15克，白薇、紫菀、百部各9克，甘草3克，大黄䗪虫丸十粒，煎剂分二次服，丸药即二次用药汁吞下。十日后复诊，咳逆略缓，潮热盗汗渐减，原方去紫菀、百部加藏红花、琥珀末各0.24克，丸药米酒下。又十日复诊，腹皮急日渐宽舒，潮热盗汗止，能安寐，食思渐佳，改用复脉汤嘱守服久服。越三月……已面有色泽，体态丰腴，不似以前瘁羸。虚痨素称难治，然亦有短期治愈者。录自《冉雪峰医案》

延按：大黄䗪虫丸载《金匮·血痹虚劳病脉症并治》，治"五劳虚极羸瘦，腹满不能饮食……内有干血，肌肤甲错，两目黯黑"。为一去瘀生新的方剂。方中大黄、䗪虫、干漆、桃仁、水蛭、虻虫、蛴螬等活血通络、消瘀破症，意在祛邪；地黄、芍药、甘草濡养血脉，和中缓急，意在扶正。佐杏仁、黄芩宣肺气以解郁热，用酒服以行药势。至于"干血痨"的治法，宜根据气血亏损情况，在调补气血的同时，兼进此丸之祛瘀，缓图以冀获效。本案先用归、芍、地黄以濡血之干，鳖甲以软坚消痞，白薇清热凉血，百部、紫菀入肺止咳化痰，甘草和中缓急。俟咳缓、潮热盗汗减，再去百部、紫菀、加入活血祛瘀的红花、琥珀。最后病邪已去，惟余正虚，乃改用柔中之刚的复脉汤以资巩固。此女之幸面得生者，首先应归功于认症明确，治疗得法。其所以能够于短期治愈此难治之痼疾，关键尤在于此女正当发育之年，生机旺盛，又系未婚之室女，斲丧较少，否则是不易短期治愈的。

甘草干姜汤证案（四例）

一、遗　　尿

刘君，30岁，小学教师。患遗尿症甚久，夜则数遗无间，良以为苦。医咸认为肾气虚损，或温肾滋水而用桂附地黄汤；或补肾温涩而用固阴煎；或以脾胃虚寒而用黄芪建中汤，补中益气汤，其它如鹿茸、紫河车、天生礞之类，均曾尝试，有效有不效，久则依然而无法治。细诊其脉，右部寸关皆弱，舌白润无苔，口淡，不咳唾液，口纳略减，小便清长而不时遗，夜为甚，大便溏薄，审系肾脾肺三脏之病。但补脾温肾之药，服之屡矣，所未服者肺经之药耳。景岳云："小水虽利于肾，而肾上连肺，若肺气无权，则肾水终不能摄，故治水者必先治气，治肾者必先治肺。"本症病缘于肾，因知有温肺以化水之治法。又甘草干姜汤原有治遗尿之说。（金匮：肺痿……必遗尿，小便数），遂借用此方，炙草24克，干姜（炮透）9克，一日二帖，三日后，尿遗大减，涎沫亦稀，再服五日，而诸症尽除。

二、劳　淋

农民卿某，以夏日田间劳作，溽暑熏蒸，憩息又多席地

而坐，不免湿热侵袭，遂致淋病。其候小便涩痛，点滴难出，急闷欲死，服寒凉清利药多日，不仅仍涩痛，且时有血渗出，痛楚不堪言状。余按其脉数而无力，口不渴，舌苔白腻且滑，胸痞闷，微咳多涎唾，大便畅，小便涩痛有血，审由劳甚伤于湿热，复损于血所致。……但以服寒凉药多，热已清，湿尚留，治以利湿滋阴疏经和血为宜，处猪苓汤加牛夕、丝瓜络，连进十剂，血痛虽减，淋则依然，且胸满咳痰转增，绎其所以，由于水湿上泛，寒生于肺，上窍不通，下窍难利，故上之咳痰，乃寒而非热，下之淋非热而属湿，其重心不在下焦而在中上二焦，法宜温肺健脾。但二术温燥有伤津液，麻、辛温散有损肺气，因书甘草干姜汤。甘草不但峻补脾土，并有缓急追通水道之功；炮姜温肺涤涎，且具上宣下利之妙。生甘草（连梢用）24克，干姜（炮透）9克，连进五剂，逐渐尿长痛减血止，亦且胸舒涎少。前方既著显效，又服五剂，病遂全愈。后用清和之益气健胃药调理康复。

三、吐　　血

王某，青年工人。素有吐血痼疾，服清凉止涩药辄愈。今夏复发，进前药不应，后杂进温补及消瘀药亦不应，诊时血尚零星未止，色黯而稀，又不时微咳，频唾清涎，口淡，舌润滑无苔，脉濡缓，小便黄，精神好，食纳不佳。然既非热证，栀芩固不可用，又非元阳衰损，卫气不敛，桂附亦属不宜。其脉濡缓，便溏，脾虚未甚，咳频唾涎，肺寒未虚，初拟六君加炒柏叶、炒荆芥之属，五进而血仍吐，……后疏

甘草干姜汤温肺补脾法。炙甘草18克，干姜（炮成炭用）9克，水煎温服四剂，吐血少间。再三剂血全止，后用饮食调养，未另服药。

四、泄　　泻

代儿石珊，端午节伤于饮食，晚间又受风寒，翌日发热恶寒，腹疼泄泻，服发表消导药，表解而泻未止，以为虚复进温补药，泻得止，而腹胀且痛，又服泻药，遂泻而不止。诊其脉弱无力，口淡乏味，舌苔薄白，不干，腹鸣，日泻五六次，不胀不痛，神色饮食均佳，归纳分析病情，乃胃寒而未大虚，不宜参术之补，亦非肠热胃寒，不合三泻心汤寒热杂进之药。……因拟温胃阳补脾虚之甘草干姜汤。药用炙甘草24克，干姜9克（不炮）温煎频服，一日二大剂，泻减效著，连服二日，泻全止，用异功散调理而安。

按：前三例用本汤，干姜均炮，目的在温肺胃而不在救阳，甘草炙用，侧重温补脾胃，惟第二例之甘草生连梢并用，在补脾之中兼具止痛通利作用，同一方又有不同处。第四例是湿寒脾泻，干姜不炮，取辛热燥脾温以行水而止泻，又与前者不同，是在临证时之辨证活用，于此可见经方运用之妙。录自（1962年9期16页《广东中医》赵守真治验案）

延按：甘草干姜汤方。一见于《伤寒论，太阳篇上》29条，治误用桂枝汤后证见厥逆而烦躁吐逆。一见于《金匮·肺痿肺痈咳嗽上气篇》治肺痿属于虚冷之遗尿，案中例一，即根据金匮所述病情而立法处方的。例二，因劳淋而致小便有血渗出，病由劳甚伤于湿热，服寒凉药过多，热去湿

存，故用炮姜以温肺，使上宣则下利，连梢生甘草缓急迫而通水道，深符《素问，至真要大论》“劳者温之”，“急者缓之”之旨。例三，属脾虚肺寒而致吐血，故用补脾温肺法，干姜炮炭，更增强其温经止血之功。例四，属胃肠虚寒之泄泻，因脾未大虚，故不用参术之壅补，仅取理中汤之半，干姜不炮，则辛热止泻力量较强。观此四案，病情虽不同，而属于虚寒所导致则一，故皆以本方治疗，体现了“异病同治”之理。

射干麻黄汤加减证案（五例）

一、肺壅喘咳

“肺胀者，虚满而喘咳”（注），肺为至高之脏，位主上焦，职司清肃。寒客于肺，肺气壅塞，清肃之令不得下行。先哲云：喘咳之为病，在肺为实，在肾为虚，此肺金之实喘也。拟温肺散寒，射干麻黄汤加减。

处方：麻黄　射干　杏仁　甘草　川贝　半夏　橘红　桑皮　款冬花　清炙枇杷叶　录自《清代名医医案精华·丁甘仁医案》注：《灵枢·胀论》

二、风寒犯肺

李××，男，5个月。因发热咳喘已十一天转入某医

院，住院检查：体重6.3公斤，缺氧1度，肺部叩诊浊音，听诊有水泡音，X线发现大片实化。血化验：白细胞总数.200／立方毫米，中性68%，淋巴32%，咽培养：有大肠菌，咽拭子分离为Ⅲ型腺病毒。诊断：腺病毒肺炎并发心衰竭。

病程与治疗：持续高热无汗，四肢不温，咳嗽喘促，音哑，痰阻不利，面青，口周围发绀，呼吸不匀，舌红无苔，脉滑微数。此证虽见舌红脉数，肺阴受伤之候，而高热无汗，面青唇绀，喘咳痰滞，仍属风痰阻塞，肺气郁痹，急宜疏风宣肺开痹。

处方：僵蚕3克　前胡0.24克　牛蒡子　杏仁、竹叶各3克　桔梗　射干各0.24克　甘草0.15克　苇根9克　葱白2寸

4月12日复诊：连服二剂，未获汗，惟四肢转温，表气仍闭，余证不减。遂改用射干麻黄汤加减，开肺宣痹，和胃涤痰。

处方：射干　细辛各0.15克　麻黄0.9克　紫菀0.24克　五味子10粒　半夏　茯苓　化橘红各3克　炙甘草0.15克　炒苏子0.21克　生姜2片　大枣2枚（劈）　再服二剂后，乃获全身漐漐汗出，肺胃和调，诸证渐除，病遂告愈。

按：《素问·热论篇》曾对伤寒热病的治疗提出："……其未满三日者，可汗而已；其满三日者，可泄而已。"这是说明对疾病发展过程，应掌握其当汗、当下之机，乃其常也。本病已越十一天而舌红脉数，肺阴已伤，似不宜汗；但高热无汗，喘促痰滞，面青唇绀，表仍不通，肺气郁痹，故不能不采用急则治标，以辛温开闭取汗，邪去正安，漐漐汗出，

表解而阴存，乃其变也。故临床辨证可不必拘泥病日，不敢取汗，表邪仍在者，亦须解表为要。录自《蒲辅周医案》

三、哮　　喘

刘××，男，15岁。1960年3月2日初诊。自幼几个月时即患哮喘。往年较轻，近二年来加重，遇冷即发。发时，呼吸迫促，胸闷喘咳，痰多，咳甚则吐，头面汗出，不能安卧，不思饮食。现见吸气困难，喉有痰声，颜面浮肿，小便如常。脉象滑而兼数，舌苔白滞。此乃寒饮客肺，久留不去，病发哮喘。拟温肺散寒、祛痰行水、宁嗽定喘为法。

处方：射干　五味各9克　麻黄3克　细辛1.5克　半夏　杏仁　大贝各9克　干姜6克　茯苓15克　炒莱菔子　厚朴各9克　生赭石9克（研）　上方连服两剂，喘定咳轻，痰已大减，亦能卧睡，稍思饮食。上方去赭石，加炒建曲、炙桑皮各9克，又服两剂，诸症基本解除。

四、久　　咳

阎××，男，45岁。1962年1月8日初诊。自诉1948年冬季，不慎重感寒凉，遂咳痰不止，经年不愈，每遇寒凉加重。西医诊为慢性支气管炎。现在咳嗽，痰多不利，痰色白而稠，胸中时常觉闷，入夜尤甚。几天来，因天气较冷，咳嗽剧烈，整夜难寐，影响工作。察其身体消瘦，语言少力；问之，嗜烟，饮食、二便尚可；脉带滑象，舌质偏淡，苔薄白腻。诊为肺素虚寒，痰湿结聚，又兼感受寒凉，病遂加

剧。

处方：射干　五味子各9克　麻黄3克　生姜6克　紫苑　冬花　半夏　杏仁　浙、川贝、炙桑白皮　生石羔各9克，

服上药二剂后，咳嗽顿减，胸不觉闷，夜已成寐，痰少，咳吐亦利。唯素有小便不利之症，今又复发，故将上方加茯苓、泽泻、车前子，又服二剂，小便畅利，痰消咳止。后又照方继服四剂，十余年宿疾，竟获痊愈。

五、百日咳

毕××，男，4岁。1962年冬，患儿病发阵发，将近一月，西医诊断为百日咳。咳时连声不止，气似难接，唇色发绀，喉间痰声漉漉，入夜尤甚。不能平卧，纳食甚少，亦不思饮，面似虚浮，舌苔白滑。

处方：射干　五味子各6克　麻黄1.5克　半夏　大贝杏仁各6克　生姜3克　广皮3克　生石羔　炒莱菔子各6克　茯苓9克　炙桑皮4.5克　元明粉3克（另冲），服药一剂，大便微稀，喉间已无痰声，稍能安卧。服至九剂，阵咳减少，亦思饮食。症状日有缓解，但夜卧仍有不安。后守原方不变，约服至十五、六剂，病方痊愈。

按：方中元明粉分量，当以患儿大便微稀为度。余治本病时，常加用此味而获得满意效果。治疗本病，似不可少。若上方服2～3剂后，咳减不著，即加紫苑、款冬、旋复花、白薇等味以降气止咳，疗效当更迅速。

体　会

射干麻黄汤乃仲景《金匮要略》方，治“咳而上气，喉中水鸡声。”其后，如《方函口诀》用治哮喘；《类聚方广义》治久咳不止或产后喘咳；《圣惠方》治小儿咳嗽，心胸痰壅，攻咽喉作呀呷声等，历代医家，均有发挥。

我们在临床上，凡遇寒饮郁肺，或咳或喘或吐，投以本方，随症加减，多能应手取效。同时也体会到获效关键，应掌握以下辨证要点：①痰多、咳重、胸闷、不渴；②脉或弦或滑或濡，舌苔白腻或滑；③喉中有水鸡声，不得卧，咳则喘甚。其中前两项尤所必具。

依据这些辨证要点来应用本方，随症加减，临证时除酌加杏仁、川贝外，如痰多不利加蒌皮、胸腹闷胀加厚朴、炒莱菔子，气逆呕吐加生赭石，小便不利，加茯苓、泽泻等，对解除病人痰多、咳重、胸闷之痛苦，确有良好疗效。录自（1964年第12期《中医杂志》“射干麻黄汤临床治验体会”张楠　张蕴公　戴甄）

延按：案中例一，系肺实之喘咳，故取方中射干开痰结，麻黄宣肺郁，半夏、冬花止咳化痰外，又恐郁久化热伤肺，故加杏、贝、桑皮、甘草、枇杷叶、橘红等药，以清肃肺热佐以化痰降逆为治。例二，本病由高热无汗引起，故初诊时虽用辛凉轻透之方，究嫌力薄，不能达到开肺宣痹目的，汗不出则热不外达，所以仅四肢转温而余症不减，继用射干麻黄汤加化痰降逆之苏子、橘红等而始获良效。例三、四、五在其体会一栏，已叙述明白，例五用元明粉治小儿百

日咳的临床经验，颇值得玩味。

厚朴麻黄汤证案

咳嗽气喘

朱小祥患咳嗽，恶寒头疼，胸满气急，口燥烦渴，尿短色黄，脉浮而小弱。由邪侵肌表，寒袭肺经，肺与皮毛相表里，故恶寒而咳；浊痰上泛，冲激于肺，以致气机不利，失于宣化，故胸满气促；燥渴为内有郁热，津液不布，因之饮水自救；又痰积中焦，水不运化，上下隔阻，中焦决渎无权，故小便黄短；脉浮则属外邪未解，小弱则因营血亏损，显示脏气之不足。如此寒热错杂内外合邪之候，宜合治不宜分治。要不出疏表利肺降浊升清之法，处以厚朴麻黄汤。麻、石合用，不惟功擅辛凉解表，而且祛痰力巨；朴、杏宽中定喘，辅麻、石以成功；姜、辛、味温肺敛气，功具开阖；半夏降逆散气，调理中焦之湿痰；尤妙小麦一味补正，斡旋其间，相辅相需，以促成健运升降诸作用。药服三剂，喘满得平，外邪解，烦渴止。再二剂，诸恙如失。录自《赵守真治验回忆录》

延按：本方见《金匮·肺痿肺痈咳嗽上气病脉症治》系小青龙加石羔汤之变方，以厚朴、杏仁、小麦、易桂枝、芍药、甘草而成。本案运用此方较恰当。其解释病理及药物组合均佳。

麦门冬汤证案

阴火上冲

梅生苾臣，得冲气病。医人不识，自分必死，每发气上冲，咽喉窒塞，一身振战不已，耸肩目突，不能出声，家人意拟为脱，一日数发，延医丛集，亦称气脱，日进理中，黑锡，缠绵数月，竟服黑锡丸斤许，其病愈进。予诊其脉，右尺数盛，人迎亦大。因思《素问·至真要大论篇》有"诸逆冲上，皆属于火。"之例。遂制滋肾丸，煎金匮肾气（即桂附地黄丸），麦门冬汤吞服。旬日始见微功，一月乃奏全效，未尝更变药味也。　滋肾丸　黄柏　知母　肉桂

麦门冬汤　麦冬　半夏　人参　大枣　甘草　粳米　录自《谢映庐医案》

延按：本案叙述症状，与《金匮，肺痿肺痈咳嗽上气病脉症治》麦门冬汤条文基本相符。原文"大逆"二字，后世注家改为"火逆"，较易理解，当从之。此火是指虚火（即阴火），本方为清养肺胃，止逆下气之剂。用知、柏，当因右尺数盛，又数进理中、黑锡，致热蓄于里之故。用地黄丸以滋肾阴，佐桂附以引火归原。是既救药误，又从纳气之肾的根本上着眼，更见考虑周到，守方一月不变，始奏全功，非有定识定力者不能。

葶苈大枣泻肺汤证案

肺　痈

辛未七月中旬，余治一陈姓疾。初发时，咳嗽，胸中隐隐作痛，痛连缺盆，其所吐者，浊痰腥臭，与悬饮内痛之吐涎沫，固自不同，决为肺痈之始萌。遂以桔梗汤，乘其未集而先排之。进五剂，痛稍止，诸症依然，脉滑实。因思是证确为肺痈之正病，必其肺脏壅阻不通而腐，腐久乃吐脓，所谓久久吐脓如米粥者，治以桔梗汤。今当壅塞之时，不去其壅，反排其腐，何怪其不效也。《淮南子》云：葶苈愈胀，胀者，壅极不通之谓。《金匮》曰：肺痈，喘而不得眠，即胀也。《千金》重申其义曰：肺痈胸满胀，故知葶苈泻肺汤非泻肺也，泻肺中壅胀。今有此证，必用此方，乃以葶苈子15克，大黑枣12枚，凡五进，痛渐止，咳亦爽。其腥臭挟有米粥状之痰，即腐脓也。后乃以《千金》苇茎汤，并以大小蓟、海藻、桔梗、甘草、杜赤豆出入加减成方。至八月朔日，先后凡十五日有奇，用药凡十余剂，始告全瘥。九月底其人偶受寒凉，宿恙又发，乃嘱兼服犀黄醒消丸，以45克分作五服。服后，腥臭全去。但尚有绿色之痰，复制一料服之，乃愈。

按：《要略》曰："风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，口干喘满，咽燥不渴，多唾浊沫，时时振寒，热之所过，血为之凝滞，蓄结痈脓，吐如米粥，始萌可救，脓

成则死。”由此可知肺痈之病源为热，其病状为先唾浊沫，后吐脓血。浊沫者，肺津为热熏灼所成也。脓血者，津尽甚至肺体腐化也。又曰：“咳而胸满，振寒，脉数，咽干，不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈，桔梗汤主之。”。由此可知桔梗汤之所主者，为肺痈之初成，时出浊唾腥臭，必久而久之，方吐脓如米粥，非初时吐脓如米粥也。又曰：“肺痈喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。”又曰：“肺痈，胸满胀，一身面目浮肿，鼻塞，清涕出，不闻香臭酸辛，咳逆上气，喘鸣迫塞者，葶苈大枣泻肺汤主之。”后人见此二条无脓血字样，竟以本方专为逐水之剂，非有脓血也，乃失仲圣原旨矣。夫曰胸满胀，试问其所胀者何物，非肺津肺体化为脓血而何？曰喘鸣迫塞，曰不得卧，试问其故安在，非肺体腐化不能营其呼吸之工作而何？况仲圣之笔法多有详于彼而略于此者。故桔梗汤条既曰久久吐脓如米粥者为肺痈，葶苈大枣汤二条即但言肺痈，面隐含吐脓血于其中矣。又曰：《千金》苇茎汤治咳有微热，烦满，胸中甲错，是为肺痈。”按烦满，读如烦懣，烦懣者，肺中微热之初生，似尚未灼烁肺津为腥臭之浊唾也。故苇茎汤所主之候，还在桔梗汤之前。由是观之，以上三汤，殊有轻重层次之分。苇茎汤最先面轻，桔梗汤为中，葶苈大枣泻肺汤最后而重。录自（曹颖甫《经方实验录》）

延按：本案起到显著疗效的在葶苈大枣泻肺汤方。初用桔梗汤疗效不显，但痛可稍止，以桔梗一物，《本经》载其有“主胸胁痛如刀刺”之功，诸症依然者，以桔梗汤只能开胸膈排脓而去壅塞之力不足，迨服葶苈大枣汤后，痛止咳爽，知其壅阻已通，但峻药中病即止，不宜过量，即转手而

用清热散结，逐瘀排脓之苇茎汤，佐以大小蓟等药，不过增强其破瘀散结排脓之作用而已。善后用犀黄醒消丸，考此两方均载《外科全生集》为活血行瘀解毒消痈之剂。肺痈用此者，因《洄溪医案》在其治肺痈条下说明治疗原则谓："盖余平日因此症甚多，集唐人以来治肺痈之法，用甘凉之药以清其火，滋润之药以养其血，滑降之药以祛其痰，芳香之药以调其气，更以珠黄之药解其毒，金石之药填其空。"犀黄醒消丸，即系金石芳香之药组成，故用之收效。

桔梗汤加味证案

肺　痈

闽侯雪峰林某，患咳嗽，胸中隐隐作痛，经过中西医调治，均不见效。后延余往诊，见其吐痰盈盆，滑如米粥，腥臭难闻，按其右寸脉象滑数，舌苔微绛，查其所服中药，大约清痰降火，大同小异而已。余再三考虑，药尚对症，何以并不见效？必系用量太轻。余照《金匮》甘桔汤加味施以重剂。

处方：甘草120克　桔梗60克　法夏18克　白芨粉15克　蜜紫苑9克

是日下午服药一剂，至夜半已觉胸中痛减，嗽稀痰少。次日早晨复诊，患者自谓病已减轻大半，余复按其两寸脉微数，舌中部微现白苔。患者曰：我服药多次，未见药量如是

之多，见效亦未得如是之速，请问其故？余谓前医轻描淡写，药品驳杂，故难以见功。……次日复诊，予以甘桔汤分量减半，白芨粉再加9克，法夏 紫苑仍旧，连服三剂而愈。录自（《福建中医药》1958，12，“肺痈治验”、林竹均）

延按：桔梗汤方。一见于《伤寒论·少阴篇》311条，为治客热咽痛而设。一见于《金匮·肺痿肺痈咳嗽上气》篇，为治肺痈吐脓如米粥而设，方义是取桔梗排脓，甘草解毒。但本方究嫌药力轻薄，施于轻型的肺痈当有效，如稍重的则疗效不显，所以后世医家治疗此症，每多配合《千金》苇茎汤或加入其他对症药品，本案治例即系加重本方剂量，再加法夏、紫苑 白芨以燥湿祛痰，或止咳化痰，或敛肺消痈等药配合应用来收到治疗效果的。

越婢加半夏汤证案

肺 胀

李士材治孙其芳女，久咳而喘，凡顺气化痰，清金降火之剂，几于遍尝，绝不取效，一日喘甚烦躁，李视其目则胀出，鼻则鼓扇，脉则浮而且大，肺胀无疑矣。遂以越婢加半夏汤投之，一剂而减，再剂而愈。李曰：今虽愈，未可恃也，当以参、术补元，助养金气，使清肃令行，竟因循月余，终不调补，再发而不可救矣。 录自《古今医案按》

延按：此案与《金匮·肺痿肺痈咳嗽上气》篇之肺胀症相符，故投越婢加半夏汤有效，惜未能用补土生金方法善后，终至不救，读此案可见治病只治标不固本之非上策也。

越婢加半夏汤加味证案

风寒犯肺

金××，女，1岁。1964年1月29日初诊。

检查摘要：扁桃腺红肿，两肺布满水泡音。胸透：两肺纹理粗重模糊，并有小型斑点状浸润性阴影，尤以内中带为著，两肺下部有轻度肺气肿，心膈无异常。血化验：白细胞总数11.300／立方毫米，中性79％，淋巴20％，酸性1％。诊断为支气管肺炎。

病程与治疗：患儿发热四天，已服过中西药未效，高热达39.6℃，咳喘气促，腹满膈扇，喉间痰声漉漉，鼻翼煽动，面青唇淡，头汗出，时有烦躁，不欲食奶，大便稀溏，小便黄，脉沉紧，指纹不显，舌质淡苔白，由风寒犯肺，肺气郁闭，治宜辛开，主以越婢加半夏汤加味。

处方：麻黄0.24克　甘草1.5克　生石羔9克　法半夏6克　前胡　炒苏子各3克　生姜3片，大枣2枚

1月30日二诊：服药后，微出汗，热降，烦喘膈扇俱减，大便呈泡沫样，小便微黄，脉浮数，舌淡苔黄腻。肺闭已开，表邪解散，但痰湿尚阻，以理肺化痰为治。

处方：连皮茯苓　法半夏　橘红各3克　甘草1.5克　杏仁　炒苏子　前胡各3克　桑白皮4.5克　炒莱菔子　竹茹各3克　生姜3片

1月31日三诊：体温正常，精神转佳，呼吸微促，喉间尚有少许痰声，大小便同前，食纳尚差，以调和肺胃温化痰湿，前方加厚朴0.24克　麦芽3克

2月1日四诊：唯喉间略有痰声外，余症悉平，继续调和肺胃，兼清伏火。

处方：法半夏　茯苓各3克　陈皮　炒枳壳各1.5克　神曲0.24克　焦山楂　莱菔子（炒）　杏仁各3克　麦芽6克　黄连0.3克　炒苏子0.24克　生姜2片　此方服后，一切恢复正常。

按：本例西医诊断为支气管肺炎。中医诊断为风寒犯肺，肺气郁闭。其症高烧而喘，烦躁而满，面青，脉沉紧，故宗仲景越婢加半夏汤再加前胡、苏子。取麻黄、前胡散表邪，石羔清内热，法夏、苏子降气化痰，姜、枣调和营卫，甘草调和诸药。服后寒开热透，诸症减其大半，继以利湿化痰，调和肺胃而平。录自《蒲辅周医案》

延按：本案所以久治不愈，其原因想系在小儿高烧咳喘时，遽用寒凉退烧药品，将热邪闭伏所致。蒲老据症立方，大胆运用《金匮》方加味，因而获得满意效果。

奔豚汤证案

惊恐奔豚

曹颖甫治平姓妇，其人新产，会有仇家到门寻衅，毁物漫骂，恶声达户外，妇大惊怖，嗣是少腹即有一块，数日后，大小二块，时上时下，腹中剧痛不可忍，日暮即有寒热，予初投以炮姜、熟附、当归、川芎、白芍，二剂稍愈，后投以奔豚汤（注）二剂而消。

注：《金匮·奔豚气病脉症治》　录自《金匮发微》

延按：此案系因情志受到惊恐的刺激而引起奔豚发作，与《伤寒论》所述的奔豚病因不同，故治法亦异，所谓"同病异治"也。方中药品主要从疏解肝邪为着眼点，李根白皮下气，甘草缓急，归、芍、芎和血调肝，黄芩、生葛清热，生姜、半夏降逆，故投之见效。请参阅《古方医案选编》上集桂枝加桂汤证案自明。

括蒌薤白白酒汤证案

胸　痹

曹颖甫治一病者，但言胸背痛，脉之，沉而涩，尺至关上紧，虽无喘息咳吐，其为胸痹，则确然无疑。问其业，则

为缝工，问其病因，则为寒夜伛偻制裘，裘成稍觉胸闷。久乃作痛，予即书括蒌薤白白酒汤（注）授之。

处方：括蒌15克　薤白9克　高粱酒一小杯，二剂而痛止……盖伛偻则胸膈气凝，用力则背毛汗泄，阳气虚而阴气从之也。

注：《金匮·胸痹心痛短气病脉症治》录自《金匮发微》

延按：本症虽无喘息咳吐而仍断为胸痹者，是从问诊得其病因的。方中括蒌开胸中痰结，薤白辛温通阳，豁痰下气，白酒以行药势，具有通阳散结，豁痰下气功效。如兼有痰饮宿疾，症见喘息咳唾，可配合苓桂术甘汤再加干姜、陈皮等药以行阳豁痰，温中理气，更能增强治疗效果。

瓜蒌薤白半夏汤加味证案

胸　痹

苏××女，36岁。1964年4月29日初诊。

症状：心前区阵发性绞痛，发作频繁，每日五～七次，胸痛彻背，牵引肩背及上腹掣痛，胸感发憋气短，指甲发青，略有咳嗽，疼剧时有大汗出……有时恶心，口苦，大便偏干燥，睡眠亦差，形体尚胖，面色苍白，腹不满，卧床不能下地活动已年余，经用各种方法治疗均未见效，病情反日渐加剧，请会诊。脉象寸尺沉弱，右关动数，左关弦细，舌

质略淡，后根苔薄秽腻，月经尚不大差，据病程已久，肝胃失调，心脾不和，阳气不宣，宗气阻滞，以致胸痹绞痛走窜，属胸痹，先宜通阳宣闭，降逆和中。

处方：全瓜蒌（打）18克　薤白9克，枳实（炒）3克　法半夏6克　柴胡　降香各3克，三剂。

二诊：药后心绞痛次数减少，大发作仅两次……脉象寸尺沉细，右关弦缓，左关弦细，舌正红苔秽腻略减，续宜理心气，和胆胃。

处方：茯苓9克，法半夏6克，广陈皮3克，枳实0.24克，竹茹3克，九菖卜　远志各3克，白芥子（炒）4.5克　高良姜3克，炒川楝2枚，麦芽6克，　三剂

三诊：服药后心绞痛很少发作，吃油腻物或牛奶后尚易诱发，右胁疼痛阵发如前，伴有恶心，上肢及下肢经常起紫斑，大便已不干，精神更见好转，脉象左脉渐缓和，右沉细涩，舌正红，腻苔再减，续予原方佐入行气和络之品。

处方：茯苓9克　法半夏6克　广陈皮3克　炒枳实0.24克　九菖卜　炒远志各3克，炒白芥4.5克　炒川楝6克　川芎0.24克　桃仁3克　血竭　琥珀各1.5克　焦楂4.5克　麦芽6克　三剂

四诊：紫斑消退，心绞痛未犯，仍宗原方再服三剂。

五诊：精神更见好转，能下床活动，前天进行肝穿刺，病理变化属迁延性肝炎，现觉胃不舒，泛酸嘈杂，口酸，呕吐一次，大小便正常，出汗较少。脉象两寸尺沉细，右关沉弱，左关弦细涩，舌质正常无苔，由肝胃不调，心气未和，治宜调肝胃，降逆气，佐以养血。

处方：党参4.5克　茯神6克　炒小麦9克，当归、白

芍、熟地各6克　炮狗脊3克　法半夏4.5克　代赭石9克　干姜0.12克　黄连　琥珀各1.5克　沉香0.9克

三个月后再来门诊：心绞痛仅犯过三次，每次疼痛时间较短，疼痛程度亦轻，但仍彻背和向右手臂放射，伴有憋闷感，走路气短头晕，不发时已能稍微活动和散步。右胁下绞痛比较稳定未发，有时腹胀及胃脘疼痛，心情依然很悲观，时时欲哭，睡眠不好，脉象沉细微弦涩，舌质正中心微有秽苔，宜续调肝胆、滋心脾。

处方：炙甘草4.5克　白芍9克　炒小麦12克　大枣4枚　茯苓　枣仁各9克　香橼皮3克　高良姜3克　焦山楂6克　麦芽6克　血琥珀1.5克（冲服）　七剂

次诊：上方随症加减三次，症状趋向稳定，心绞痛很少发，饮食亦好转，唯少腹有时发凉，脉沉细，舌正无苔，续宜强心气，养肝脾以资巩固。

处方：黄芪6克　党参　白术　远志（炒）　炙甘草　白芍各3克　茯苓　熟地各6克　当归4.5克　五味子0.24克　陈皮0.21克　肉桂（后下）0.6克　七剂

最后治疗，朝服养营丸，晚服左归丸各一丸以善后。

按：根据中医审症求因，不外是六淫之邪由表入理，未能及时透邪外出，以致附着脏腑，或内伤七情，以致机体功能紊乱，或两者相合为病，今患者病程已六年，脉寸尺沉弱，体质已虚，而见症皆实，如胸痛彻背，背痛彻心，胸感憋闷，指甲发青，恶心，大便干，右关动数，左关弦细，知其气机闭塞，胸中阳气不宣，急则治标，遂以瓜蒌薤白半夏汤加柴、枳、降香通阳宣闭，调和肝胃。服后疼痛次数及程度皆大减，但停药则发作仍频且甚，右关由动数转弦缓，此

胸阳渐通，气机初启，而心气不足，胆胃未和，故易十味温胆汤加减，益心气，和胆胃，再加高良姜温阳散寒，川楝子降逆清胆，麦芽和胃疏肝。又因上下肢有紫斑，加川芎、桃仁、血竭行瘀和络。至五诊精神好转，能下床活动，但胃尚不舒，泛酸嘈杂或呕吐，改用法夏、干姜、黄连、代赭石、沉香调肝胃，降逆气。用党参、茯苓、小麦、当归、白芍、熟地益心气，养肝血，病情进一步稳定。然而仍见心情悲观，时时欲哭，睡眠欠佳，故用芍药甘草汤合甘麦大枣加味，滋补心肝，健脾和胃，终则改服人参养营丸，后加服左归丸，心肾肝脾并调补其不足以资巩固，遂精神睡眠皆佳，饮食二便正常而告痊愈。

注：本案原文叙述过长，略加删节。录自《蒲辅周医案》

延按：总观蒲老此案，因患者体虚病实，治疗颇不易，故先以宣通胸痹为主，继则随其病势发展情况，或化痰，或消瘀，或补心脾，或调肝胃，俟病情稳定，再以丸剂缓调以善后。

橘枳生姜汤加味证案

胸　痹

《金匮》橘枳生姜汤与茯苓杏仁甘草汤同主胸痹胸中气塞、短气证。《医宗金鉴》认为水盛于气的，主以苓杏甘草

汤；气盛于水的，主以橘枳生姜汤。兹将吾师运用此方加味，治愈历时五年之胸痹证一例，介绍于下。

何××，男，34岁。

主诉：咳嗽已五年，经中西医久治未愈。西医拟诊为支气管炎，屡用棕色合剂、青霉素等药；中医认为"久嗽"，常用半夏露、麦金杏仁糖浆等，皆不效。细询咳虽久而并不剧，痰亦不多；其主要证状为入夜胸中似有气上冲至咽喉，呼呼作声，短气，胃脘胸胁及背部均隐隐作痛，畏寒，纳减，脉迟而细，苔薄白。颇似《金匮》胸痹，胸中气塞、短气证；乃以橘枳生姜汤加味治之。

处方：橘皮　茯苓　姜半夏各12克　炒枳实9克　生姜15克

二诊：服药三剂后，诸症消退，胁背部痛亦止；惟胃脘尚有隐痛，再拟原方出入。

处方：橘皮　生姜　金瓜蒌各12克　炒枳实　薤白各9克　桂枝6克

三诊：五年宿疾，基本痊愈，痛亦缓解，再拟上方去蒌、薤、桂枝，加半夏、茯苓、甘草以善其后。

体　会

此证重点，不在咳嗽而在胸中气塞短气，夜间有气上冲咽喉，以及胃脘胸胁背部之隐痛，实胸痹证之缓者。橘枳生姜汤有辛温通达之力，并有下气之功；加茯苓、半夏、桂枝、薤白、瓜蒌甘草等以化痰、逐饮、温胃之品，肺胃并治，遂获良效。须注意者，橘皮必须重用。录自（中医杂志

1964年第6期“橘枳生姜汤治疗胸痹的体会”。姚国鑫主治，蒋钝儒整理）

延按：本案运用橘枳生姜汤治疗痰饮阻胃，胸闷气塞之胸痹，获得良效。案中对症状，脉舌等叙述较详，可补充金匮条文内容，案中第一诊处方为本方合小半夏加茯苓汤重在痰饮，二诊处方为本方合瓜蒌薤白桂枝汤，治痰饮兼宣胸阳，三诊处方为本方去蒌、薤、桂枝、加茯苓、半夏、甘草仍从治疗痰饮着眼。

乌头赤石脂丸加减证案

寒积胃痛

李××，女，13岁，学生，1963年2月8日就诊。自八岁起患胃痛，屡发屡止，因感受寒邪，胃脘绞痛，牵引胸背，呕吐清水，畏寒肢冷，面色苍白，口唇及爪甲发青，舌苔滑白，脉小面紧。证属阴寒内盛，气滞脘痛。法宜温阳散寒，行气止痛，拟乌头赤石脂丸加减。

处方：制川乌　干姜　川椒　良姜各6克　赤石脂4.5克　广木香3克　服一剂痛大减，二剂痛止，脘满纳差，苔白滑，脉沉紧，改用香砂平胃散加神曲、麦芽、鸡内金、乌药、郁金，三剂病愈。

按：本案为阴寒痛结，复感寒邪，阳气不振，寒结气滞，致脘痛彻背。《金匮要略》说：“心痛彻背，背痛彻

心，乌头赤石脂丸主之。”先取乌头赤石脂丸峻逐阴寒，去附子以防辛热太过，加木香、良姜行气止痛，2剂厥回痛止。续以香砂平胃散加味，温中散寒，化湿健胃而收功。录自（《辽宁中医》1978，4，“胃痛治验”彭述宪）

延按：乌头赤石脂丸，纯为温燥药品组成，虽属寒积胃痛之对症方剂，然峻烈之品，中病即止，不可过量。况本案患者又系一13岁之女孩，阴寒盛又兼气滞，故减方中赤石脂之量，既有乌头，故去附子以防辛热太过，加良姜、广香增强行气止痛之力。最后用香砂平胃以善后。这样既收到温阳散寒行气之益，又避免了辛热过量伤阴之弊。

厚朴七物汤证案

结　肠

关××，男，3个月。

患者其父代诉：日前原因不明的阵发性哭闹，当时腹胀，可能有腹痛，三日间，不大便，吐奶不止，以后吐出黄色如大便样物，此间未曾进食，症状日益加剧。

曾经两个医院诊治，检查腹部可见肠影，腹壁紧张而拒按，经X光腹部单透，发现有液平面6～7个，并充满气体，确诊为完全性肠梗阻，经灌肠下胃管等对症治疗，不见好转，终于决定手术疗法，患者家属考虑到小儿只三个月，不同意手术，而来中医处诊治。

74年4月5日来诊，患儿面色苍白，精神萎靡，时出冷汗，腹胀拒按，大便不通，系脾阳不运，积滞内停所致。以厚朴七物汤治之。

方剂：厚朴10克　桂枝7.5克　甘草　枳实各10克　川军2.5克　生姜5克　按上方顿服一次即效。服药后约1～2小时内，排出脓块样大便，以后两小时内，共排出三次稀便，随着腹胀消失，腹痛减轻。已经十余日，逐渐好转，与健康婴儿无异。

本病多因肠机能不全，复加食积、冷饮、寒邪、蛔虫等结聚，壅滞肠腔，致下焦闭塞不通，不通则痛，呕呃、窒闷等诸症并作。脉微、汗出、舌苔灰白等，因阳气虚，阴寒甚所致。凡机能性肠梗阻多属虚寒，机械性肠梗阻多属寒实，为阳虚阴盛之象。

治疗时应以温药助阳补虚。阳气一振，胃肠机能恢复正常，然滞积阻塞，究属有形，必须通泄，使陈莝速去。

厚朴七物汤，主为解肌发表，疏泄里实。方中厚朴、枳实消痞泻满，佐川军通便导滞，桂枝、甘草、生姜，解表散寒，调和营卫。总之，本汤以行气泄满为主，兼能温中散寒，所以在治疗肠梗阻时，收到可免却手术的疗效。录自（沈阳市老中医经验选编第一集陈会心医案）

延按：厚朴七物汤见《金匮·腹满寒疝宿食病脉症治》篇中，系桂枝汤去芍药与厚朴三物汤两方合剂而成。本案治一三个月男孩的肠梗阻而借用此方收到满意效果，避免了手术治疗，可称善治。查本案所述症状，未有表邪现象，似与金匮条文不符，但其病变的重心在肠部则是一致的。从患儿的面色、精神等观察，都属脾阳不运的征兆。用桂枝汤是取

其内症得之有化气调阴阳之功（去芍药避其阴柔凝滞）非取其解表也，不用大枣，是否惧其甘壅太过，有碍本方通下作用之故欤！

附子粳米汤加味证案

虚 寒 腹 痛

彭君之母，晚餐后夜半腹痛，呕吐不止。煎服姜艾汤，呕痛未少减，且加剧。请诊，思年老腹痛而呕，多属虚寒所致，处以砂半理中汤，服药后痛呕如故，四肢且厥，势甚危迫，急速往。见患者呻吟床第，辗转不宁，呕吐时作，痰涎遍地，唇白面惨，四肢微厥，神疲懒言，舌质白胖，按脉沉而紧。自谓：腹中雷鸣剧痛，胸膈逆满，呕吐不止，尿清长。凭证而论，则为腹中寒气奔迫，上攻胸胁，胃中停水，逆而作呕，阴盛阳衰之候。《灵枢，五邪篇》："邪在脾胃……阳气不足，阴气有余，则寒中肠鸣腹痛。"又《金匮，腹满寒疝宿食病脉症治》："腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满呕吐，附子粳米汤主之。尤在泾注云："下焦浊阴之气，不特肆于阴部，而且逆于阳位，中虚而堤防撤矣。故以附子补阳驱阴，半夏降逆止呕，而尤赖粳米、甘草、大枣培令土厚而使敛阴气也。"本病用此方最恰当，尚恐该汤力过薄弱，再加干姜、茯苓之温中利水，服二帖痛呕均减，再二帖全愈。改给姜附六君子汤补脾肾，调养十余日健复如常。录

自《赵守真治验回忆录》

延按：此案引用《灵枢》《金匮》及尤注以解释病情，甚恰当。分析脉症也非常详尽，可法。

厚朴三物汤加减证案

实 热 胃 痛

陈××，男，43岁，干部，1974年5月3日就诊。胃脘剧痛，腹胀便秘，拒按，口苦，口渴，舌质红，苔黄厚，脉沉数。证属热邪积滞，胃府不通。法当宣滞通便，仿厚朴三物汤法。

处方：厚朴18克　枳实12克　大黄6克（后下），青木香6克　沉香3克　服一剂，大便稀泻二次，其痛大减，脘腹有拘急感，胀满纳差，口微苦，舌苔黄，脉弦略数。改用芍药甘草汤加佛手、化桔皮、山栀、麦芽，服之病愈。

按：本案为实热内积，胃府不通，阻碍气机，因而胃痛便秘。《金匮》："痛而闭者，厚朴三物汤主之。"取厚朴三物汤之行气通便以除里实，加入沉香、青木香调中止痛，故一剂便通滞行。再以芍药甘草汤益脾和中，加山栀泄热，佛手、化桔皮、麦芽畅中开胃，故获速效。录自（《辽宁中医》1978，4，"胃痛治验"，彭述宪）

延按：厚朴三物汤与小承气汤药味相同，不过加重了厚朴剂量。本案由于热积气滞，阻塞胃肠作痛，用本方加二香

宣滞通便，是取通则不痛之义。

大建中汤加减证案（二例）

一、中虚阳气不运

腹中痛甚则有块，平则无形，每每呕吐酸水。此属中虚，阳气不运。当与大建中汤。

党参　蜀椒　干姜　金橘饼

诒按：简明切当，如老吏断狱。

二、阳虚寒疝

中阳虚弱，厥阴寒疝僭逆，腹痛筋急，大便坚结，痛甚则呕吐，拟大建中汤。

川椒　炮姜　党参　附子　半夏　橘饼

诒按：此寒疝证之偏于虚者，故用药专于温理　　录自（柳选《环溪草堂医案》）

延按：例一，用本方去胶饴、加金橘饼，想因呕吐酸水，故去甘壅之饴，而加调气和胃之金橘饼。例二，用本方去胶饴、加附子、半夏、橘饼，易干姜为炮姜，因痛甚则呕吐。考《伤寒论》太阳病篇102条小建中汤后有“呕家不可用建中汤，以甜故也。”所以去甘腻之胶饴，而加半夏、附子、橘饼以增强温运兼镇呕之力耳。

大黄附子汤证案

寒积腹痛

钟大满，腹痛有年，理中四逆辈皆已服之，间或可止。但痛发不常，或一月数发，或两月一发，每痛多为饮食寒冷之所诱致。常以胡椒末用姜汤冲服，痛得暂解。诊之脉沉而弦紧，舌白润无苔，按其腹有微痛，痛时常及腰胁，大便间日一次，少而不畅，小便如常。此系阴寒积聚，非温不能已其寒，非下不能荡其积，是宜温下并行，前服理中辈无效者，仅祛寒而不逐积耳。即与大黄附子汤。（注）

处方：大黄12克　乌附9克　细辛4.5克　服二剂即愈。（注）《金匮，腹满寒疝宿食病脉症治》　录自《赵守真治验回忆录》

延按：本症由于寒实内结肠胃，气机闭阻不通，所以用温而兼补之理中辈仅能缓解，须用温下并行之大黄附子汤始可见功。《千金》之温脾汤（人参　附子　甘草　芒硝　大黄　当归　干姜）即师此意而立法处方的，如遇虚人有积滞应攻补并行者，不妨施用。

当归生姜羊肉汤加味证案

少 腹 绞 痛

周吉人先生内人，冬月产后，少腹绞痛，诸医称为儿枕之患，去瘀之药，屡投愈重，乃至手不可触，痛甚则呕，二便紧急，欲解不畅，且更牵引腰胁俱痛，势颇迫切。急延二医相商，咸议当用峻攻，庶几通则不痛。余曰：形羸气馁，何胜攻击，乃临产胎下，寒入阴中，攻触作痛，故亦拒按，与中寒腹痛无异。然表里俱虚，脉象浮大，法当托里散邪，但气短不续，表药既不可用，而腹痛拒按，补剂亦难遽投，仿仲景寒疝例，与当归生姜羊肉汤，因兼呕吐，略加陈皮、葱白，一服微汗而愈。

处方：当归生姜羊肉汤加味

黄芪　人参　当归　生姜　羊肉（煮汁 煎药）

如恶露不尽，加桂行血。录自《谢映庐医案》

延按：当归生姜羊肉汤见《金匮·腹满寒疝宿食病脉症治》为治"寒疝腹中痛，及胁痛里急"之方。本案由于产后受寒，屡投去瘀药品，致表里俱虚，故宗仲景当归姜羊汤，加参、芪补气，葱白过阳，陈皮和胃止呕，为托里散邪之法，庶病去而正不伤。

乌头桂枝汤证案

寒　疝

袁素珠，青年农妇，体甚健，经期准，已有子女三、四人矣。一日，少腹大痛，筋脉拘急而未少安，虽按亦不住，服行经调气药不止，迁延十余日，病益增剧。诊其脉沉紧，头身痛，肢厥冷，时有汗出，舌润，口不渴，吐清水，不发热而恶寒，脐以下痛，痛剧则冷汗出，常觉有冷气向阴户冲出，痛处喜热敷，此由阴气积于内，寒气抟结而不散，脏腑虚弱，风冷邪气相击，则腹痛里急，而成纯阴无阳之寒疝。窃思该妇经期如常，不属于血凝气滞，亦非伤冷食积，从其脉紧肢厥而知为表里俱寒，，有类于《金匮》之寒疝。本病症状虽与《金匮》寒疝条文略有出入，而阴寒积痛则属一致。因处以乌头桂枝汤①：连进药二帖，痛减厥回，汗止人安。换方当归四逆加吴茱萸生姜汤②以温通经络，清除余寒，病竟愈。　录自《赵守真治验回忆录》

注：①《金匮，腹满寒疝宿食病脉症治》

②《伤寒论》（351）条

延按：本方即桂枝汤加入一味乌头，为《金匮》治寒疝方。案中所述症状，虽与条文不尽相符，但具备了表里俱寒的脉症，而以里寒为主，方中起主要作用的药物仍在乌头。考乌头辛散温通，适于治寒症的心腹剧痛，疝痛。故用后发挥了明显的效果。迨痛减厥回后，再用当归四逆加茱姜汤温通血脉散寒涤饮以善后。

乌头桂枝汤加减证案

历　节　风

何家福妻，年46岁。素因血气虚寒，风挟寒湿，直中血络，游历关节而成。症见历节挛疼，痛不可忍，屈伸不得，难以转移，发作不热，昼静夜剧。脉左浮弦急，右沉弱，舌苔白腻，脉症合参，张仲景所谓："沉即主骨，弱即主筋，""浮则为风，风血相抟，即疼痛如掣"（注），历节痛不可屈伸是也。用乌头桂枝汤加减。

处方：川乌2.4克、生黄芪4.5克、麻黄2.4克、桂枝3克、怀牛夕9克、生白芍4.5克、清炙草2.4克，水两碗，白蜜一匙，煎成一碗，温服。

方以乌头为主，含麻醉性，善能麻痹神经以止痛。辅以托里达表，通行三焦之黄芪，开皮达腠，上行外通之麻黄，使肢节留伏之寒湿一齐外出，佐以桂枝横行手臂，牛夕下行足膝，皆有活血除疼之作用，使以芍、甘、白蜜酸收甘润以监制之。

次诊：前方连服两剂，痛虽渐减，而屈伸不利如前，形气羸弱，颇难支持，脉仍沉弱，惟左手浮弦已减，法当通补兼施，八珍活络汤主之。

处方：丽参须2.4克，茯苓9克，当归9克，酒炒生地6克，薄桂1.5克，生于术4.5克，清炙草1.8克，羌、独活各1.5克，酒炒赤芍4.5克，川芎3克蜜炙，红花1.8克，制川

乌1克，酒水各一碗煎服。叠服四剂，挛痛已除，手足亦可屈伸，人能支持，步履可扶杖而行，遂嘱其服史丞相遇仙酒，一日两次，每服一小酒盅，旬余即痊。

注：《金匮·中风历节病脉症并治》

廉按：金匮要略，分历节病因有四：一因汗出入水中，二因风血相搏，三因饮酒汗出当风，四因饮食味过酸咸。此案即风血相搏，为历节痛风之总因，男妇犯此者最多，《病源》《千金》《外台》均谓之历节风，以其痛循历节，故曰历节风，甚如虎咬，故又曰白虎历节风。初方用乌头桂枝汤，必辨明风挟寒湿，搏其血络，乃可引用。接方用八珍活络汤，亦必其人血气虚寒，始为相宜。 录自《全国名医验案类编·何拯华》

延按：乌头桂枝汤，本为治寒疝之方，因条中有"手足不仁，若身疼痛，"之文，故本案借用以治历节，以其风挟寒湿，痹阻血络较甚，故复于方中加入生黄芪、麻黄以增强其托里达表，开达皮腠之力。又因患者血气素虚寒，故次方以调补气血之八珍汤为主，佐以驱除风湿，疏通血络，麻醉镇痛之羌、独活、红花、川乌等品以善后而收功。

加味旋复花汤证案（四例）

一、气分痹阻

久客劳伤，气分痹阻，则上焦清空诸窍不利。初病在

气，久则入血，身痛目黄，食减形瘦，由病患及乎元虚，攻补未能除病，思人身左升属肝，右降属肺，当两和气血，使升降得宜，若再延捱，必瘀滞日甚，结为腑聚矣。

处方：旋复花汤加桃仁、归须、萎皮，录自《清代名医医案精华·叶天士医案》

二、肝胆气血郁滞

惊惶忿怒，都主肝阳上冒，血沸气滞瘀浊，宜宣通以就下。因误投止塞，旧瘀不清，新血入瘀络中，匝月屡屡反复，究竟肝胆气血皆郁，仍宜条达宣扬……。

处方：旅复花、新绛、青葱管、炒桃仁、柏子仁，《同上》

三、肝郁胁痛久咳

久咳胁痛，不能左侧，病在肝，逆在肺。得之情志，难以骤驱。治法不当求肺，而当求肝。

处方：旋复花、丹皮、桃仁、郁金、猩绛、甘草、牛夕、白芍。

诒按：审证用药，巧力兼到，拟再加青皮，、桑皮、紫苏、山栀、瓦楞子壳，录自（柳选《静香楼医案》）

四、闪挫胁痛

家若谷兄乃郎，感证已逾两旬，胁痛依然不愈，按外感

胁痛，病在少阳，内伤胁痛，病在厥阴。今外邪解经多日，胁痛何以不瘳，既无情志抑郁，定属动作闪力之伤，外邪引发耳，夫久痛在络，络主血，防其蓄瘀动红，从《金匮》肝着例，用旋复花汤一法。

安波按：病久入络，理固宜然，药内再参入搜痰涤饮，则无遗蕴矣。　录自《程杏轩医案辑录》

延按：旋复花汤在《金匮》中凡两见，一在（五脏风寒积聚病脉症并治）一在（妇人杂病脉症并治）药仅三味，即旋复花、葱、新绛，功能下气散结，活血通络。本案例一，注重两和气血，调整升降，故在方中加桃仁、归须、通血络之瘀滞，蒌皮开气分之痹阻。例二，症由惊惶忿怒，导致肝胆气血皆郁，故于方中加桃仁外，再加治惊悸不眠之柏子仁。例三，此症属《素问，咳论篇》肝咳范畴，故用药重在治肝，除方中加入凉血活血舒肝药品外，妙在加柔肝镇痛之芍药，和中缓急之甘草，深合治肝酸收甘缓之旨。例四，闪挫胁痛，病久入络，应加入搜痰涤饮之品，拟借用《温病条辨，下焦篇》之香附旋复花汤主治。

肾着汤证案

寒湿腰痛

李××，男82岁。1972年1月10日，腰痛而重，年老怕冷，脉沉而细，两尺脉尤沉细，舌苔白腻。此为肾家寒湿，

用肾着汤治之。

处方：干姜9克　茯苓　白术各12克，甘草3克，服上方四剂后，腰痛即痊愈。

按：本例脉象沉细，舌苔白腻，形寒怕冷，为寒湿之象。尺脉尤沉细，腰痛而重，属肾家寒湿。《金匮·五脏风寒积聚病脉症并治》说："腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘姜苓术汤（一名肾着汤）主之，"此为古之经验方。　录自（《李斯炽医案》第一辑）

延按：吾师李老，深于《金匮》，案中治法，颇具典型。既不以患者当盛年，而遽用参、芪之补，复不以寒湿凝滞而泛施桂、附之温。但此病既名肾着，何以着眼点不在肾而在脾，仅用干姜、甘草辛甘之品以温健中阳，白术、茯苓苦甘温淡渗之味以补脾利湿呢？此点尤在泾金匮心典中的解释很有参考之价值，他说："肾受冷湿，着而不行，则为肾着，然其病不在肾之中脏而在肾之外腑，故其治法，不在温肾以散寒，而在燥土以胜水，甘姜苓术辛温甘淡，本非肾药，言肾着者，原其病也。"陆渊雷《金匮要略今释》也说："肾在腰部，故腰以下之病症，古人漫称肾病，其实非肾脏病也，此因水气停积于腰部，故腰以下冷痛，如坐水中，水气即湿气，湿胜故身重，腰重如带五千钱也。"所以药只四味，服仅四剂，竟能收到满意的效果，真可谓少一味不可，多一味不必也。方贵对症，药贵专精，读此案益信。

苓桂术甘汤加味证案（二例）

痰　饮

痰饮病，《内经》仅有"积饮"之名，未出治法。张仲景《金匮要略》始将其症治进一步丰富和完整起来，苓桂术甘汤是治疗痰饮的主要方剂之一。《金匮要略·痰饮篇》说："病痰饮者，当以温药和之。"又说："心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。"又说："夫短气有微饮，当从小便去，苓桂术甘汤主之。"个人体会，痰饮较多是阳虚阴盛的病变，以温药和之，也就是离照当空，阴霾自消的意思。但是，痰饮病的临床表现，是多种多样的，故《金匮》有痰饮、悬饮、溢饮、支饮之别，而其原则一。我们临床上依据"以温药和之"，这一原则，运用苓桂术甘汤治疗痰饮，获得较好的疗效。兹将较典型的医案，附列于下，以资探讨。

1．全××，男，35岁。左腿患结核性骨炎，并已形成瘘管，气营两损，精神萎顿。局部病灶虽经手术治疗，但术后第三天，突发寒热，头眩且痛，恶心频作，喉间及胸中自觉有寒痰凝滞，喘满不舒，纳减。经服疏解药未效。呕恶反增，喘满益剧。转余诊时，形寒未罢，但不发热，呕逆多白沫，胸痞且寒，微咳起坐则头晕目眩，冲气上逆，心下悸，夜不成寐，人形瘦削，舌苔白腻，中有剥痕，脉象濡细。显为脾阳不运，胃失降和，以致水饮内阻，阴邪锢结。乃拟苓

桂术甘汤佐燥湿降逆之剂。方用：肉桂0.6克，茯苓12克，焦白术、潞党参各9克，吴萸、厚朴各0.24克，半夏6克，炙甘草3克，生姜4片，大枣4枚，玉枢丹0.12克，（先送下）。先后连诊二次，服上方加减八剂，呕逆即除，胸痞亦减，继进益气补血之剂，以善其后。

2．陈××，女，41岁。患者体质素弱，且易恼怒。头晕目眩，神疲气短，时轻时作。近来喘咳加频，晨间更剧，眼睑及四肢出现轻度浮肿，胸痞腹满，心悸，背寒，纳呆，溲减。诊视舌苔白腻，脉象沉弦带数。肺气肃降不利，脾阳转输无权，痰聚气阻，酿成饮症。拟苓桂术甘汤合厚朴半夏汤加减，以疏调气机，温化饮邪。

处方：茯苓12克，桂枝4.5克，冬术、泽泻各9克，姜半夏6克，厚朴、苏叶各0.24克，炙甘草3克，生姜汁半小杯（分二次冲）。上药连服四剂，喘咳减轻，溲多，胸腹痞满亦除，嗣以温胆汤等调理而愈。

综上两案，咳逆，呕恶，头眩，身寒，胸痞，心悸，为其共有的见症。……试观本方二案，前者系病久气营两损，加以手术前后精神紧张；后者体质素弱，抑郁气机，其致病之因虽异，而其病机，则同为脾阳不振，胃失降和，津液不通，聚成痰饮，上凌心肺者一也。……苓桂术甘汤的作用，是温运脾阳，调适三焦，故为痰饮治本之方。由于例一系因术后气血虚，苔白而中有剥痕，故以肉桂代桂枝，配参、夏、姜、草、枣之健脾益气，取补气以生血之义。但呕逆不止，是浊邪壅结之症，急者治标，在所必施。故佐玉枢丹之宣壅化浊，标本兼顾。例二，为气机不利，卫阳式微，浊饮上凌，喘肿并作，故以苓桂术甘汤之温运外，合厚朴半夏汤

之调气畅中，亦脏腑同治之意。……从本文两案来看，虽均为痰饮，各以苓桂术甘汤为基础方剂，但其因不同，现症各有特殊，故配佐之方，亦各异趣。由此可见，审证求因，是临床上值得注意的问题。录自（《浙江中医杂志》七卷，二号“苓桂术甘汤治疗痰饮的体会”林文增）

延按：苓桂术甘汤方，一见于《伤寒论》太阳篇67条，一见于《金匮》痰饮篇中，本案就是根据《金匮》的理论指导结合疾病的具体情况来立法处方的。案中对脉症的叙述，病机的分析，方剂的化裁，均较详尽，可供临床参考。

甘遂半夏汤证案（二例）

一、留　　饮

吴孚先治西商王某，气体甚厚，病留饮，得利反快，心下续坚满，鼻色鲜明，脉沉，此留饮去而不能尽去也。用甘遂、甘草、半夏、白芍，加白蜜五匙顿服，前症悉除。或问：甘遂与甘草，其性相反，用之无害而反奏效，何也？曰：正取其性之相反，使自相攻击，以成疏瀹决排之功。（西人赋性厚，尤当用之）录自《续名医类案》

二、留饮胃痛

张女小菊，14岁。前以伤食胀满作痛，服平胃散加查、曲、谷、麦芽之类得愈。未期月，胃又胀痛而呕，有上下走

痛感觉，但便后可稍减，再服前方不验，辗转半年未愈。其症胃胀痛，绵绵无休止，间作阵痛，痛则苦不可言，手不可近。服破血行气药，不惟不减，且致不饮食。此病既非气血凝滞，亦非食停中焦，而为痰积作痛，即《金匮》之留饮症也。盖其痰饮停于胃而不及于胸胁，则非十枣汤所宜。若从其胃胀痛利反快而言，又当以甘遂半夏汤主之。方中半夏温胃散痰，甘遂逐水，又恐甘遂药力过峻，佐白蜜、甘草之甘以缓其势，复用芍药之苦以安中。虽甘草、甘遂相反，而实则相激以相成，盖欲其一战而逐尽留饮也。服后痛转剧，顷而下利数行，痛胀遂减，再剂全瘳。录自《赵守真治验回忆录》

延按：本方见《金匮·痰饮咳嗽病脉症并治》案中两例所述病状，基本上与留饮症相符，所以均用此方。例一，补述了鼻色鲜明，脉沉，更较全面具体，又因西人禀厚质壮，故非借此疏瀹排决之剂不易见功。例二，初服消食药治其致病之原，故效。继则病情变化，仍用前方故无效。至用破血行气药，则属南辕北辙，诛罚无过，所以痛更加剧。最后认定留饮停胃作痛，从根本上着眼，才收到满意的效果。

又按：本方的煮药法，据《千金》记载：应甘遂半夏同煮，芍药与甘草同煮，最后将二汁加蜜合煮，顿服，较安全无弊。特录出以供临床运用时参考。

十 枣 汤 证 案

悬 饮

宋子载之妻年已望五，素病胸膈胀痛，或五六日不得大解，夜睡初醒，则咽燥舌干。医家或以为浮火，或指为肝气，花粉、连翘、玉竹、麦冬、山栀之属，多至卅余剂。沉香、青皮、木香、白芍之属，亦不下十余方。二年以来，迄无小效。去年四月，延余诊治。余诊其脉双弦，曰：此痰饮也。因用细辛、干姜等，以副仲师温药和之之义。宋见方甚为迟疑。曰：前医用清润之品，尚不免咽中干燥，况于温药？余曰：服此当反不渴，……一剂而渴止。惟胸膈胀痛如故，余因《金匮》悬饮内痛者用十枣汤下之，遂书：制甘遂大戟 炙芫花各3克 用十枣浓煎为汤，去滓令服，如《金匮》法，并开明每服一钱。……令减半服之，不下。……因令再进一钱，日晡始下，胸膈始宽，然大便干燥，痰未下。因令加芒硝9克，使于明早如法服之。三日后，复延余诊，知其下甚畅，粪中多痰涎。遂令暂行停药，日饮糜粥以养之。此时病者眠食安适，步履轻捷。余按十枣汤一方，医家多畏其猛峻，然余用之屡效，今存此案，非惟表经方之功，亦以启世俗之蔽也。录自（曹颖甫《经方实验录》）

延按：见咽燥舌干，即投清润，见胸膈胀痛，即施理气。不知此干燥，是饮阻津不上潮，胀痛是水阻胸膈，阳不宣畅，所以无效。一用干姜、细辛等之温开而渴止，用十枣汤

之逐水而胸膈通畅，病遂以瘳。观此可知治病求本之重要性。请参阅本书上集十枣汤证条。

木防己汤加茯苓证案

痰饮胸痛

刘翁，年近古稀，酷嗜酒，体肥胖，精神奕奕，因长子病逝，家境日转恶化，胸襟因而不舒，发生咳嗽，每晨须吐痰数口，膈上始宽，但仍嗜酒，借资排遣。昨饮邻居，以酒过量而大吐，遂病；胸膈痞痛，时吐涎沫。医用涤痰汤有时稍安，旋又复作，渐至面色黧黑，喘满不宁，形体日瘠，神困饮少，犹能饮，因循数月，始觉不支。诊脉沉弦无力，自言膈间胀痛，吐痰略松，已数日未饮酒，食亦不思，夜间口干燥，心烦难寐，按其心下似痛非痛，随有痰涎吐出；再从脉沉弦与胸胀痛而论，实为痰饮弥漫胸胃之间而作痛。再据病理分析，其人嗜酒则湿多，湿停于胃而不化，水冲于肺则发喘，阴不降则阳不升，水势泛滥故面黧，湿以久郁而化热，津不输布故口渴。考《金匮》木防己汤于本证适合，方为防己　党参各12克　石羔18克　桂枝6克　另加茯苓15克增强燥脾利水功能而大其效。三剂喘平，夜能成寐，舌现和润，胸膈略舒，痰吐亦少，尚不思食，复于前方去石羔，加佛手、砂仁、鸡内金调气开胃。又四剂各证递减，食亦知味，精神转佳，惟膈间略有不适而已。善后给《外台》茯苓

饮（茯苓　人参　枳实　白术　橘皮　生姜）调理。录自《赵守真治验回忆录》

延按：本案患者，因年高体丰而嗜酒，为痰湿素盛之体无疑。根据出现症状，给以本方较恰当。因水与气互结，故用防已、桂枝行水饮而散结气，因湿郁久化热，故用石羔以清郁热，因年高病久体虚，故用人参扶正补虚。但本症水湿太甚，方中药品，究嫌行水力弱，故于方中加甘淡利水而不伤中之茯苓，以增强燥脾利水之功。再剂因郁热已解，气机尚不畅，故去石羔，加佛手、砂仁、鸡内金调气开胃。此症主要系水为患，观其善后方用《外台》茯苓饮，其着眼于水饮可知。后世《温病条辨》中的加减木防已汤，即系本方去人参、加杏仁、苡仁、滑石、白通草，用治暑湿成痹，更见化裁之妙。

白术泽泻汤证案（二例）

一、眩冒昏迷

陈，51岁。人尚未老，阳痿多年，眩冒昏迷，胸中如伤油腻状，饮水多则胃不快，此状饮眩冒症也。先与白术泽泻汤逐其饮，再议缓治湿热之阳痿，岂有六脉俱弦细，而恣用熟地久服六味之理哉。

处方：冬于术60克，泽泻60克，

煮三杯，分三次服。已效而未尽除，再服原方十数帖而

愈。

二、眩　　冒

昆，42岁。饮家眩冒，用白术泽泻汤法。脉洪滑而沉。

处方：半夏　茯苓各30克，泽泻60克，白术30克，小枳实9克，　甘澜水八碗，煮取三碗，渣再煮一碗，分四次服。

次诊：于前方内加竹茹18克，生姜汁每杯冲三小匙。

三诊：脉沉微数。

处方：于术30克，半夏、竹茹各30克，泽泻60克，茯苓块30克　甘澜水八碗，煮取三碗，渣再煮一碗，分四次服。

丸方：半夏　泽泻　天麻各240克，茯苓　白术各180克，共为细末，神曲糊姜汁为丸，如桐子大，每服9克，日再服，重则三服。录自《吴鞠通医案》

延按：本案例一，眩冒昏迷，六脉弦细，由伏饮所致，饮为阴邪，治在通阳，（通阳不在温，而在利小便，叶天士外感温热论中语）。故借用《金匮·痰饮咳嗽病脉症并治》篇中之泽泻汤，虽药仅二味，以泽泻利水除饮，白术补脾制水，药用重量，服十数帖不易方，由于见之真、故认之确，力专功宏，所以获效。例二，虽同属饮家眩冒，但脉洪滑而沉或微数，有痰热互阻之象。故用白术、泽泻外，并随症佐入半夏、茯苓、竹茹、生姜汁等通络豁痰之品，更见考虑周到。

己椒苈黄丸证案

水　臌

朱成，男，25岁。春患风寒咳嗽，寝至全身浮肿，医用开鬼门法①浮肿全消，但咳嗽仍紧，腹感满胀，又用六君子汤加姜、辛、味温肺健脾，咳得减而腹更胀大，行动则气促，易医亦认为虚，疏实脾饮，服后胀不减，胸亦甚觉痞满。经治十余日无效，迁延半年，腹大如鼓。按脉沉实，面目浮肿，口舌干燥，却不渴，腹大如瓮，有时鸣声胀满，延及膻中，小便黄短，大便燥结，数日一行，起居饮食尚好，殊无羸状。审病起源风寒，太阳之表邪未尽，水气留滞，不能由肺外散，反而逐渐深入中焦，与太阴之湿混合为一，并走肠间，漉漉有声，而三焦决渎无权，不从膀胱气化而外溢，积蓄胃肠而成水臌。当趁其体未虚，乘时而攻去之。依《金匮》法，处已椒苈黄丸（改汤），以防己、椒目行水，葶苈泻肺，大黄清肠胃积热，可收到快利之效。药后水泻数次，腹胀得减。再二剂，下利尤甚，腹又逐消，小便尚不长，用扶脾利水滋阴之法，改服茯苓导水汤②，配吞六味地黄丸，旬日而瘥。

注：①开鬼门，发汗的意思。见《素问·汤液醪醴论》

②《证治准绳》方（赤苓、麦冬、泽泻、白术、桑白皮、紫苏、槟榔、木瓜、大腹皮、陈皮、木香、砂仁、灯心）　录自《赵守真治验回忆录》

延按：本方见《金匮·痰饮咳嗽病脉症并治》案中分析病理，描述脉症，及治疗经过，非常详尽，善后用扶脾利水滋阴法，尤见考虑周到，深得治实防虚之旨。

小半夏加茯苓汤证案

水 气 头 汗

傅金生，时当暑月，天气亢燥，饮水过多，得胸痛病，大汗呕吐不止。视之口不渴，脉不躁，投以温胃之剂，胸痛遂愈，而呕吐未除，自汗头眩加甚，再以温胃方加黄芪与服。服后亦不见躁，惟汗出抹拭不逮，稍动则眩晕难支，心下悸动。举家咸以为脱，吾许以一剂立愈，以半夏15克，茯苓9克，生姜1片，令即煎服，少顷汗收呕止，头眩心悸顿除。

原按：此症缘饮水过多，水停心下，火位不安，故惕惕悸动，本仅当心下作痞，兹以阳气素虚，更重为心下作痛，所以前投温胃之剂，助阳消寒，其痛自除，但水饮犹未下耳。水气上逆，则呕吐不止，水气上干，则汗眩难支，举以小半夏加茯苓汤，行水散逆，使水下行，则呕悸汗眩俱止，所谓治得其法，汗自敛耳。录自《谢映庐医案》

延按：此症头汗眩晕，得之饮水过多，水气上逆所致，故从根本治疗，不用敛汗之剂，而施行水散逆之法。处以本方，药仅三味，服仅一剂，即收到满意的效果。可见药贵对

症，不贵多也。

苓甘五味姜辛半夏汤证案

支　饮

曹颖甫治宋姓妇人，病者平时常患口燥，所服方剂，大率不外生地、石斛、麦冬、玉竹、知母、花粉、西洋参之类。予见其咳吐涎沫，脉弦而体肥，决为痰饮，授以此方(注)，服后，终日不曾饮水，略无所苦，乃知仲师渴反止为支饮之说，信而有征也。

注：《金匮·痰饮咳嗽病脉症治》　录自《金匮发微》

延按：本症之渴，由于饮邪阻抑津液不能上升所致，非热盛伤津可比。故用清热生津药无效，其舌苔多白滑，渴必喜热饮，案中对支饮服热药渴反止之理论，得曹案临床实践加以证明，更具有说服力。

括蒌瞿麦散（丸）加味证案

癃　闭

湘乡成××，初患淋症，继则点滴不通，探其脉象，左

手沉缓，余拟用括蒌瞿麦散加车前子9克，牛夕9克，服三剂后，小便涌出如泉矣。录自（《湖南中医医案选编》第一剂，湘潭，朱卓夫）

延按：括蒌瞿麦丸方，见《金匮·消渴小便不利淋病脉症并治》篇，治"小便不利者，有水气，其人苦渴。"本案初因患淋而小便不通，脉象左手沉缓，属肾虚而膀胱气化不行所导致，仍用本方之括蒌、薯蓣养阴润燥，瞿麦、茯苓渗泻利水，用炮附子者，因其肾气虚衰，借此味以温阳化气，盖仿肾气丸之变制耳。案中不言渴者，以病势浅，津液尚可蒸腾上达，故药仅三剂而小便自通。加车前、牛夕，不过增强其下行利尿之力尔。

蒲灰散证案

皮　水

王一仁在广益医院治病，有钱姓男子，腹如鼓，股大如五斗瓮，臂如车轴之心，头面皆肿，遍体如冰，气咻咻若不续，见者皆曰必死。一仁商于刘仲华，取药房中干菖卜一巨捆，炽炭焚之，得灰150克，随用滑石和研，用麻油调涂遍体，以开水调服3克，日三服，明中肿减大半，一仁见有效，益厚涂之，改服6克，日三服，三日而肿全消，饮食谈笑如常人，乃知经方之妙，不可思议也。　录自曹颖甫《金匮发微》

延按：蒲灰散方条文，在《金匮》中凡两见，一见（消渴小便不利淋病脉症并治）篇，治小便不利，茎中疼痛，小腹急痛，有化瘀利窍泄热的功效。一见（水气病脉症并治）篇，治“厥而皮水”，本案系根据治皮水条文来进行治疗的。曹颖甫氏说：“世皆论蒲灰为蒲黄，其实不然……此厥字即上文身肿而冷之冷……蒲灰即溪涧中大菖卜叶，味咸能降，味辛能开……前数年予在家乡治谢姓小儿，茎及睾丸，明若水碧，令制而服之，一夕得小便甚多，其肿即消，惟腹满不减，继以姜、辛、术、附，闻此儿已14岁矣。又治宋姓小儿水肿亦用之，但其手足不冷，小便清，内服麻辛附子汤，佐以五苓，冬葵子、车前子，外敷蒲灰散，早夜调服3克，五日而肿全消，每一日夜小溲十七八次云。”观此可见蒲灰散之作用，既能治皮水，又能通利小便，诚一简、便、验之良方。

越婢加术汤证案

风　水

陈修孟，男，25岁，缝纫业。途中遇大雨，衣履尽湿，归即浴身换衣，三日后，发热，恶寒，头疼，身痛，行动沉重。医与发散药，得微汗，表未尽解，即停药。未数日，竟全身浮肿，按处凹陷，久而始复，恶风身疼无汗。医又与苏杏五皮饮，肿未轻减，改服五苓散，病如故。诊时详问病因

及服药经过，认为风水停留肌腠所致，本证先由寒湿而起，皮肤之表未解，郁发水肿。诊脉浮紧，恶风无汗，身沉重，口舌干燥，有湿郁化热现象。既非防已黄芪汤之虚证，亦非麻黄加术汤之表实证，乃一外寒湿而内郁热之越婢加术汤证。宜解表与清里同治，使寒湿与热均从汗解，其肿自消。方中重用麻黄45克，直解表邪，苍术12克燥湿，姜皮9克走表行气，资助麻黄发散，石羔30克清理内热，并制抑麻黄之辛而合力疏表，大枣、甘草各9克，和中扶正，温服一剂，卧厚覆，汗出如洗，易衣数次，肿消大半。再剂汗仍大，身肿全消，竟此霍然。此属重证，又属青年体气壮实，故治如此。若仅寻常外邪，又以小量微汗为宜，否则易导致漏汗阳虚等证，不可不知　录自《赵守真治验回忆录》

延按：本方见《金匮·中风历节病脉症并治》案中以苍术易白术，增强其燥湿之力，以姜皮易生姜，加速其走表行气之功，对于外有寒湿内有郁热之风水肿胀，确能收到因势利导的效果。

越婢加术汤法证案

水　肿

兰女，14岁。脉数，水气由面肿至足心……议腰以上肿当发汗例。越婢加术汤法。

处方：麻黄（去节）15克，白术9克，杏仁泥15克，石

羔18克，桂枝9克，炙甘草3克，

水五杯，煮取二杯，先服一杯，得汗止后服，不汗再服。

次诊：处方：生石羔24克，麻黄（去节）9克，生姜3片，炙甘草6克，杏仁泥15克，桂枝6克，大枣（去核）2枚。

水八杯，煮取三杯，分三次服，以汗出至足为度，又不可使汗淋漓。

三诊：水气由头面肿至足下，与越婢法，上身之肿，已消其半，兹脉沉而数，以凉淡复微苦利其小便。

处方：飞滑石15克，生苡仁15克，杏仁9克，茯苓皮18克，黄柏炭3克，海金沙18克，泽泻9克，白通花9克，不能减咸，不必服药。　录自《吴鞠通医案》

延按：本案由水气阻滞，表里不通，不能分消走泄而形成此症。故采用发汗利小便法。初服两方，为越婢汤加减，重在发汗；服后上身之肿已消其半，继用利小便法消其下肿。深得《素问·汤液醪醴论》"开鬼门，洁净府"之旨。

茵陈蒿汤加味证案

阳明发黄

张明敏，男，11岁。

病因：湿热熏蒸，发为阳黄。

症候、面目发黄，咳嗽，呕水，大便干燥，小便红赤。

诊断：舌黄而燥，脉缓而滑。

疗法：《金匮》云："黄家所得，从湿得之。"今胃府湿热上越侵肺，致发黄而兼咳嗽。《素问·平人气象论》云："缓而滑曰热中。"治宜茵陈蒿汤泄热利尿。

处方：茵陈45克　栀子12克　大黄9克　川郁金3克　香豉6克　黄柏　杏仁各4.5克　黄芩6克　枇杷叶9克　白毛藤60克

二诊：服药以后多次吐水，黄疸加重，腹痛拒按，二便不通，脉息缓滑，舌苔仍黄，这是湿热不得外泄现象，所以腹痛拒按，吐水，仍用前方加重剂量治疗。

处方：茵陈蒿汤84克　黄芩　黄柏各9克　黄连4.5克　白毛藤90克　连服二剂。

三诊：腹痛呕吐均已停止，大便已通，小便清利，身黄亦退，但肝区还有触痛。仍用前方加郁金启膈，川朴导滞，甘露消毒丹泄秽。

四诊：呕吐全平，脉尚缓滑，舌苔微黄，此胃中热邪未尽之故。仍用茵陈蒿汤120克　川郁金4.5克　槟榔9克　川朴3克　白毛藤60克　连服三剂后痊愈。录自（《福建中医医案医话选编》陈逸园）

延按：茵陈蒿汤为《金匮》中治"谷疸"方。本案虽非"谷疸"，然湿热壅阻肺胃不得下行之病因则一。故仍用此方以泄热逐秽。案中以茵陈蒿汤为主，初诊时因病重药轻，不能制其猖獗之势，病情反而更甚。以后逐渐加重本方剂量，并配合导滞泄秽之药，症状因之缓解，在此紧要关头，并不考虑年龄幼稚，而毅然投以大剂，若非医者具有定识定力，很难挽救如此重症。考白毛藤一药，据《中国医学大辞

典》载：谓其能清湿热、治黄疸，甘露消毒丹为叶天士治湿温时疫之方。载《温热经纬》方论中。

茵陈五苓散加味证案

湿热发黄

衡阳市李××，患黄疸病，久治无效，病更加剧。求治于余，察其面容黄黑，身重体倦，小便短涩而黄，大便秘结，此系受湿太重，郁久而从热化。李自以为睡楼上，从何受湿，请余至寝室察看，见室内一竹床，被汗浸渍，竹老红色，问其是否睡此床上，答以去年夏天酷热，整整睡过一个热天，余谓病源起于此。方用茵陈五苓散去白术，加生苡仁、厚朴、五加皮，服两剂，面上黄渐散，五剂后，眼内及指甲上黄色尽退，面转光泽。惟食量不佳，大便仍结，再以龙胆泻肝汤加大黄、芒硝，服后下黑色秽物如鱼脑水者甚多，食量增，而病根永绝。录自（《湖南中医医案选辑》衡阳·刘华田）

延按：茵陈五苓散在《金匮》中虽列为治湿热黄疸的正治法。但只能治湿重而热不甚的黄疸。本案所述症状，由受湿太重，郁久化热自应以治湿为主。故选用本方，因方中白术有壅气留湿之弊，故去此味而加苡仁、五加皮宣畅经络之湿，厚朴湿通中焦之湿，迨湿开热化，始用清利湿热之龙胆泻肝汤加硝、黄，使湿热从大便排泄，湿热一去，则病根拔矣。

侧柏叶汤证案

吐　血

段××男，38岁。1960年10月1日初诊。旧有胃溃疡病，并有胃出血史，前二十日大便检查潜血阳性，近因过度疲劳，加之公出逢大雨受冷，饮葡萄酒一杯后，突然发生吐血不止，精神萎靡，急送某医院检查为胃出血，经住院治疗两日，大口吐血仍不止，恐导致胃穿孔，患者家属不同意施行手术，请会诊。询其原因由受寒饮酒致血上溢，未可以凉药止血。宜用《金匮要略》侧柏叶汤，温通胃阳，消瘀止血。

处方：侧柏叶9克　炮干姜6克　艾叶6克　浓煎取汁，兑童便60毫升，频频服之。次晨往诊，吐血渐止，脉沉细涩，舌质淡，无苔，原方再进，加西洋乡12克益气摄血，三七6克（研末吞）止血消瘀，频频服之。次日复诊，血止，神安欲寝，知饥思食，并转矢气，脉两寸微，关尺沉弱，舌质淡无苔，此乃气弱血虚之象，但在大失血之后，脉症相符为吉，治宜温运脾阳，并养营血，佐以消瘀。主以理中汤，加归、芎补血，佐以三七消瘀。服后微有头晕耳鸣，脉细数，此为虚热上冲致致，于前方内加入地骨皮6克，藕节9克，浓煎取汁，仍兑童便60毫升续服。

再诊：诸症悉平，脉亦缓和，纳谷增加，但转矢气而无大便，继宜益气补血，养阴润燥兼消瘀之剂。

处方：白人乡9克　柏子仁6克　肉苁蓉12克　火麻仁

12克（打） 甜当归6克 藕节15克，新会皮 山查肉各3克 浓煎取汁，清阿胶12克（烊化）和童便60毫升内入。分四次温服。服后宿粪渐下，食眠俱佳，大便检查潜血阴性，嘱其停药，以饮食调养，逐渐恢复健康。

按：本例旧有胃损之症，素不饮酒，骤因受寒饮酒，寒热相攻，致血上溢，非热极吐血可比，故主以温降之法，采用侧柏叶汤。柏叶轻清，气香味甘，能清热止血，佐以姜、艾辛温，合以童便咸寒降逆消瘀，温通清降并行，故服后血即渐止。再剂加三七、洋参消瘀止血，因而得以避免手术。继以理中法温运脾阳，服后微见头晕耳鸣，知其虚热上冲，则佐以地骨皮凉血不滞，藕节通络消瘀，使以童便降火，服后诸症悉平，脉和睡安，终以益气补血，滋阴润燥而善其后。录自《蒲辅周医案》

延按：侧柏叶汤，见《金匮，惊悸吐衄下血胸满瘀血病症治》考原方系用马通（即马尿）合则代以童便，取其较马通易觅也。案中当吐血不止时，采用频频服药法甚妙。又理中汤方内之干姜，余意改用黑姜，止血效果较好。

黄土汤加味证案（四例）

1．粪后便血

粪后便血，责之小肠寒湿，不与粪前为大肠热湿同科。举世业医者不知有此，无怪乎数年不愈也，用古法黄土汤。

处方：灶中黄土、生地、黄芩、制苍术、阿胶、甘草、熟附子、白芍、全归，录自《清代名医医案精华·吴鞠通医案》

2．便血夹湿热

阴络伤则血内溢(注)。为日已久，阴分固伤，阳分亦弱，而身中素有之湿热，仍未清楚，恐增浮喘。处方：大熟地、伏龙肝（即灶心土）、阿胶、白术、赤小豆、附子、黄芩、炙草、当归、地榆炭、乌梅肉。

注：《灵枢，百病始生第六十六》"阴络伤则血内溢，血内溢则后血。"

延按：此《金匮》黄土汤加味，阴阳并治而兼清湿热，立方颇为周到。

3．便血肿胀

湿热伤营，腹臌便血，久而不愈。左脉细涩，右芤，寸大尺小，加以浮肿，气分亦虚，不但不能摄血，而且不能清化湿热、防喘。

处方：黄土汤加大腹皮、五加皮、桑皮、党参、槐花，

原注：原方之妙，附子扶脾之母，黄芩清肝之热，熟地滋肾之阴，白术培脾之本，阿胶凉血之热，各脏照顾，非仲景不能作也。

延按：增入之药，亦能与病机恰当，录自（柳选《继志堂医案》）

4．便血

吉××女，58岁。患者大便后流鲜血，或无大便亦流大量鲜血。每次流血量约1～2茶碗之多，每日二～三次，已二十余日。两少腹有隐痛，自觉头晕心慌，气短自汗，脸肿，饮食尚可，素有失眠及关节疼痛，月经已停止二年。脉沉数，舌微淡无苔，《素问，阴阳别论》谓："结阴者，便血一升，再结二升，三结三升。"以阴气内结，不得外行，血无所禀，渗入肠间，今去血过多，治宜温养脾肾，方用《金匮要略》黄土汤加味：处方：熟地30克　白术18克　炙甘草18克　黑附子9克　黄芩6克　阿胶15克　侧柏叶炒9克　黄土60克　用开水泡黄土，澄清取水煎药，服二剂。复诊时，服上方已有好转，昨日大便三次，只有一次流血，今日又便后流血一次，仍有心跳气短，已无头晕及自汗出，饮食尚可，眠佳，舌无苔，脉仍沉数，原方再服三剂。　三诊：便血已很少，心跳气短亦减，舌薄苔微黄，脉如前。此症血虽渐止，但日久伤血，中气亦伤，仍宜益气滋阴补血以资善后。处方：生黄芪15克　当归6克　干地黄12克　阿胶9克　甘草6克　生地榆　侧柏叶（炒）各6克　黄芩4.5克　炒槐花　地骨皮各6克　五剂。三个月随访，未再便血，心跳气短亦较前为佳。

按：古之所谓结阴，即今之所谓便血。《金匮要略》："下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之。"黄土性温入脾，合白术、附子以复健行之气，血得温即循经而行；又用阿胶、地黄、甘草，滋肾以益脱竭之血。又虑辛温之品，易致出血，故又以黄芩之苦寒制之，本例采用全方再加侧柏

叶，增强止血作用。善用经方者，常能应手而效。录自《蒲辅周医案》

延按：黄土汤方见《金匮·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉症并治》药为：灶中黄土　甘草　阿胶　干地黄　白术　炮附子　黄芩等七味，以黄土为主药，故名黄土汤。本案例一，将方中白术易苍术、再加归、芍，以增强温燥寒湿兼柔肝养血之力。例二，生地易为熟地、另加赤小豆、当归、地榆炭、乌梅肉，是于摄血中佐以清湿热之法。例三，于方中加三皮，仿五皮饮意，以治浮肿和喘，加党参以治气虚，加槐花以清化湿热。例四，由于失血过多，但饮食尚可，故易方中甘平之干地黄为甘温之熟地以补血滋阴，如遇脾虚少食，腹满便溏，舌苔厚腻者，熟地滋腻之品，即应慎用。惜方中的灶中黄土现在很难配制，考赤后脂一物，《本经》载其功用，“主泄痢，肠澼脓血，下血赤白。”《本经逢源》载其有“止血固下”的作用，似不妨以此物代之。

半夏泻心汤加味证案

温邪扶湿

谢某，男，二十多岁。恶寒发热，已历五天。脸色苍白，头痛身疼，汗少，舌尖红，很浊中有白苔，渴喜热饮，胸烦欲呕，躁扰不寐，时有诂语，便溏无腹痛，脉弦细急而短。

其父颇知医，因有恶寒便溏，舌白喜热饮等症象，深虑有涉少阴内寒外热之候，议进补阳之药，我不同意。

盖因本病是属温邪挟湿，而非真寒假热之少阴症。由于病体阳气素虚，已有浊阴留滞，今复感温热之邪，致温邪挟湿之症。故微恶寒而午后热甚，舌中白苔而尖红，渴喜热饮，心烦便溏，正为温湿混淆之症；脉象弦细急而短，乃因浊阴留滞；烦躁不眠，时时诂语，显属温邪上干之明证，此时若用温药治疗，势必助长温邪，致成痉厥抽搐之变；但如偏用凉药，则不能解散浊阴而宣达温邪。遂决用半夏泻心汤加减，以通苦泄法分解湿热，并加用紫雪丹之芳香以透邪逐秽而安神。

处方：北沙参　白芍　葛根　竹茹　麦冬各9克　半夏　黄芩各4.5克　干姜1.5克　益元散12克　芦根24克　紫雪丹0.6克　川连3克

服一剂后，汗出，热退，呕瘥，烦定，神清。脉转缓和；但舌浊，便仍溏。最后，改取温胆汤加佩兰、蚕沙、白叩花、菖蒲、荷叶、益元散等，三剂而愈。录自（《福建中医医案医话选编》林宝榆）

延按：半夏泻心汤一方，在《伤寒论》中治误下后满而不痛之痞证。在《金匮》中治呕而肠鸣心下痞之证。都属寒热之邪互结而兼正虚，故芩、连、姜、夏之苦辛开降，与参、枣、草补中药品并用，是恰当病情的。本案系温邪挟湿，借用此方则须加减化裁。以病体虽阳气素虚，但兼有浊阴留滞，故补中不宜乡、（以沙乡易党乡则不壅），枣、草之甘壅，而“通阳不在温而在利小便”，遵叶天士温热论中法，用益元散以“渗湿于热下”。湿热浊邪易于蒙蔽神明，

故用紫雪丹芳香逐秽而通神明。惟症中既有舌浊便溏现象，则方中白芍、麦冬似可减去。

大半夏汤证案（二例）

1．忧怒致噎

李士材治邑宰张孟端夫人，忧怒之余，得食辄噎，膈中隐隐痛。李曰：脉紧且滑，痰在上脘，用二陈，加姜汁、竹沥，曰：半夏燥乎，李曰：湿痰满中，非此不治。遂用四剂，病尚不减，改大半夏汤，服四帖，胸痛乃止，又四帖，而噎亦减，服二十剂而安，录自《古今医案按》

2．呕　吐

某，口吐涎沫，胃气虚不能约束津液也，吐沫而仍口渴，胃阴虚而求救于水也。舌萎苔黄，胃气不治而虚浊反行攒聚也。气阴益亏，又复夹浊，用药顾此失彼，且恐动辄得咎，惟仲景大半夏汤，取人参以补胃气，白蜜以和胃阴，半夏以通胃阳。处方：人参3克，白蜜15克，半夏9克，录自《张韦青医案》

延按：本案两例，病情不同，但都用大半夏汤，体现了异病同治之旨。例一，用二陈加姜汁、竹沥效不显，改用大半夏汤方愈者，想因患者病久胃机能衰弱肠胃乏液濡润。故

用人参健胃，白蜜润肠，助半夏通降之力而效始显。例二，本症呕吐，有口渴、舌萎、苔黄等症。故断为阴亏夹浊，如泛用一般止呕化浊药必无效，须补胃以降浊，故用本方。

橘皮竹茹汤加减证案（二例）

1。暑温误治并发呃逆

郑某，男，三十多岁。六月间患暑温病。症见恶寒发热，头痛如劈，热盛则人事不知。发病已十天，曾延中西医诊治，有谓系疟疾，有谓系恶性疟疾；或用凉药，或用温药，不但无效，而且并发呃逆，日夜不止，汤药不能下咽。病者烦扰不宁，脸色红赤，唇齿干燥，大便秘结，舌苔黄腻而间带灰浊，脉象滑数，右关中取鼓指。

本病是暑温误用燥药，热邪蕴结中焦所致。遂以橘皮竹茹汤加石羔、竹叶与服。服后，热稍退，呃逆次数显著减少。后照原方合增液汤加减，连服五剂痊愈。

橘皮竹茹汤是治足阳明兼手太阴主药，能治胃火上冲，肺金失降。方中陈皮、半夏能降逆和胃，竹茹、枇杷叶、麦冬、沙参甘寒清肺，重用石羔泻火生津，所以一剂见效。后合增液汤加减，取其养阴润燥，因此仅数剂而痊愈。

处方一：橘皮3克，竹茹24克，沙参12克，麦冬15克，半夏4.5克，枇杷叶9克，石羔90克，鲜竹叶100片。

处方二：麦冬、元参各15克，生地、竹茹各24克，芦根

30克，石羔60克，枇杷叶9克，粳米24克。录自（福建中医医案医话选编第一辑，黄斌藩）

2．胃热呕吐

洪山乡周××，患呕吐，多方不效，辗转床上，已经三天。据述稍进水食则吐，断为胃火上逆。以云连3克，苏叶9皮煎水呷下，遂不复吐。随进橘皮竹茹汤，加云连，（姜汁炒），三剂全愈。盖以胃热上逆，先用苦降，继以清胃降逆，方不格拒。查前医方药，均是温中或乌梅丸之属，故尔不效。录自（湖南中医医案选辑，第一集，双峰，康任难）

延按：以上两个案例。例一为暑温热盛，杂药乱投，使热蕴中焦而发呃逆，因热郁过久又经药误，致伤阴劫津，故于本方中去姜、枣、草之甘壅，以沙参易原方中之人参，再加降逆养阴生津之品，是为救误而设。例二属胃热上逆呕吐但热势不如前案之盛，故开始仿薛生白湿热病篇中治胃热移肺之连苏饮法以止呕，继进本方之清胃降逆益气补中，另加苦降之黄连不令格拒，因而获愈。

又按：《金匮·呕吐哕下利病脉症治》篇中的橘皮竹茹汤，为橘皮、竹茹、生姜、大枣、人参、甘草六味组成。。另济生橘皮竹茹汤即在金匮方中加茯苓、半夏、麦冬、枇杷叶，又温病条辨中有新制橘皮竹茹饮，即本方去参、枣、草，加柿蒂、以生姜易姜汁。合并录出以供参考。

桃花汤加减证案（四例）

冷　痢

阿米巴痢得病以后，可分急性和慢性两期，急性者中医指为热痢，慢性者指为冷痢。因为中国古代医学家没有化验器械的检查，不懂这种痢疾是有一种变形虫常在大肠里生活而传染的。故中医仅指本病是因脏腑传化失职，津液受伤，则奔迫无度而下痢，气分热而腐化成汁为白痢，血分热而下溃则为赤痢。现在所名阿米巴痢疾，似为古代所称的肠澼便血之类是也。

最典型的症状，是在疾病开始时，沿腹部的结肠径路上有剧烈的疼痛，并且多在结肠下端，有便意时，疼痛更甚。里急后重，便数越多，腹部越痛。体温一般正常，如有合并病者，体温稍有上升。经4—6星期后就降至正常。

本病大都是由急性转为慢性，甚有病至一二年的。

加减桃花汤的治疗

患了阿米巴痢疾、最好趁早投与白头翁汤加大黄、鲜莱菔汁调冬蜜水连服数日，可缩短病程，或者服三四剂后病就好了。如治疗无效而转为慢性病，常有排出脓血胶样液便，腹部隐隐作痛，兼有微胀和哕气诸症状，那就非用加减桃花汤不可。

典型病例

1．杨××，男，62岁，1954年12月20日就诊。据述患此病已有四月，小腹微胀作痛，肛门急坠，屡欲便意，日夜约有十余次，排出便粘液带血，食量减少，精神疲弱，四肢痿软，举步无力，脉形细滑，舌苔清白。

处方：赤石脂　禹余粮各12克　炒地榆15克　炒秦艽9克　干姜炭3克　龙骨　牡蛎　怀条各30克　清水二杯，煎一杯，药渣再煎一杯，饭前各服一服。

初服一剂，下痢减半，仍照原方连服三剂，一面用淮山药、莲子肉研末煮粥，经常服一周而全愈。

2．陈××，男，34岁，1957年1月15日诊。于1956年6月中旬起患痢疾，初下利腹痛，里急后重，日夜拉便数十次。经西医注射服药，病症较好，惟每日仍下五六次，粪带些脓血，腹胀嗳气，夜间较为严重，已有六七个月，寒热温补诸药遍尝殆尽，均不见效。去年来找我治疗，我仅用加减桃花汤治愈。

处方：赤石脂　禹余粮　诃子肉　山查炭各9克　龙骨　牡蛎　怀山各30克　炒地榆15克　炮姜炭4.5克

连服该方三剂，下利均愈，惟腹胀噫气未减，改用香砂六君子汤加代赭石、川厚朴、柿蒂、丁香，连服五六剂，自己回家调养。

3．王××，女，43岁，1957年6月诊治，据病者自述，患痢疾一载有奇，经西医医院及中医联合诊所治疗，均无效。常服卡白松鸦片酊就会减少些，但终不会除根，……特

来我家就诊，断为慢性阿米巴痢疾。

处方：赤石脂　禹余粮各12克　龙骨　牡蛎　炒淮药各30克　炒地榆　黄芪各9克　炒秦皮6克　升麻3克　炮姜炭0.24克

连服五剂，诸病均瘥；继给予参苓白术散，二星期病体转为健康。

4．郑××，男，51岁，1957年2月诊。

病者自诉：初起发生腹痛，自服辛热食物，如鸡肉焙醋，胡椒煨牛肉之类，食后三四日，即转变下痢，腹里拘急，里急后重，日夜数十次。粪便带有脓血，身热口渴，喜吃冷水，胸腹胀满，睡眠不安，就近乡私人诊治，用鲜草药调蜜水服，热渴已好，而下利不除，每日夜尚要拉大便四五次，便中带些红色液，拖延至今，将近二载，服中西药都没有效，……特到我家求诊，我也是按照加减桃花汤治疗。

处方：禹余粮　赤石脂各6克　龙骨　牡蛎　淮条各30克　生地榆　山查各9克　生白芍15克　炮姜炭0.15克

连服五六剂，病渐减轻；继与淮条120克　鸡内金15克　灶心土30克　北沙参15克　常服而愈。

小　结

在这四个病例中，病者都系患了很多的时间，少则半载，多则一二年，经过中西医治疗没有效果，嗣后服了此方，遂逐渐减轻，而至痊愈。录自（《广东中医》）1959，4，“桃花汤治疗慢性阿米巴痢的初步体会，”李健颐）

延按：桃花汤方，一见于《伤寒论，少阴篇》306，307

两条，治少阴病，腹痛，下利便脓血症。一见于《金匮，呕吐哕下利病脉症治》篇，与《伤寒论》306条内容相同。此症所下脓血，色多暗晦，或色浅淡，其气不臭而腥，泻时滑脱不禁，无里急后重及肛门灼热感觉。本案四例所述脉症，虽同属慢性痢疾，但病情同中有异，所以借用本方随症加入地榆、秦皮、龙、牡、诃子、姜炭、黄芪、升麻等，减粳米代以淮药，或佐以凉血止血化瘀，或佐收涩固脱，或佐温涩止血，或佐补中益气，治疗大法，着眼于虚寒滑脱，遣方用药则以温涩为主，与白头翁汤，葛根芩连汤的治痢应有所区别。

白头翁汤加减证案

湿 热 痢

赖××，男，15岁。

症状：1944年初夏，疫疠流行，沿门患痢。患者滞下纯血，日夜无度，腹痛不可忍，诸药无效。时发眩仆、屡频于危、脉象沉伏、舌苔深黄。

诊断：湿热之毒，深踞曲肠，服药辄顺流而下，不能迳达病所，以致历久不瘳。

疗法：议用清解湿热法，并先用鸦胆子直达病所，以为前导。鸦胆子21粒，去壳，用沙糖水囫囵吞服，腹即不痛，痢亦轻松，思进稀糜，且能安卧，继用加减白头翁汤治之，

四剂而痊。

处方：白头翁　葛根各9克　黄连　秦皮　青木香　台乌各6克　白芍12克　甘草3克　水煎服。

自按：此为热痢，疫毒深踞大肠曲折之间，有攻之不可，达之不及之势。惟鸦胆子可直达病所，缓缓溶解，而发挥作用。录自（蒲园医案）

延按：本案根据脉、舌、症状，断为湿热阻遏肠胃，故用白头翁，葛根芩连合剂加入行气之品。妙在先用鸦胆子吞服作为先驱以直达病所，然后清利湿热药物更能发挥其治疗效果。

大黄牡丹汤合薏苡附子败酱散证案（三例）

肠　痈（兰尾炎）

现代所谓的阑尾炎症状，与中医的肠痈很类似，在临床上用中医治疗肠痈的方法来治疗阑尾炎，有肯定的疗效，因此我认为阑尾炎是包括在肠痈范围，但是也反对肠痈即阑尾炎的狭义说法。

本病初起，常出现腹痛，呕吐、厌食，大便秘或下利不畅，脉紧，舌厚腻等等，初起时痛觉弥漫全腹，根容易误诊为胃痛或消化不良性的胃肠炎，但不久痛点即固定于右少腹

部，特别是髂骨窝的斜行线与腹直肌的交叉处，压痛最为显著，是本病的特征。

《金匮·肠痈篇》中对这病的病原治法，已有明确的认识。该篇条文云："肠痈之为病……薏苡附子败酱散主之"。又"肠痈者少腹肿痞，按之痛如淋……不可下也，大黄牡丹皮汤主之"。以上两条，仲景以脉迟紧者，脓未成可下之，脉洪数者脓已成，不可下，这四句以示大法，分别以症状、脉象、辩证论治法则其慎如此，这是祖国医学的特点。

我的浅见：所谓未成脓者系指初起阶段；所谓已成脓者，系指吸收期和形成肿块阶段。对阑尾炎治法，临床上根据仲景法则，掌握肿痛之痞块与濡软，在寒热与无热，在脉迟紧与洪数来辩证论治，确有相当疗效。几年来在临床实践中，我认为薏苡附子败酱散与大黄牡丹皮汤复方合并应用，治疗阑尾炎初期阶段效果比单独使用尤佳……兹将病例简录如下。

1、林××，男，21岁，农、厂内民工。于本年8月3日下午3时左右，突发作全部腹痛，经西医陈××往诊，认为胃痛，给予内服镇痛、镇静剂，并注射吗啡阿托品，均不见效，症反加剧，乃延我急诊。据诉：初起整个腹部痛，特以胃部为甚，曾呕吐二次，（食物），大便二次似痢而不畅，服药后痛未减。

检查：发育、营养均佳，身体健壮，急性病容，剧痛不安，体温正常，脉芤紧促，舌腻而厚，胃部痛及压痛点已消失，马克氏压痛点明显，诊断为阑尾炎。

处方：苡仁30克　附子6克　败酱30克　大黄　丹皮　冬瓜仁　元明粉各9克　桃仁6克　水煎给予频服。药后约

3小时，大便畅解三次，粪如橘汁，痛已大减，照上方增减三剂而愈。

2．吴××，男，19岁，农，厂内民工。8月17日上午，突发生右腹部痛，压痛明显，经所内西医诊为阑尾炎，邀会诊，患者体温正常、脉芤紧，急性病容，马克氏压痛点明显，按之反射淋样痛，大便泻二次，呕吐一次，小便正常，确为阑尾炎症状。我认为中医治疗效果很好，同时患者亦不愿去医院，因此决定中药治疗。

处方：大黄　丹皮　冬瓜仁各9克　桃仁　元明粉各6克　苡仁　败酱草各30克，配以煎剂，服药后情况如第一例。第二方去元明粉连服二剂而愈。

3．陆××，男，24岁，农，厂内工人。9月2日下午5点许，突发全腹部痛，病况如第一例，由西医龙××处理，诊断为消化不良性胃炎，处理同第一例，痛未减。至八时许延我急诊，病状明显，淋痛样的反射痛特别显著拒按，体温正常，脉芤稍数，诊断为阑尾炎，照第一例方合剂治疗。至晚上12时许，突发恶寒，继则体温升高38.3℃，脉数较显而带洪，嘱将原药再煎给服，至三点许，病未减而体温继续升至38.8℃，考虑有化脓现象，病势危重，即送专区医院。经专区医院检查为急性阑尾炎，化脓现象显著，立即开刀处理。

结　语

①薏苡附子败酱散与大黄牡丹皮汤二方复合应用，治疗阑尾炎初期，（单纯性）效果良好。

②对急性化脓型一例，应用以上二方效果不佳，这是由于病例不多和个人水平有关，今后对这方面应进一步研究。

③据金匮所说未成脓者脉为迟，但是在临床上多为紧脉，并未见迟脉，值得提出讨论。录自（福建中医药1958，12月号“应用大黄牡丹汤、薏苡附子败酱散合剂治疗阑尾炎三例的经过”，倪德生）

延按：本案作者根据自己的临床实践，认为治疗肠痈，（阑尾炎），用薏苡附子败酱散与大黄牡丹皮汤合剂，效果较好，并举出案例三则作了忠实的报导，值得参考研究。查古方中两方合用的不少，如麻黄汤、桂枝汤两方，桂枝汤、越婢汤两方，小柴胡汤、桂枝汤两方。载在《伤寒论》中。后世医家以小柴胡与小陷胸汤，白虎与承气等合用，都是明显的例子。主要在观察病情的发展变化而随症加减化裁。忆王孟英前辈医家在孙文垣治马厨案后，（见古今医案按），批注云：“杂合之病，不妨以杂合之药治之，必欲执古书以合今病？未免胶柱刻舟，是病不循规矩以为患，医第循规矩以为治矣，奚可哉”。用以解释此案，恰好。

大黄牡丹汤证案（四例）

肠　痈

曹颖甫治验：1．若华之母病此，腰腹俱肿，有时发热自汗，有时不甚发热，痛不可忍，按之稍定，于冬至前二

日，用大黄15克　丹皮30克　桃仁50粒　冬瓜子80粒　芒硝9克　服后腹中大痛，午后下血半净捅，而腹平痛止，不啻平人矣。

2．强鸿培嗣子福全病此，既就宝隆医院矣。西医指为盲肠炎，并言三日后大开刀，患者惧，翌日，抵予小西门寓所，以腹中剧痛求诊，按其脉紧而数，发热有汗，但不恶寒，予即疏方与之，明日复诊，盖下经三次而腹痛止矣。

3．治陆性少女腹右旁痛，痛经四月，身体瘦弱，西医不敢开刀，由同乡高长佑推荐，予以此方减轻授之，当夕下泥黑粪，痛未止，稍稍加重，遂大下黑粪，如河泥，其痛乃安，调理一月，方能出险。

4．四明史惠甫病此，已由姜佐景用前方下过，未能拔除病根，予用生大黄15克，冬瓜仁30克，桃仁80粒，丹皮30克，芒硝9克，外加当归、赤豆，二诊加赤芍15克，败酱草15克，所下黑粪，并如污泥状，病乃出险，录自《金匮发微》

延按：以上四例，虽同属肠痈，因其体质不同和病程长短殊异，所以在使用本方时，或用原方，或原方减轻其剂量，逐渐加重，并注意善后调理，或在原方基础上加入活血化瘀排脓药品，以拔除病根。因其治疗方法适当，不是机械地搬用古方，故能收到一定的效果。

大黄牡丹汤加味证案（四例）

肠　痈

兰尾炎就是中医所称的吊脚肠痈症，汉张仲景著《金匮要略》时已采用大黄牡丹汤来治疗。历代医家如张路玉、尤在泾等，对此均有所阐明。所以用中药来医治此症，原是不足为奇的。近年来由于西医外科手术的进步，中医遇到此症日渐稀少，大部中医碰到此症，也往往不考虑开方，直截的介绍进院割治；一般群众在思想上就存着只有一个割治的办法，因此在中医临床上就很少遇到。全程治疗，当然更少。现将最近二三年内所遇到的起初经过西医诊断，因病家对开刀有顾虑而剩下来的四个病例介绍于后。

1．房×生，男，59岁。始起寒热，右小腹疼痛异常，且拒手按，右腿不能伸，大便闭，脉数而大，体温39.1℃。54年9月30日经加兴医院诊断为兰尾炎。因恐已化脓，未立即开刀，次日由亲友介绍来我处诊治，投以复方大黄牡丹汤（生大黄9克　元明粉9克　瓜蒌仁12克　桃仁　丹皮各6克　乳香　没药　炙甲片各4.5克　琥珀粉0.5克（冲胀）金铃子6克　延胡4.5　青皮3克　贯仲9克）后，逐日减轻，前后共诊五次全愈。

2．潘×宝，女，69岁。55年10月29日经加善县卫生院诊断为兰尾炎。因无开刀设备，出给3299号急性兰尾炎的诊断证明书，转送加兴治疗。患者因限于经济，当日下午邀我

用中药治疗。体温39℃，腹右拒按，足吊，便闭，苔色黄垢，投以复方大黄牡丹汤，连续九诊全愈。

3．徐×懿，女，58岁。猝起身热，体温为38.7℃，颧红，右小腹剧痛，不耐手按，便闭，时作泛恶，右足艰于伸。经新民诊所诊断为兰尾炎，建议去加兴治疗。56年8月2日由潘大宝介绍来我处用中药治疗，给服复方大黄牡丹汤，不旬日而痊。

4．裘×弟，女，52岁。57年8月17日，猝患腹部满痛，旋即聚痛于偏右小腹部，拒按，足不能直伸，时欲作恶，经搬运工会保健室诊断为兰尾炎，嘱送加兴割治。于20日抬至本人处就诊，脉弦，苔灰黄而腻，便不爽，体温38.2℃，当即投予复方大黄牡丹汤。次日痛减，体温降至37.5℃，第七天热退尽，按痛处犹觉不舒，至11天全愈。

上列四例，均有发热、便闭、右腿不能直伸现象，且病起迅速，系属急性一类，是复方大黄牡丹汤的适应症。

复方大黄牡丹汤，较大黄牡丹汤原方在止痛行瘀方面，尤为得力。不仅治早期，即中晚期的阑尾炎，只要脉芤旺，精神尚振，舌苔垢厚，都可适应。录自（1957年12期《浙江中医杂志》“复方大黄牡丹汤治愈阑尾炎病例）嘉善，张宗良）

延按：此案叙述的症状，较金匮更具体明确，因为病属急性，且来势迅猛，故在大黄牡丹汤原方上另加止痛行瘀药品，因而代替了手术治疗。

蜘蛛散证案

阴狐疝

曹颖甫治一倪姓患者，其症时发时止，今以遇寒而发，偏坠微痛，夜有寒热，睡醒汗出，两脉迟滑，方用大蜘蛛一枚炙过，川桂枝12克，一剂即愈。录自《金匮发微》

延按：本症病因，尤在泾说："阴狐疝气者，寒湿袭阴，而睾丸受病，或左或右，大小不同，或上或下，出没无时，故名狐疝"。本方的方义，曹颖甫说："蜘蛛破瘀消肿……取其下入阴部，桂枝通阳宣郁……破瘀则寒湿不凝，通阳则郁热外散，而偏坠可愈矣"。用何种蜘蛛有效问题，据中国医学大辞典载："蜘蛛入药，宜取身小尻大，腹内有结"黄"之浓浆及悬网者"。

又按：陆九芝《世补斋医书前集》，述先一文内载其先祖用此方以治吐泻腹痛，脚麻转筋，谓"木运太过，风气流行，而后脾土受邪，故欲补土，必先平肝，欲平肝，必先定风，风定而后以脾药继之，庶可及救，若专补土无近功，非救急法。然定风之药，如勾藤、天麻辈亦未必能奏效。乃取金匮方中蜘蛛散一法，以蜘蛛、肉桂二物锉为散，盖谓蜘蛛临风结网，长于定风，炙焦则微变其寒性而为温，有开散之力，佐以肉桂，（此症用肉桂较桂枝更有力），木得桂而枯，使风先息而木自平。"此一治验，虽所述症状与金匮不合，但都从肝脏着眼寻求治法则一，可谓善用古方，并扩充了蜘蛛散的应用范围。

甘草粉蜜汤证案

蛔　厥

先母侍婢曾患此，始病吐蛔，一二日后，暴厥若死，治以乌梅丸，入口即吐，予用甘草15克，先煎去渣，以铅粉6克，白蜜30克调饮之，半日许，下蛔虫如拇指大者九条，其病乃愈。”录自曹颖甫《金匮发微》

延按：关于甘草粉蜜汤中的粉，有认作铅粉的，有认作米粉的，聚讼纷纭，莫衷一是。如果根据实践是检验真理的唯一标准这一思想指导，那么我认为用铅粉是正确的。观此案的治疗方剂，先用乌梅丸无效，因乌梅丸中药品，只能安蛔，不能杀虫，继用本方有铅粉之杀虫，就获得显效，可作有力的证明。并请参阅1958年中医杂志4期，“关于甘草粉蜜汤之我见”。后秦伯未按语，和同年12期“甘草粉蜜汤的争鸣”一文，5．临床实验病例。就更明瞭。

桂枝茯苓丸加味证案（四例）

1．小儿夜间发热

谢秋光，2岁。身体健，性聪明，昨夜倏然高热，口不

渴，人清醒，家人虑热极生风，致生它变，夜半延唐医治之，进以清热解肌剂，天明热退，白日嬉戏如常。至夜复热，间有妄语，医又认作风兼积滞，用青蒿、薄荷、连翘、神曲、焦查之属，解热消食，病亦不退，此后夜间发热无少间，儿体则日呈虚象。今晨儿母携来就诊，指纹青滞，舌尖红无苔，夜热无汗，尿黄便和。但发热之前不恶寒，指纹青，既非外感伤风，则属受惊生热所致。乃母曰：前夕儿从床坠地，次日即病，其以是欤？如此则病因惊而发，惊则气血不和，影响经脉，因而发热，是热自内生，故非解表可治者，治宜安神和血则得之矣。处《金匮》桂枝茯苓丸(注)，而变通其用。

处方：桂枝3.5克，丹皮6克，桃仁6克，茯神（辰砂拌）9克，加龙骨、牡蛎各9克。

午后服完一帖，当夜热大减，再剂热不复发，遂嬉笑如常矣。观此，则知发热之多端，不宜局限于清热解表之成法。录自《赵守真治验回忆录》

注：《金匮·妇人妊娠病脉症并治》

2．漏下

王××，28岁。1958年9月在南通市人民医院住院。因一月前，施行人工流产术，阴道一直有断续性出血，腹中隐痛，近日来出血尤多，衣裤浸湿。经妇科检查，无特殊发现，拟诊为：（1）月经过多，（2）异物残留感染，乃于9月24日邀余会诊。按脉象弦，舌苔淡黄，此盖冲任受损，血凝瘀滞不净，虚中夹实，血不归经之故。

处方：潞党参　川桂枝　云茯苓　粉丹皮　桃仁泥　生白芍　清阿胶　益母草　服药两帖，阴道出血由减少而基本停止；惟26日起床受凉，略感身寒头疼，腹中冷痛，体温36.6℃。所幸胃气未伤，食欲尚好，其他症状，因之亦遂有好转。遂于原方内加入附子、当归、生姜、大枣，温经养血，调和营卫，补中有散，虚实并举，以助桂枝茯苓丸力之所来遂。大气一转，诸病若失，一剂知，二剂已。28日改服益母膏合归脾膏以善其后。

3．方××，女，37岁，大生一厂工人。数年来，腰左侧前后，时有疼痛，痛甚自汗出。每屈经行前，辄腹胀气转，失气频仍。刻头眩、面㿠白、身寒。于1959年11月20日，行人工流产术后，阴道血性分泌物，迄今淋漓不断。住南通市工人医院，于59年12月24日邀余会诊。神疲、颠倒困顿，病势十分严重，痛苦极难忍受。经内外科医师检查，拟诊为肾脏结石，按法治之罔效，因转而改服中药。当按脉轻举之濡，重按之有弦意，察苔淡黄而腻。根据中医诊断为血凝气滞，厥阴络脉失调，络阻攻冲，故牵引腰背疼痛甚剧耳。欲止其痛，必调其气血，缓其攻冲，气煦血濡，营卫和谐，斯痛可止而正可渐复，络脉通调，经气流转，诸症愈矣。

处方：潞党参　川桂枝　赤白茯苓　赤白芍药　桃仁泥　粉丹皮　制香附　全当归　紫丹参　炒延胡　益母草　佩兰梗

服药一帖，阴道出血反较多，惟腰部疼痛大减，大便得通，腑秽有下行之机，气血有流畅之渐。服药二帖，血行转少，腹中舒适，自诉未服药前，腹肌颇有紧张感，服药后，

腹肌顿觉松弛，盖邪甚则拘挛，正复自舒软耳。乃于原方内去佩兰梗之宣中化浊，加清阿胶之培补血源，另嚼服益母膏以资调理。从此精神振作，血止痛停。其后间有腰痛，加杜仲、木香、乳香、没药以止痛。食欲不振，加砂仁、谷、麦芽、鸡内金以醒胃。并续进八珍益母丸以善其后而病愈，计先后服煎方十五帖。

作者从临床实践中，将桂枝茯苓丸方化裁而得治疗痛经、漏下、人工流产后遗症，子宫宫能性出血，……平脉辩症，相体论治，随症选药，疗效极佳。

加味桂枝茯苓丸方

潞党参　川桂枝　赤白茯苓　赤白芍药

桃仁泥　粉丹皮　制香附　全当归

紫丹参　清阿胶　益母草

药效分析

扶正达邪——党乡

温运血行——桂枝　桃仁

止血补血——阿胶

化瘀导滞——桃仁　丹参　赤芍

调经止痛——当归　白芍　香附

消炎解凝——丹皮

运中导浊——赤白茯苓

收缩子宫——益母草

加味桂枝茯苓丸，一般多改丸剂为汤药煎剂内服，大抵2—4帖后必效。亦尝以原方加红糖收膏为加味桂枝茯苓膏。较益母膏为力强。录自（1961年9期《江苏中医》“论桂枝茯苓丸证及加味桂枝茯苓丸在妇科病学上的临床应

用”，陈伯涛）

4．症瘕

病者××，女，49岁。1956年5月，患子宫肌瘤发作，发热剧痛，向两下肢放射，如火灼终夜不能成眠，经注射过钲痛药，及青霉素，毫无效果，续往××医院留医，根据检查诊断为子宫肌瘤，伴甲状腺肿大，月经过多，须先摘除甲状腺，才能把子宫肌瘤摘除。当时病者，以环境困难，仅留院十余天，亦无效果而出院，症状并未改变，至午后潮热，约在38.5℃上下，入夜则剧痛，按之腹内有硬块（如柚子大），所谓“盘牢不移”，“状如怀子”，治以加味桂枝茯苓丸汤三剂，剧痛缓解，热亦退，后将汤剂改为丸剂连服三月，病告痊愈，直至57年，月经如常，58年月经仍有三次，又于当年十月间，到××医院检查，肿瘤萎缩如鸡卵大，健康恢复如常。

丸方：桂枝48克　茯苓60克　丹皮36克　桃仁18克　白芍48克　丹参36克　鸡内金36克　川大黄36克　当归36克

制法：将上药焙干，共为细末，炼蜜为小丸。

服法：早晚开水吞服9克，约服2料，每一料为一疗程，约服二疗程。

服药后反应：初服二、三天期间，觉有作闷作呕，服至第四天后已能忍受，这种反应自能消失。

子宫肌瘤是妇女生殖器官中最多发现的良性肿瘤之一，在祖国医学典籍中，早在几千年前即有“症瘕”这个病名，从现代的医学理解，“症瘕”当即属于子宫瘤一类，《灵

枢·水胀》指出："石瘕生于胞中……月事不以时下。"《素问·骨空论》："任脉为病……女子带下瘕聚"。"症瘕"、"石瘕"形容肿瘤的硬块，"月事不以时下"说明子宫瘤容易出血。仲景《金匮》中说："妇人宿有症病……所以血不止者，其症不去故也，当下其症，桂枝茯苓丸主之。"这不仅认为症瘕病人可能妊娠，还认识"漏下不止，血不止"，是"症不去"的"症痼害"，这与现代子宫肌瘤的病理特征——月经过多，或不规则子宫出血，是相符的。

讨　论

1．桂枝茯苓丸，仲景原为妊娠而兼有宿症者设，性力和平，对子宫瘤有潜移默化之效，伍以大黄、丹参、鸡内金而消症效力增强，佐以当归生血，久服于身体无碍，丸能缓缓消其积聚，不致过峻伤正。

2．在患肌痼的患者，而兼有并发症存在，或肌瘤割除术不可能施行时，可适应使用。

3．丸服后几天，症状消失，大便畅通，食欲增进，药价低廉，服食便利，是值得推广使用的。录自（1960，3，《广东中医》"加味桂枝茯苓丸治愈子宫肌瘤一例"谭石生）

延按：以上四例，一例为小儿疾患，三例为妇女疾患，均以桂枝茯苓丸为基础方，因其病情不同，故随其症状的变化而加入对症药品，如例一，本症通过问诊及视指纹，知为受惊所致，由于发热之前不恶寒，知非外感，故借用桂枝茯苓丸去芍加龙、牡治疗。方中桂枝温通血脉，丹皮、桃仁凉

血散瘀，朱拌茯神协同龙、牡钲惊安神，去芍药，以非营卫不和之发热，故不需桂、芍相伍。例二、三，为施行人工流产术后，致月经淋漓不断，病属虚中夹实，所以用补中有散，虚实并举之方，因而收到满意的效果。例四，为“症痼害”，非用攻不可，故在桂枝茯苓丸方中加软坚化瘀攻积药品，先服汤剂以缓解其剧痛，后变汤为丸，可以久服较长时间，仿抵当丸意，收到峻药缓攻的效果。观此，可见古方运用化裁之妙。

芎归胶艾汤加味证案（四例）

妊娠下血

“先兆流产”是指妇人在妊娠期间发现有下阴道出血的一种症状，中医妇科书籍上称为“胎漏”，《金匮》称作“妊娠下血”，如处理不当，不啻有导致正式流产的危险……芎归胶艾汤是古人用以治疗妊娠下血（即先兆流产）的首要方剂，但也非任何一种性质的妊娠下血皆适用。现试举采用本方治疗初步认为先兆流产的“生理性妊娠”，“病理性妊娠”病例各二则，说明其治疗不同的结果，并简述个人的一些体会。

1．崔×，25岁，本院职工。月经已三月未行，小便蟾蜍试验阳性，证明确有妊娠。旬日前，因向高处取物，致腰部受闪，随即觉腹部隐隐作痛，伴有腰酸及后背下坠感，次

晨发现下阴道有少量出血，即至妇产科检查，初步诊断为先兆流产，除嘱绝对卧床休息外，并注射黄体制剂及维生素戊等药物，三天后血仍未止，腹痛及腰酸等症状虽减，但亦未完全消失；改服中药治疗，时漏红已五天，有恶心，食欲不振，并觉心悸头昏，脉细小而滑，舌质略绛薄白少苔。

处方：阿胶　艾叶　归身　炒白芍各9克，川芎　炒黄芩各4.5克　生白术6克　砂仁3克　续断　大生地　杜仲各12克，服药后约三、四小时腹痛即逐渐停止，腰酸顿减，下坠感消失，次晨红止，惟胃纳仍不佳，时欲泛恶，头眩而晕，精神欠佳，除嘱继续休息外，再投补气血兼和脾胃方：阿胶　茯苓　归身　党参　黄芪各9克　艾叶　砂仁各4.5　熟地12克　炙草　川芎各3克　白术　陈皮各6克　三剂后胃纳渐强，呕恶亦止，精神日见好转，头眩头晕若失，未久即照常工作，于去年三月正式分娩，母子俱安。

2．周×，33岁，梅林罐头食品厂女工。

月经已50余日未行，4月19日在本厂保健室接种预防注射（三联苗）后，下午当即发冷发热，继感腹痛呕恶，曾服藿、佩、芍、连、橘、半、姜、草、砂仁等煎剂，服后呕仍未减，且随服随吐，腹痛亦未止，翌日又服××药水，呕吐反剧，腹痛更甚，次日即发现下阴道有少量出血，同时有腰酸下坠感，自知恐系“小产”，乃于4月23日来本科门诊，当日处方：阿胶　艾叶　归身　焦白术　炒白芍各9克　续断　杜仲各12克　大生地18克　川芎3克　炒黄芩6克，服药后腹痛即逐渐减轻，呕恶亦不复再作，当夜下阴道出血渐觉减少，二剂后腰酸坠消失，红亦停止，小便蟾蜍试验结果阳性，证明确系妊娠。但胃纳仍不佳，食后饱闷，时感头

昏，再进补中益气，安胎健胃方：党参　焦白术　茯苓各9克　陈皮　炙黄芪　归身各6克　炙甘草　砂仁各3克　艾叶4.5克 服两剂，于4月28日到厂恢复工作，近据妇科检查，一般情况良好。

3．瞿×，28岁，某书店营业员。月经停止已三月余，据述，曾作蟾蜍妊娠试验阳性，一星期前下阴道出血，断续不止，伴有腹痛及腰酸，头目昏晕，曾服中药6剂无效，18日初诊时漏红将旬日，时多时少，腹痛阵作，心悸荡然，恍惚若有所失，腰酸且坠，呈紧张面貌，脉小滑，苔薄白。初步诊断为“胎漏”有流产之虞。

处方：阿胶　杜仲　归身　炒白芍　炒白术　炙黄芪　续断各9克　艾炭4.5克　大生地15克　川芎　砂仁各3克　陈皮6克　20日复诊：据称服药二剂后，腹痛及腰酸略减，漏红亦较少，惟食欲不佳，寝不安神，心悸惕惕，乃于原方中加太子参、朱茯神各9克。24日三诊：又服二剂后，漏红停止两天，惟昨日（23日）又续见漏红，29日四诊：漏红仍断续不绝……结果再往某医院检查，确诊为葡萄胎，已于4日上旬动用手术截除。

4．杨×，26岁，梅林罐头食品厂女工。1958年3月19日初诊：患者系今年元旦结婚，婚后将近一月二十三日月经后未复来潮，3月4日晚，发现下阴道有少量漏红，迄今未止。两旬前腹痛泄泻，一日三、四次，粪质稀薄，无粘液及脓血，微有发热未久又续见两耳下肿痛，经保健室医师初步诊断为肠炎并发腮腺炎，经注射青枚素及口服氯枚素而肿痛渐消，腹泻随愈，但于3月4日晚起，发现在小便时阴道漏红，当初以为是月经来潮，未加注意，后因断续不止，且其

量甚少，与往日月经显有不同，同时伴有腹痛及腰酸，呕恶频繁，甚则饮食入口即吐，时觉头昏，乃于3月19日起，前来本院中医科门诊，服药8帖未效，于是乃嘱住院观察。入院时神清，无急性病容，舌苔白腻，脉细滑微数，按其少腹有轻微触痛，但腹肌无紧张状态。血压160/64毫米汞柱，小便蟾蜍试验阳性，初步诊断为先兆流产。处方：阿胶　归身炒白芍各9克　艾叶4.5克　川芎　佛手片　砂仁各3克　大熟地15克　川断12克　次日腹痛略减　惟漏红未止……至4月9日下午5时右左，突然腹痛及腰酸增剧，小腹下坠，忽然间漏红增多，当有如鸡卵大小瘪肉状物质三枚从阴道排出，至晚10时左右，又排出如婴儿手掌大者一块，色紫红，经妇产科医师检查，……系病理妊娠之一，在近代医学名辞上称曰泡状胎块”，相当于中医书籍上的“鬼胎”。据称此类病理性妊娠，其流产是必然的，否则亦必须手术治疗。

讨论和体会

一、关于先兆流产的治疗，如果熟谙中医治疗其他一般疾病的基本规律和方剂药物等知识，并不十分困难；但是在临床上若不借助于现代的化验和物理学检查，要把一个生理性妊娠与病理性妊娠科学地区别开来，却非简单……根据我们的初步体会，凡妊娠下血，在一般情况下，若加以适当地治疗和定期的休息，其血可迅速能止，若服药后，漏仍若断若续，或呈间断性和持续性的反复发作，且逐渐增多者，除非有其他继发性感染或别有特殊原因外，就应该考虑到是否有属于病理性妊娠的可疑。

二、芎归胶艾汤虽然是古人用以治疗妊娠下血的首要方剂……根据我们初步的经验和体会，以本方施用于生理性妊娠下血的早期尚未濒临于“不可避免性流产”的程度，有很好的疗效。倘若系病理性妊娠下血或虽系生理性妊娠但由于治疗不及时，业已达到“不可避免性流产”的程度则不宜再用本方治疗。录自（1958年7期《浙江中医杂志》“芎归胶艾汤治疗先兆流产初步探讨”上海市徐汇医院　徐余祥　杨俊才）

延按：以上四案，均系《金匮·妇人妊娠病脉症并治》篇中所称的“妊娠下血”均用芎归胶艾汤加减治疗，前二例为生理性妊娠，故用本方有效；后二例为病理性妊娠，用本方则无效，根据现代医学检查，必须用手术才能达到治疗目的，以见有些疑似病症，用中西结合治疗，是可取的。

当归芍药散加味证案（三例）

当归芍药散载于《金匮要略》。主治妇人腹中诸疾痛。方由当归、芍药、川芎、白术、泽泻、茯苓六味药组成。虽选药平淡无奇，而有缓急止痛、养血抑肝、健脾利湿之功。

1。行经腹痛

张××，女，26岁。患痛经已3年，曾用温经汤，胶艾汤及西药治疗无效。面色无华，形体消瘦，胃纳不佳，经期

尚准，行经时必下腹痛，月经量少，色暗红，质稀如水状，今行经二日，腹痛又发，绵绵隐痛，痛时精神不振，大便溏而欠爽。舌质略暗苔薄腻，脉象弦涩。此肝郁脾虚，血亏湿浸之痛经，治以当归芍药散加味。处方：当归　泽泻　茯苓各12克，赤芍　川芎　白术　制香附各9克　丹参18克，小茴　蕲艾各3克　兑黄酒3克同煎。服三剂。

嘱患者每次月经期服上方三剂，连服三月后，痛经已除，经量适中，经色亦正常，余症消失，精神面色已趋正常。

按：本例素体血虚，肝木易旺，肝旺势必侮土，土虚水湿逗留，而致行经腹痛、经水稀少。治用当归芍药散，健脾抑木、养血调经、止痛利湿。加丹参以增调经养血之功，制香附有调经理气之用，小茴、蕲艾止痛理气，3年之疾，药中肯綮，而使病愈。

2．经后腹痛

郑××，女，30岁。患经后腹痛已半年，近月加剧，前来诊治。素体矮小，孱弱，年幼多疾，初潮后月经不调。经期尚准，行经时少腹略有不适，腰酸乏力，胃纳一般，经后下腹拘急胀疼，时痛时止，时喜按，时按之反剧。舌苔薄腻，脉小弦。此肝肾不足，气滞湿阻之腹痛，治以当归芍药散合枳实芍药散加味。

处方：茯苓　全当归各12克　白芍　白术　川芎各9克　枳实6克　菟丝子　丹参各18克　川断　桑寄生各15克

服五剂后，腹痛已除，腰酸已瘥，精神亦振，并嘱下次

月经后再服此方。隔二月后随访，经后下腹已无痛感。

按：痛经的临床辨证，一般常以经前或经期腹痛为实，经后腹痛为虚；按之痛甚为实，按之痛减为虚。本例患者经后下腹胀痛，时喜按而按之反剧，是气滞肝郁又兼血亏，为虚实夹杂之症。伴腰酸者，因经行后肝血已去，肝肾同源，肝亏肾亦虚也。用当归芍药散，健脾养血，止痛抑木。减泽泻因肾虚已露，湿热未盛。加枳实兼疏肝行气之力，加菟丝子、川断、桑寄生滋肾以强腰脊，加丹参一味，有四物之用，增强养血滋肝之功。辨证明确，药证相符，病能痊愈。

3．腹痛白带

董××，女，31岁。患者面色㿠白，头昏腰酸，纳差，少腹隐痛，时痛时止，痛时白带绵绵，痛除无带。舌苔薄腻，脉弦尺部小。证属肝郁血虚，脾肾两亏，而夹湿郁，治以当归芍药散加味。处方：全当归　白术　海螵蛸各12克　白芍　煅牡蛎　菟丝子各18克　制香附9克　川芎6克　茯苓　沙苑子各15克

服上方四剂，腹痛已缓，带下已减，余症亦瘥，前方续服五剂而愈。

按：《传青主女科》论带下曰："……以脾气之虚，肝气之郁，湿气之浸，热气之逼，安得不成带下之病哉。"该例腹痛则带下，不痛则无，可见腹痛是本，带下是标，治腹痛则带下自已，面色㿠白，头昏，少腹隐痛，是血虚肝络不和《素问·五运行大论》曰："气有余，则制己所胜而侮所不胜。"血虚肝旺，必制其所胜之脾，脾虚湿下渗而成带

下。用当归芍药散，健脾抑木，养血止痛。减泽泻因其肾亏，不能分利太过，加制香附增疏肝止痛之功，加海螵蛸、沙苑子、牡蛎、菟丝子滋补肝肾，固带脉以涩带下，服药九剂，诸症消失。

临证体会

当归芍药散是一张肝脾同治、血气两和、虚实相顾、治疗诸腹痛的好方子。用本方的辩证要点，笔者认为，除观察其腹痛为绵绵不断，不剧烈而时间较长外，脉苔的诊察，相当重要，脉弦、苔白腻或薄腻是本方的适应证，其他症状，不必悉具。如临床要提高疗效，该方的加减法，也很重要。若腹痛是血亏络虚所致，用白芍、白术止痛为主，白芍缓急止痛，白术健脾益气。若腹痛是血瘀所致，用当归、川芎止痛为主，当归养血活血，川芎活血祛瘀，血行瘀除则痛自止。血虚而燥者用白芍，血虚而瘀者用赤芍，阴（血）虚络脉拘急疼痛者，重用白芍18克方能取效。肾亏者减泽泻加滋肾药，血热湿热并重者，减川芎随夹杂症而选用它药。至于方中川芎的用量，可根据临床属于血瘀而痛者，用量可较重，血亏络虚而痛者，用量可较轻。煎服兑酒以行药力，效果更佳。录自（1979年3期《新医药学杂志》“当归芍药散的临床应用”沈敏南）

延按：本案运用当归芍药散加减治疗腹痛三例。一在经前，以气机阻滞为多，故加入调经理气之品。一在经后，为虚实夹杂，故药品亦滋肾疏肝并用。一兼白带，故在本方基础上，加入疏肝止痛，滋补肝肾，固涩带下药品，如此标本同治，用药取舍适当，因而收到治疗效果。

干姜人参半夏丸证及加味证案（五例）

干姜人参半夏汤（丸），方出《金匮要略》。《金匮·妇人妊娠病脉症并治》篇云："妊娠呕吐不止，干姜人参半夏丸主之"。《医宗金鉴》注："妊娠呕吐，谓之恶阻。恶阻者，谓胃中素有寒饮，恶阻其胎，而妨饮食也"。但因方内干姜、半夏，后世方书皆列为妊娠禁药，故现代用之者不多。然本人曾用该方治疗属于寒饮之恶阻及由于胃有寒饮而致的腹痛、吐逆、眩晕、痞证等，收效都很满意。体会本方的应用对象，当以《医宗金鉴》所指的"胃中素有寒饮"为准则。

1．**妊娠呕吐**：妊娠呕吐，属热者固有，而属寒者亦不少见。其辩症当以口之渴与不渴，舌质之红赤与否，呕吐之粘稠与稀薄等为辩。……至于所谓干姜、半夏为妊娠禁药，本人曾屡用而未见损胎。盖有病则病当之。兹举例如下：

农民林××，女，26岁。停经2月，开始胃纳不佳，饮食无味，倦怠嗜卧，晨起头晕恶心，干呕吐逆，口涎增多，时或吐出痰涎宿食。根据经验自知是妊娠恶阻，认为恶阻乃妊娠常事，未加适当处理。延时将近一月，渐至水饮不入，食入则吐，所吐皆痰涎清水，稀薄澄澈，动则头晕、眩掉时则呕吐增剧。始延诊治。诊其脉虽细，但滑象明显，面色苍白，形容憔悴，羸瘦衰弱，无力以动，闭眼畏光，面里蹉卧，唇舌色淡，苔白而滑，口中和，四末冷，胸脘痞塞不舒，二便如常而量少。脉症合参，一派虚寒之象。

处方：干姜　半夏各4.5克　党参9克　水煎，日一剂，连服三剂，呕吐大减，略能进食稀粥和汤饮。再服三剂，呕吐俱停，但饮食尚少，继以“五味异功散”调理善后，七月后顺产一男。

2．**虚寒吐逆**：虚寒吐逆，有厥阴寒气上乘之呕吐涎沫。如《金匮要略》之“吴茱萸汤”证；有中土虚寒之干呕吐逆吐涎沫，如《金匮要略》之“半夏干姜散”证。但两者每有因果关系。盖下焦阳气不足，厥阴寒气上乘，则火不生土而引致中土虚寒；中土既虚，脾阳不振，则土不制水，使阴寒之气益盛，更易上乘阳位。且土虚而木益陷，肝气亦易上逆。两者互为因果，形成恶性循环，而病益深。笔者曾用本方加吴茱萸一味，治愈顽固之虚寒吐逆症。举例如下：

盐业工人许××，男，41岁。胃脘饥时钝痛，已历有年，屡治未愈。近3个月来胃痛虽未发作，但转为“胃反”证。其证先是早午两餐饮食尚可，但午后逐渐饱满，至暮则呕吐宿食酸水后，始觉舒畅。病情逐渐发展。近日早午两餐饮食亦减，终日呕吐不停。曾经多方治疗，均作胃寒处理，服过“香砂六君子汤”、“吴茱萸汤”、“橘皮竹茹汤”、“丁香柿蒂散等方，其效皆不著。诊脉沉迟而稍弦，所吐皆痰涎清水，呕逆后其气上冲头顶、抟痛甚剧，经常亦觉眩晕不支；肌肉消瘦，四末冰冷，舌苔白滑。该病起于中虚胃有寒饮，因迁延失治，致土愈虚而木愈盛，使厥阴寒气上逆，而呕吐眩晕皆剧。现补虚则痰饮益滞，祛痰则中土愈虚，处理为难。**处方**：干姜30克　党参45克　半夏90克　吴茱萸15克　研末米糊为丸，每次9克，日服三次，用生姜汤送下，徐以图之。连服三天，已中病机，呕吐头眩均减。继服至10

天后，已基本痊愈。后仍用“香砂六君丸”收功。

3．**虚寒腹痛**：腹痛之由于里虚兼寒者，如虚多而寒不甚者，可用“六君子汤”等方为治；如寒甚而气滞者，《局方》有“二姜散”一法；如虚寒而挟有痰饮作痛者，则宜用本方加良姜甚效。兹举一例：

林××，男，32岁，农民。腹痛绵绵，久而不愈；时吐涎沫，胃脘痞塞，食少哎气；倘矢气一下，则痛可暂宽，大便常溏参之脉迟紧，苔白滑，证系寒饮阻中，中寒气滞，久之中土亦虚。**处方**：干姜　良姜各9克　党参　半夏各6克　以“干姜人参半夏汤”之温中散寒，祛痰止呕；加良姜所以行气止痛也。一剂而呕减痛轻，三剂告愈。

4．**痰饮眩晕**：中焦虚寒，痰饮上逆，每致眩晕，此时但治其痰饮，而眩晕自除。病案举例：

林××，家庭妇女，45岁。素体虚寒，喜热怕冷；春夏之交，突患眩冒。其症头眩眼花，睁眼则天旋地转，眼前昏黑，起则眩晕加剧，且作恶心呕吐，终日闭眼而卧，喜静恶噪，饮食须由他人喂饲，尚可进食流粥；唾涎增多，津津欲唾，腹中漉漉如水声；脉见弦滑，苔滑色灰。予诊时病已十余天矣，询前医曾用“苓桂术甘汤”、“桂枝加龙骨牡蛎汤，”等方，以及应用西药，均未见效。思患者素体虚寒，加以痰饮阻遏，使阳气不升于上，故起则眩晕加剧，寒病属阴，故喜静而恶噪，寒饮上逆，故口内津津欲唾，甚则腹中水声漉漉可闻。前医所拟诸方，虽能逐饮，但嫌力轻；且专逐饮则中虚难复，中虚不复，则饮邪难除。

处方：干姜　党参各6克　半夏9克　桂枝4.5克（后下），茯苓15克　水煎温服，4剂而恢复健康。数月后复发

一次，证象如前，照方再服，亦获良效。

5．**虚寒痞满**：痞症起于胃虚，然有寒热之别。其中胃虚而热邪郁结者，仲师立诸泻心法，可随证选用；但属于寒邪者，《伤寒论》虽有“旋复代赭汤”一法，对寒邪盛者，究难获效。因方内旋复花虽然涤痰消结，但究系肺经本药，以之治膈上之痰结则可，治中焦虚寒之痞，则其力有所不及；而代赭石味苦性寒，亦非虚寒者所宜。本人曾用“干姜人参半夏汤”加附子一味，以治虚寒之痞满，效果甚为满意。举例如下：

柳妇，壮年农民。夏月饮冷，晚间突患吐泻交作，肠鸣腹痛，服西药和应用注射剂，至晨吐泻腹痛均除，转为胸脘痞满，壅塞不舒，嗳气频频，唾液津津。继服“旋复代赭汤”不应，改延余治。六脉沉细，苔白津多，舌淡中冷。盖因中土本虚，加之寒湿伤中，中焦运化受阻，而致吐泻交作，现吐泻虽止，但中焦阳气未复，阴寒冷饮阻滞，气化无权，故痞塞胀满也。治宜温里散寒，佐以和胃祛痰。

处方：干姜　附子各6克　党参9克　半夏4.5克　水煎温服，病遂霍然。

体　会

1．干姜人参半夏丸是仲景先师用治妊娠呕吐之方；但必须掌握其呕吐系由胃虚有寒饮所致者，方能合拍，推而广之，本方用治由于胃虚有寒饮所致的其他病症，如腹痛、吐逆、眩晕、痞满等，亦皆有效。但必须认定虚寒二字，以呕吐物稀薄澄清或口内清涎上泛，唾液津津，舌苔白滑，舌质

淡白为应用标准。于此更体现了中医“异病同治”的特点；同时也说明了“治病必求其本”的重要意义，因中医治病，全凭辩证论治；而辩证论治，又必须建立在“审证求因”的基础上，才能做到“辩证”明确，“论治”精当。

2．干姜、半夏，后世方书皆列为妊娠禁药，但用之适当，并不损胎。至于半夏，后世用于妊娠期者，则更不鲜见。本人在临床中亦常用这两药以治疗妊娠期的疾病，并未发现任何损胎事故。但必须在辩证明确的情况下，药适其用。则“有故无陨”也。若漫无法则，盲目乱用，则非《内经》本意。录自（《中医杂志》1964年第9期“应用干姜人参半夏汤的一些经验”林善星）

延按：干姜人参半夏汤（丸），药仅三味，但方剂组合非常精当。用干姜温中散寒，人参补正益气，半夏、姜汁蠲饮降逆。对胃虚兼有寒饮的疾患是有一定效果的。案中所举五个病例虽表现症状不同，但致病的原因相同，所以治疗原则亦不变。例一，妊娠呕吐，与金匮条文所述相符，故用原方治疗。例二，虚寒吐逆，因病情顽固，汤剂效果不佳，乃以本方依金匮法作丸，另加吴萸以温降厥阴上逆之寒气，取丸者缓之之意，使药力在胃中持续发挥作用。例三，虚寒腹痛，用本方温中散寒，因寒凝气滞作痛，故加良姜以行气止痛。例四，痰饮眩晕，用本方温中逐饮，加苓、桂增强温化水饮之力。例五，虚寒痞满，病由吐泻后，脾肾之阳俱伤，故用本方温健脾胃之阳，外更加附子以温肾阳，符合“补火以生土”之义。

当归贝母苦参丸加味证案

小便不利

樊氏，青年农妇，劬劳家务，又常作业田间，因家贫，故不敢一日偷闲。1944年夏伤于湿热，饮食如常，而小便不利，有涩痛感。李医认为湿热，先服五苓去桂，加滑石不应，再服八正散亦鲜效。迁延半月，精神饮食减退，肢倦无力，不能再事劳作。切脉细滑，面色渗淡，气促不续，口干微咳，少腹胀痛，大便黄燥，小便不利而疼。此下焦湿热郁滞，与上焦肺气不宣，上下失调，故尿闭不通。师古人上通下利之旨，用宣肺开窍诸品，佐渗利清热药为引导，拟用当归贝母苦参丸①（改汤）加桔梗、白叩、鸡苏散（六一散加卜荷）等，……二剂而小便通利，不咳，尿黄而多，此湿热下降之征兆。更以猪苓汤②加海金沙、瞿麦，数剂小便清，饮食进，略为清补即安。

注：①《金匮·妇人妊娠病脉症并治》

②《金匮，消渴小便不利淋病脉症并治》 录自《赵守真治验回忆录》

延按：本案所表现一系列症状，属下焦湿热郁滞，上焦肺气不宣的缘故。四苓、八正仅治其下而忽略其上，故鲜效。案中拟用清上导下之当归贝母苦参丸，以贝母清热散结解上焦肺气之郁，佐桔、叩以开提肺窍。苦参利湿热，除热结，辅以鸡苏散，更增强入膀胱清热利水之功。以当归和

血润燥，补其劳倦之虚。继以猪苓汤加海金沙、瞿麦，滋阴利水，清除积热，作善后收功之计，使邪去而正不伤，方称良治。

竹叶汤加味证案

产后风痉

付××，女，34岁，1960年3月就诊，

主诉：产后三日，初起微寒发热，头痛，继而热升，（38.8℃），汗出而红，微喘，欲呕，手足抽搐。舌质红，苔白腻，脉浮大而芤。

诊断：产后气血两虚，外感风邪，营卫失调而致痉。

治则：调和营卫，行气补血祛风，拟《金匮》竹叶汤加减。

处方：党参6克　葛根10克　桂枝　竹叶　姜半夏各6克　附子　防风　桔梗各5克　炙草3克　生姜3片　大枣3枚　一日一剂，服二剂。

复诊：发热已退，喘平痉止，纳香，二便通调，脉和缓。续服前方一剂而愈。

按：产后风痉，亦属伤寒之太阳中风痉症，病虽同，而治则异，盖产后气血两虚，治宜固其本，佐以疏风祛邪。方中党参扶正补气，葛根、竹叶清热，桂枝、防风祛风，附子温阳固本，半夏化痰止呕。录自（《闽北中医医案选》邹武

县医院，朱本）

延按：竹叶汤方见《金匮·妇人产后病脉症治》篇，为治“产后中风，发热，面正赤，喘而头痛”，症。本案亦系产后气血虚，因感外邪而致痉。故借用此方，祛邪以扶正，因症见汗出面红，脉浮大而芤，有虚阳上越之势，故用参、附以回阳固本，因有欲呕现象，故加半夏以止呕。其余药品，不外疏风清热，标本兼顾，施于此症恰好。

半夏厚朴汤证案

梅核气

张溪亭乃眷，喉中哽哽有肉如炙脔，吞之不下，吐之不出，鼻塞头晕，耳常啾啾不安，汗出如雨，心惊胆怯，不敢出门，稍见风即遍身疼，小腹时疼，小水淋涩而疼，脉两寸皆短，两关滑大；右关尤抟指，此“梅核气”症也。以半夏12克，厚朴3克，紫苏叶4.5克，茯苓3.9克，姜3片，水煎食后服，每用此汤调理多效。录自《孙一奎三吴医案》

延按：本方载《金匮·妇人杂病脉症并治》篇，治七情郁结，痰凝气滞，上逆于咽喉之间，后世称为“梅核气”，方名半夏厚朴汤。案中所述主要症状，与金匮所载基本相符，故用之获效。此症用此方并不难，难在于有耳常啾啾不安，汗出如雨，心惊胆怯等一系列真实类虚之假象，足以惑人。如果结合脉象考察，则种种症状，都属痰湿蒙蔽清阳所

致。水湿无从下泄，阻于中则心悸胆怯，迫于外则汗出如雨，此方辛以散结，苦以降逆，有化饮祛痰，行气解郁之功，用之得当，药简功宏，无以平淡而忽之。

半夏厚朴汤加减证案（五例）

半夏厚朴汤见于《金匮要略》，为治疗妇人咽中如炙脔者而设。方用半夏、厚朴、生姜辛以散结，苦以降逆，茯苓甘淡化气，苏叶芳香宣气。

笔者在临床上曾以本方治疗梅核气、咳喘、呕吐、脘痛、胸痹等属于气机郁滞，痰湿内蕴者均能取得较好的疗效。

1．梅核气

此病多由情志怫郁，肝失调达，胃失和降，痰湿内蕴，气机受阻，痰气相抟而成。

蔡××，女，28岁。病起情志怫郁，咽中梗塞不舒，吐之不出，吞之不下，胸闷不畅，欲嗳不爽，纳谷不馨，泛泛欲呕，脉象弦，苔薄白，肝郁气滞，痰湿内踞，梅核气也。拟舒肝理气而化痰湿，用本方加味。除药物外，当宜怡情适怀，以助药力之不逮。

处方：法夏9克，厚朴3克，老苏梗6克，竹茹、旋复花、茯苓各9克，新会皮、佛手片各4.5克，生姜2片。

服上方二剂，自感喉中较舒，胸闷亦渐宽畅，纳谷较前

为振，再予上方续服二剂，诸恙即瘥。

2．咳喘

七情郁结，气滞痰凝，肝木乘肺所致之咳喘气急，用本方亦有佳效。

单××，男，37岁。宿有咳嗽气急之患，湿痰偏多，近因情志怫郁，气机痹阻，以致咳嗽气急，痰多色白而稀，胸闷不畅，纳谷不馨，脉象弦细而滑，舌苔薄腻，治拟舒展气机，肃肺化痰。**处方**：法夏6克，厚朴3克，苏子梗、茯苓、杏仁、旋复花、佛耳草各9克，桔红4.5克，莱京子12克，甘草0.24克，药后咳嗽气急大减，胸闷较开，再予原方续服三剂，咳喘即平。惟纳谷依然不振，继以健脾强胃之品服三剂全愈。

3．脘痛

脘痛一证，气滞居多，凡属七情郁结，失于条达，生痰生湿而致脘痛者，用本方很适应。

谢××，男，21岁。脘痛牵引两胁，胸闷嗳气频频，纳谷乏味，口渗清涎，脉象弦滑，舌苔薄腻，病起肝郁气滞。痰湿内阻，胃失和降，用本方损益。**处方**：姜半夏4.5克，厚朴0.18克，茯苓、麦芽各12克，苏叶、陈皮各4.5克，炒枳壳4.5克，甘草0.24克。

服上方二剂，脘痛大减，惟负重力屏气后又致胸闷且痛，口仍渗清涎，脉象尚弦滑，苔厚腻。拟原方加炒竹茹9克，红枣4枚，服二剂愈。

4．呕吐

情志不和，肝气犯胃以致上逆之呕吐，在临床上颇为多见，治宜舒肝理气，和胃降逆本方亦可用之。

吴××，女，40岁。肝气怫郁，胃失降和，呕吐泛恶，胸脘痞闷，嗳气较舒，二便尚调，脉象弦细，舌苔薄滑，治当舒肝理气，和胃降逆。**处方**：姜半夏　老苏梗　茯苓各6克，厚朴3克，旋复花9克　代赭石12克，陈皮4.5克，　甘草0.24克，生姜3片。

服上方一剂，呕吐止，续服一剂愈。

5．胸痹

胸中为阳之位，清阳之府，如离照当空，不受纤翳，胸阳不旷，痰浊凝滞，气机痹阻，脾胃运化功能失健，治当苦降辛开，滑利气机，予瓜蒌薤白半夏汤合本方服之有效。

单××，男，40岁。胸闷且痛，太息或嗳气较舒，微咳少痰，脉象弦细，舌苔腻，此乃气滞不畅，痰湿内蕴，胸阳痹阻，不通则痛也。拟辛滑通阳，化痰宣气。**处方**：法夏、薤白各6克，制川朴、甘草各0.24克，苏叶梗、桔红、枳壳各4.5克，全瓜蒌、连皮苓、杏苡仁各9克，生姜2　片。服上方二剂后，诸症均减，苔腻渐化，脉象如上，再予前方续进两剂而愈。

体　　会

半夏厚朴汤《三因方》中加大枣又名四七汤，有舒郁宽

膈，燥湿祛痰之效。适用于气滞不畅，痰湿内蕴诸症均有佳效。但药偏辛燥，阴虚之体，肝阳偏亢，或气郁化火之证，则不宜用。录自（江苏中医1964.10半夏厚朴汤在临床 应用的体会。程聚生）

延按：本案运用《金匮》半夏厚朴汤加减治疗痰湿阻滞上中焦部分，气逆不降诸种疾患无郁久化热伤阴现象即可使用，因此就扩大了本方治疗范围。观其随症加药处亦恰当病情，具见斟酌。

甘麦大枣汤证案（六例）

脏躁（歇司底里，癔症）

1．长林胡某，延诊妇病，据述症经半载，外无寒热，饮食月事如常，惟时时悲泣，劝之不止，询其何故，伊不自知。延医多人，有云抑郁，用逍遥散者，有云痰火，用温胆汤者，药俱不效，又疑邪祟，禳祷无灵，咸称怪症，恳为诊治。视毕出语某曰：易治耳。

处方：甘草　小麦　大枣　某问病名及用药方法。予曰：病名“脏躁”，方乃甘麦大枣汤，详载金匮玉匮中，未见是书，不识病名，焉知治法，宜乎目为怪症也。某疑药只三味，且皆平淡，来卜果能去疾否？予曰：此仲圣祖方，神化莫测，必效无疑，服之果验。

安波按：有时法于古而不泥于古，有时竟法于古而泥于

古，此之谓良工也。录自《程杏轩医案续录》

2．徐××，女，28岁，已婚，家务。主诉：爱人代诉病史，哭泣吵闹，有病已50天，呈间歇性发作，自1948年以来，先后发作数次，发作期间神识不清，胡言乱语，甚则毁物伤人，自称神鬼附体……每遇事不遂意即有发作。1958年11月5日，病人往市场购买衣料，结果买了被单，十分懊悔的说："买错了，买错了。"当天晚上病人是大声涕泣，呜咽失声，劝说无效，以致彻夜未眠，于翌晨照常起床工作，次日晚间仍不能入睡，至半夜即放声大哭，追询何故，亦不自知，一周后病人呈意识模糊状态，而与邻居纠缠不清，并胡言乱语，语言前后不连续，甚则出言骂詈，有时诉说胸部不适，拉着别人的手放在胸口，一会儿要喝水，一会儿要吃梨，当给予时吃了几口又丢掉。有时突然表现全身肌肉紧张，四肢僵直，口吐白沫，不一会又突然大声叫嚷，或自言自语，有时躺在床上，一会儿开灯，一会儿熄灯，手足不住的动着，当别人对她态度凶些，病人即说："有声音刮风下雨……。"甚至连自己的爱人和孩子也辨识不清，于同年12月26日进入我院，体检无异常发现。精神状态：意识不清，仪表不整，秽洁不分，不易接触不合作，并有伤人毁物行为，生活不能自理，动作增多，有搔扰不宁的现象，情绪易波动，时或激怒，时或悲泣，甚则裸体露形，而把墙头上的石灰涂抹满脸满身，问话对答不适切，但未见妄想和幻觉内容，智能欠佳，自知力缺如。经诊断为"歇司底里"精神性发作，采用甘麦大枣汤治疗，于服药二剂后转安静，连10帖而痊愈出院。

3．徐××，女，35岁，已婚，农民。

家属介绍病史，于1958年10月病人因事不遂意而哭笑无常，自言自语漫骂不停，昼夜不眠，甚则有伤人毁物行为，呈间歇性发作，每次发作均与外界刺激因素关联，平素个性急躁，胸襟狭隘，高傲好胜，遇事不肯相让，但又表现胆怯，情感亦脆弱，入院时体检无异常。精神状态：神志清楚，仪表整洁，接触良好，病人对周围环境关注，双目富于活力，向四处顾盼，情绪易波动，如病人提起不如意的往事即放声哭泣，但当谈到高兴的事情虽然泪液未干，亦即笑颜满面。对发病经过叙述无缺，问话对答中肯，主动语言增多，说话时有滔滔不绝的现象……”。但未发现病态思想内容和感知障碍，一般智能良好，自知力不全，经诊断为歇司底里精神性发作，虽曾使用镇静剂及电针等疗法均未获效，于是采用甘麦大枣汤进服二剂后即酣然成寐，连服10剂而愈。

方剂配制及用法：

方剂：甘麦大枣汤

主治：适用于神志恍惚，无故悲伤，哭泣叫嚷，吵闹躁扰不宁，夜眠不安者，尤以“脏躁”症为佳。

药物：北小麦30克　粉甘草9克　大枣7枚。

制剂及用法：水煎日服二次，可连服十至十五剂。录自（1960年2期《中医杂志》“甘麦大枣汤治疗歇斯底里精神性发作25例的疗效观察”周勤芳　葛萍）

4．女，22岁，未婚，南京第四机械厂。

1957年12月10日初诊：据云生母已故，父续娶，常被继母虐待，生活环境不佳，常有厌世之念，现虽离家在××机械厂学习机工，但因平素刺激过深，郁闷难解，初则自觉胸

闷嗳气，头痛健忘，心悸肉瞤，性躁易怒，数月之后，渐见日夜不寐，哭笑非常，默默不欲食，言语错乱，首尾不相应，经服西药，鲁米那儿，六硫二苯胺，三溴剂等效果不显。见其神情如痴，言语不正，时作太息，时而欢笑，时又流泪，诊脉弦劲，舌苔薄黄尖红，津少口干，有阴虚液少之象，乃断其为癔病。即用生甘草15克，小麦120克，红枣150克，浓煮去甘草，啖食。二剂后，即感精神清爽，五剂恢复正常，十剂全愈，照常工作。1958年3月1日复诊：因工作紧张，睡眠减少，略感头痛，健忘，心悸肉瞤，为仍处原方减轻剂量（甘草12克，小麦90克，大枣120克）十剂，服后全愈，迄今未再复发。

5，女，16岁，未婚，业农。据云：1956年秋，因骑牛放草，被牛突然带入河中，以致受惊，以后渐觉精神失常，哭笑不定，烦躁失眠，语无伦次，饮食无时。二年来，经服中西药甚多，病势不减。1958年7月10日来南京，经××等医院断为癔病，给予钲静剂无效。于7月12日来本院门诊：先治以豁痰平肝熄风之剂，并针神门、太渊、丰隆、大椎、照海等穴，效亦不显。15日复诊，见其时哭时笑，胡言乱语，答非所问。诊得脉来弦数，舌红无苔，口干欲饮，大便干燥，乃属阴虚阳亢，津液不足之象。即用生甘草12克，黑大枣　小麦各60克，每日煎汤服一剂。两剂即安定，四剂后神志清爽，一如常人，续处原方数剂，返六合家乡，经访问迄今未再发作。

6．女，21岁，已婚，家务。

1958年6月23日初诊。自诉：平时性急多怒，1958年春，因其妹病死，悲伤过甚，于是渐觉胸闷不适，中脘胀

满，嗳气频频，饮食难化，大便干结，二三日一行，咽干口燥，烦躁，失眠，喉间似有物阻，吞咽不下，吐之不出，绵延二三月，曾服中西药无效。其脉来细弦，舌尖红苔薄腻，当时以为是肝郁气滞，故先用半夏、厚朴、紫苏、枳壳、代赭石、旋复花、木香、砂仁、丁香、竹茹、生甘草等，以钲逆利气，讵知连服三剂无效。后即改用生甘草15克，小麦，大枣各60克，紫苏叶9克，煎浓汤续服四剂，所有症状，大为减轻，又服五剂全愈。据访问得知，迄今并未发作。

原按：通过古代文献的温习及临床实践，证明促使本病的原因，是由于情志过度失调，精神长期刺激所致。所谓五志生火，内灼阴液，阴液损伤，则血气衰少，五脏空虚……于是水精不得四布，五经不得并行，有消耗而无补充，则百脉必致失养，故出现口唇、咽喉、舌质等异常干燥，多饮不能解渴，便秘、溲黄、烦躁、不寐、哭笑不得等等，一派阴虚液少，急迫难忍之状。仲景所以称为“脏躁”（是指脏中干燥，并非单纯的指子脏或子宫而言，不过此病患者以妇女为多，故仲景列入妇人杂病篇中）而治法着重于甘润滋养，以补其不足而缓其急迫。《素问·举痛论》说：“悲则心系急”。《素问·金匮真言论》说：“东方青色，入通于肝”。“其谷麦。《素问，脏气法时论》说：“肝苦急，急食甘以缓之”，等等。实足为后人治疗本病的南针，仲景师其意，而立甘麦大枣汤一方，可谓水乳相洽，正合机宜，故其效如桴鼓也。……窃思甘麦大枣汤治疗本病，不但效果确实而迅速，且价廉物美，味甘可口，病人喜食，尤其对性情执拗，好恶非常，不肯服药的患者更为适宜，且药性和平，毫无付作用产生，即可充饥，又能治病，诚属一举两得，不过

使用本方的分量宜重，如甘草须用至四、五钱以上，效力方显，如果咽干口燥较甚者，可酌加归、芍、地、冬；烦躁不安者，加入龙、牡、酸枣；兼有癔球（仲景名为炙脔，金鉴名为梅核气）而觉喉间阻塞，无舌红、口燥、咽干之象者，宜与《金匮·妇人杂病篇》中的半夏厚朴汤合并使用，则效果尤佳。同时再配合适当的精神疗法，以除其原因，更换患者境环与生活等，亦属必要，并且根据先贤的经验记载，以及本人的临床试用本方对于其他的神经系诸病，如严重的神经衰弱、舞蹈病、癫、狂、痫症，小儿夜啼等，凡一切阴虚阳亢津液不足，而呈现干燥急迫难忍之状者，只需多服久服，皆有相当疗效。录自（1960、4，总41期《浙江中医杂志》）“运用甘麦大枣汤治疗癔病的经验简介》刘景辉）

延按：“脏躁”，“歇思底里”，“癔症”，是一种疾病的三个名称，本方见《金匮·妇人杂病脉症并治》为治“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作。”方中用甘草、大枣味甘缓诸急，小麦养心肝而止躁。案中诸病例所表现的症状，与金匮所述基本相符，故用之获效。考王孟英先生曾治一朱姓妇，既多悒郁，又善思虑，所谓病发心脾也。（症状从略）而平昔畏药，虽极淡之品，服之即吐，遂用此方，以红枣易大枣（当时所用之枣当系黑大枣）取其色赤补心，气香悦胃，加藕以舒郁怡情，合之甘、麦并能益气养血，润燥缓急。如此施治竟能愈难治之痼疾，真可谓灵心妙手，善于化裁古方者矣。参阅陆士谔编《分类王孟英医案》损症类自明。

温经汤证案（二例）

血　崩

1．姚××，女，37岁。

病历：病已年余，每月经行量多如冲，临期又须淋漓多日始净，平日腰酸白带甚多，曾经西医院妇科检查，诊断为“子宫机能性出血”，并经刮宫治疗。

症候：经来如冲，腰酸形寒怯冷，面色㿠白，头晕心悸，舌薄白，脉细弱。

治疗经过：患者由于出血过多，血室空虚，胞宫虚寒。姑拟温经汤治疗，当时仅服四剂而经净，但经净后仍予原方调理半月余，患者于次月经期复诊，月经非复过去之多了。

2．秦××，女，36岁，职工中学校教员。

病历：月经每月超前而行，量多如崩，甚则下瘀块，病经二年，时发时止，曾经西医作组织切片病理检查，诊断为非器质性病变，由于出血过多，曾输血，并经刮子宫治疗未愈。

症候：月经超前六七日，来如血崩，少腹尚舒，面色萎黄，眼圈灰暗，头晕，神疲，舌薄根部起芒刺，脉细弱无力。

治疗经过：投以温经汤，服药后月经即减少，但由于病久体虚，经净后仍原方加减调治，以资巩固，最后患者每月行经甚为正常，面色华润。

讨　论

机能失调性子宫流血，系月经过多与血崩两大临床指征，非属子宫器质性疾患而引起的出血。本症为妇科常见之疾病，妇女患此病后，经年累月去血过多，往往引起身体极度虚羸。

温经汤方见《金匮·妇人杂病脉症并治》篇……仲景所说："下血崩中，或月水过多"，当然我们不能完全理解为就是机能失调性的子宫流血，但根据辩症观点，温经汤实适应于机能性子宫流血之症候。我们临床所见妇女血崩之后，则冲脉虚寒，气血两亏，出现种种虚象，如面黄，畏寒，腰酸，白带，脉细等，而大多数无少腹作痛症象，虽也可能有虚性作痛，但痛面喜按，而不是拒按。方中以吴萸、桂枝、生姜之温经暖宫，以人参、当归、芍药、川芎、阿胶、丹皮、麦冬、半夏、甘草为之补气血和冲任，所以获效。录自（1961年9期《江苏中医》"温经汤治疗机能失调性子宫流血"，俞济人）

延按：此案当与温经汤加味症案合看，同是血崩，同用温经汤，但彼案因肝郁气滞，故于方中加入行气和血之品；此案则气血虚衰现象较多，所以用原方不必加减，可见运用古方，亦须根据病情，灵活掌握，不能固执不变。

温经汤加味证案（二例）

1．血　崩

温妇年五旬，新孀之下，儿媳不顺，因之情志不适，月经当断而反多，前后参差，时久始净。渐至夜间潮热，少腹隐痛，口干难寐，乃以经济困难，延未医治。讵知某夜大崩血下，迄明未至，神疲已极，自煎参汤服食。次日迎诊，按脉细微欲绝，面唇惨白，舌胖无苔，腹痛口燥，手足烦热，血尚淋漓未停，身常自汗等候。审值更年之期，经血应止，反致血崩大下，皆由冲任虚寒，邪犯胞宫，肝郁气滞，瘀留不行，一旦内外触引，故暴发而不可止遏。本证不仅寒盛血虚，且兼郁热，治当兼顾。若认大崩血虚，一味温补，殊难收指顾之效。因处以温经汤。（注）如方中吴萸、丹、桂入血散寒行瘀，归、芎、阿胶生新止血，人参、夏、草益气降逆，麦冬清除烦热，又加香附、降香之行气和血，则视原方周到而于证更切也。煎服一时许，腹中震动大鸣，旋下黑色血丝甚多，再进血崩即止，三进热退安眠，精神转佳，末用人参养营汤，归脾汤善后调理。注：见《金匮·妇人杂病脉症并治》录自《赵守真治验回忆录》

延按：本案通过一系列脉症观察，确属大崩血虚之候，但起病原因，又兼有气郁热壅，似此标实本虚，法当兼顾，所以用养正去邪的温经汤以治本，再加香附、降香之行气和血以治标，师古而不泥古，方称善治。

2．经闭

黄××，女，18岁，1961年2月。患者平时刻苦练功，酷喜冷饮，耗热伤气，致伤阳明气血，不月者年余矣。且带下如注，头昏、心悸，演唱时，气短不续，纳少，便秘。脉象沉细而紧，舌苔淡白，阳明气血不足，冲脉为之不利也。治病必求其本，当为温养胃家气血，宗仲圣温经汤化裁。

处方：淡吴萸0.24克，龙眼肉12克，黑大枣5个，鲜生姜3片，炙甘草、陈艾叶、清阿胶各6克，麦冬、玉竹、楮实子各9克，四物丸12克（包煎），广木香0.24克，砂仁3克，资生健脾丸9克（包煎），核桃肉9克。

另：矾石丸3粒，每隔日用一粒纳入阴道内。药为：枯矾、杏仁、蜂蜜合剂。

〔**注**〕：《素问，上古天真论》，“太冲脉盛，月事以时下。”以冲脉为十二经之海，脏腑之血，皆入冲脉，故冲脉盛，月事得以时下。冲脉固为月经之本，然究血气之盈否，由于水谷饮食之盛衰，冲脉之血，总由胃府水谷所化，可见胃气与冲脉息息相关，则月经之本，本于冲脉，必借阳明为之枢机也。《素问，阴阳别论》，“二阳之病发心脾……女子不月。”夫冲脉与阳明合于宗筋，会于气街，而阳明为之长，阳明者，水谷之海也，故心脾受病，心脾胃三经皆病，冲脉无血气以泽灌，故女子为之不月。仲景阐发内经奥旨，制有温经汤。由于患者系一演员，勤学苦练，耗热伤气，平素贪凉饮冷，久之，中土阳衰，纳谷减少，化赤无源，心虚不能供血，脾虚无以统血，冲无血养，寒气内凝，

地道不温，有如雪地冰天，血凝气滞，经闭不行，周身络脉，失于濡养，头昏，心悸，大便干结，土不生金，气短不能接续，经闭日久，胞宫湿郁为热，故下白物如带也。本例宗温经汤意加味，温养胃家气血，不着重逐瘀而经自行。录自（《江苏中医》1962，7，34页困学斋医案）

延按：本案治疗方法，系宗金匮温经汤方化裁，减去行血祛瘀药品，另加入龙眼肉、大枣、木香等药物，似含有归脾汤意，此症根据其致病原因，所以不重在祛瘀，（因温经汤系治妇女冲任虚寒而有瘀血，少腹冷痛的病症），而注重温养阳明，健运胃气，使气血有生化之源，同时配合外用坐药，内外并治，因而获效。

大黄甘遂汤证案

产后血水相结

癸未六月，有店伴陈姓者，其妻患难产，二日始生，血下甚少，腹大如鼓，小便甚难，大渴。医以生化汤投之，腹满甚，且四肢头面肿。延余诊视，不呕不利，饮食如常，舌红苔黄，脉滑有力，断为水与血结在血室，投以大黄甘遂汤，先下黄水，次下血块而愈。病家初疑此方过峻。予曰：小便难，知其停水，生产血少，知其蓄瘀；不呕不利、饮食如常、脉滑有力，知其正气未虚，故可攻之。若泥胎前责实，产后责虚之说，迟延观望，俟正气既伤，虽欲攻之不能

矣。录自（《广东中医》1962.8.34页"易巨药医案选录"）

延按：《金匮·妇人杂病脉症并治》篇载："妇人少腹满，如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血俱结在血室也，大黄甘遂汤主之。"案中所述症状，虽与金匮不完全相符，但由水与血互结所导致的病理是一致的，所以借用本方治疗。其所叙舌苔、脉象，足供临床参考。至其判断水与血互结的根据，在于小便难和生产血少两点上看出，并不考虑其产后之虚而毅然投以攻下剂者，一在于有金匮条文的理论作指导，一在于观察其脉症均属有余，并非孟浪妄施峻药者可比。

大黄甘遂汤合桂枝茯苓丸加减证案

少腹胀痛

谭秋香，三旬孀妇。子女绕膝，日忙于生计，操劳过度，悒悒于心，以致气血内耗，身体渐羸，月经不行，少腹肿胀，行动则喘促，数月于兹，切脉细数而涩，口干不渴，大便燥结，两三日一行，小便黄短，少腹不仅肿胀，有时乍痛，虽闭经已久，尚无块状。窃思本病关键，首须明悉经闭与肿胀之先后，如肿胀由经闭而起，则以通经为先；如经闭由肿胀所引发，则以利水为宜。细询之下，其为经闭先而肿胀后，乃属于瘀血郁积，而小便又不利，则不仅血结亦且水

结矣。况其先由思虑伤脾，忧郁伤肝，肝伤则气滞血瘀，脾伤则运化失常，久则累及于肾，水不宣泄而停蓄其中，故水与血互结而为病。本症瘀水交结，同属严重，如逐瘀而不行水，则瘀未必去；祛水而不逐瘀，则水未必可行，法当标本兼治。用大黄甘遂汤（大黄、甘遂、阿胶）①桂枝茯苓丸（桂枝、茯苓、丹皮、芍药、桃仁）②合剂。　处方：大黄、阿胶各9克，甘遂1.5克（另冲）　桂枝、丹皮各6克，茯苓12克，桃仁9克，加丹参15克，土鳖4.5克，服后便水甚多，杂有血块。又三剂，水多而血少，腰腹胀减，已不肿，诸证消失。改用归芍异功散调理，无何经行痛解，又进归脾汤善后，时经一月，遂得康复。录自《赵守真治验回忆录》

注：①《金匮·妇人杂病脉症并治》

②《金匮·妇人妊娠病脉症并治》

延按：本案处方系大黄甘遂汤合桂枝茯苓丸减芍药，加丹参、土鳖而成。案中解积肿胀由经闭而起，宜先通经，经闭由肿胀引发，宜先利水，是本于《金匮·水气病脉症并治》篇所说“经水前断，后病水，名曰血分，此病难治；先病水，后经水断，名曰水分，易治。”之理论加以阐述。但本案病情，不仅瘀阻，又兼水结，单纯行瘀与祛水，均不相宜，故采用合方治疗。就方中药物的组合来看，仍以祛瘀为主，利水药品，仅甘遂、桂枝、茯苓三味，去芍药，加丹参、土鳖不过增强其祛瘀之力。可见病情变化，必须随症处方，正不必泥守古方一层不变也。

肾气丸证案（二例）

1．肺实肾虚喘咳

久咳喘不得卧，颧赤足冷，胸满上气，饥不能食。此肺实于上，肾虚于下，脾困于中之候也。然而实不可攻，姑治其虚，中不可燥，姑温其下。且肾为胃关(注)，火为土母，或有小补，未可知也。

处方：金匮肾气丸

注：《素问，水热穴论篇》“肾者，胃之关也。”

治按：拟再用旋复代赭汤送下，则上中两层，亦可关会矣。录自（柳选《静香楼医案》）

2．小儿口渴尿多

王女新琼，4岁。病由吐泻而起，先失治理，后又治不适宜，延至一月而吐泻始已，无何尿多而渴，家人不以为意，几至形销骨立，不能起行，奄奄床第，又复多日，始来延治。按脉细微，指纹隐约不见，神志清明，睛光亦好，唇淡白，舌润无苔，语微神疲，口渴尿多，饮后即尿，尿后即饮，不可数计，肢冷恒喜被温，尿清长，无油脂，食可稀粥半盂，大便好。是病由于阴虚阳衰，不能蒸化津液，以致尿多渴饮；又因病久气虚，故神疲肢冷，已属阴阳两虚之极。差幸能食便好，脾胃机能健运，元气几微尚存，此为本病有转机之重大环节。此时滋阴扶阳均极重要，如阳极阴生，火

能化水，津液四布，病则自已。因选用《金匮》肾气丸(注)，借以蒸发肾水，升降阴阳。方中附子、肉桂温阳，熟地、山药滋阴，丹皮清虚热，山茱涩精气，茯苓健脾升化，泽泻补肾清利，用以治小儿脾泻而成阴亏阳微之口渴尿多证，将丸改作汤服。同时用蚕茧15克，洋参3.5克，山药30克，蒸作茶饮。服药四剂，渴尿减半，至七剂则诸证悉已。后以五味异功散加补骨脂、益智、巴戟、枸杞等温补脾肾，调养一月而瘳。

注：《金匮·妇人杂病脉症并治》录自《赵守真治验回忆录》

延按：柯韵伯对本方的解释谓："欲暖脾胃之阳，必先温命门之火，此肾气丸纳桂、附于滋阴剂中……命门有火，则肾有生气矣。故不曰温肾而名肾气。"例一的喘咳，是由肾阳不足，不能化水，因而肾虚水泛为痰所致。故以温下为主。原按拟用旋赭汤送下肾丸气，治法更见周到。例二的口渴尿多，饮后即尿，尿后即饮，与《金匮·消渴小便利淋病脉症并治》"男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，肾气丸主之。"症状相符，所以借用之有效。

又按：古方肾气丸中之桂，系用桂枝、根据后世临床经验证明，以用肉桂为佳。

肾气丸加骨碎补证案

虚寒齿痛

纲兄质亏多病，予为调治，所用药剂，不外归脾汤，补

元煎之属。一日遣使相促，予至时将薄暮，绸兄踡卧榻上，起告予曰，早晨齿牙忽痛甚，不可耐，至今不止，恐挟风热外因，故停前药，相烦诊视，暂解标邪。切脉沉细无力，见症形寒足冷。谓曰：此属虚寒，非关外感，不徒用补，更须从温。爰仿古方八味地黄汤加骨碎补，一服痛已。录自《程杏轩医案续录》

延按：叶天士外感温热篇验齿节谓："初病齿缝流清血，痛者胃火冲激也；不痛者龙火内燔也。"余意以为前者属实火，牙龈多红肿，后者属虚火，牙龈多不红肿。至叶氏所用之玉女煎。（生石羔、熟地、麦冬、知母、牛夕，张景岳方）是治阴虚胃火炽甚之齿痛。本案齿痛虽同属于虚，但虚中兼寒，观其脉沉而细，症见形寒足冷可知。故用六味加桂附以治，所谓虚火宜引也。考骨碎补一物，性苦温，能补肾而收浮阳，对肾虚阳浮之牙疼有效，故方中加入此味。

再按：本方不仅治虚寒阳浮之齿痛，并可治虚阳上浮之口舌糜腐。忆余在家乡私人开业时，曾治一吴姓老年男性病员，业屠宰，其人嗜茶，喜饮酒，患口腔糜烂，舌已脱皮痛甚，口流涎不止，遍服清热解毒药数十剂，无效，痛更加剧。不得已求治于余。余诊其脉浮大鼓指，但重按无力，足膝不暖喜温复，并不喜饮水。此肾虚火浮，用肾气丸（改汤）桂用上好肉桂研末冲服，以引火归原，不数剂愈。

（一）《千金》方医案

小续命汤证加减证案（二例）

1、餐泄

吕沧洲治一人，病下利完谷，众医咸谓洞泄寒中，日服四逆，理中等弥剧。吕诊其脉两尺寸俱弦长，右关浮于左关一倍，（脾入逆肝），其目外皆如草滋，（脉浮色青，非风而何），盖知肝风传脾，因成餐泄，非脏寒所致。饮以小续命汤减麻黄，加白术三五升利止，续命非止利药，饮不终剂而利止者，以从本治故也。录自《名医类案》

2、中风

徐洄溪治运使王公叙揆，自长芦罢官归里，每向余言，手足麻木而痰多。余谓公体本丰腴，又善饮啖，痰流经脉，宜搏节为妙。一日忽昏厥，遗尿，口噤，手拳。痰声如锯，皆属危症，医者进参、附、熟地等药，煎成未服。余诊其脉，洪大有力，面赤气粗，此乃痰火充实，诸窍皆闭，服参、附立毙矣。以小续命汤，去桂、附，加生军3克为末……三剂而有声，五剂而能言，然后以消痰养血之药调之，一月后，步履如初。录自《洄溪医案》

延按：小续命汤系麻桂二方加补气之参、草，养血之芎、芍，并有防风治风，防已治湿，附子治寒，黄芩治热，为治外中风邪的通用方剂。例一，吕案下利完谷，服四逆，理中不效，借用本方加白术获效者，以湿多成五泄，取风能胜湿，补土以制水之义。例二，徐案系肥人中风，痰火充实于内，风邪闭阻于外，故用麻黄、防风开表，是火郁发之之义。去助热之桂、附，加通里之生军，仿防风通圣散方意。俟表里气机通畅，然后用消痰养血药品以善后。运用古方妙在化裁得法，庶有利而无弊。

又按：徐洄溪云："名曰中风，则其病属风可知，既为风病，则主病之方，必以治风为本，……盖以风入经络，则内风与外风相煽，以致痰火一时壅塞，惟宜先驱其风，继清痰火，而后调其气血，则经络可以渐通，今人一见中风等症，即用人参、熟地、附子、肉桂等，纯补温热之品，将风火痰热，尽行补住，轻者变重，重者即死，或有元气未伤，而感邪浅者，亦必迁延时日，以成偏枯永废之人。"读徐氏此论，可为中风不问外邪有无，遽用补塞之药者，引以为戒。

生脉散加味证案

中风五精相并

吴少参老先生年五十，新得美宠，荣归祭祖，跪拜间，

就倒仆，汗注如雨，浑身壮热，扶至床褥，人事不省，速接名医治疗，众医齐至，俱谓先用纯牛黄灌之。予后至，诊其脉关尺浮数而空，两寸透入鱼际，此阴虚甚而阳亢极也。因谓病家曰：无灌牛黄，灌之即死矣。急用生地自然汁一升，人参30克，麦冬15克，五味子100粒，煎浓灌之，至二三服，神气稍定，汗止，是夜似睡非睡，至五更时，作恐惧状，如人将捕之。至清晨，又作盛怒状，骂詈不止。至午间，又大笑一二时。至薄暮，又悲泣。自此夜静日作，病家以为鬼祟，众医束手。予思之，此即内经所谓五精相并也。"并于肾则恐，并于肝则怒，并于心则喜，并于肺则悲。"(注)，刘河间云："平时将息失宜，肾水不足，心火亢极，乃显此症。"夜间阴盛，邪乃暂息，日中阳隆，遂游行五脏而无已时也。仍用前方减人参之半，旬日间，或但悲笑，或但骂詈，恐惧。人事时省，时不省，饮食与之，尽食方止，不与，不思索，大小便亦通，至半月后，而诂妄不作，自后调养气血之药，至百剂而始愈。

注：《素问·宣明五气篇》

卢绍庵曰：肾水衰极，火无制而游并五脏，五更肾水用事之时，火并而作恐惧状；清晨肝木用事之时，木并而作怒骂状；日中心火用事之时，火并而作喜笑状；薄暮肺金用事之时，火并而作悲泣状。录自（陆氏三世医验，第一世陆养愚医案）

延按：本案根据脉证，断为阴虚甚而阳亢极之征。故用生脉散加味以施治。考生脉散为益气敛汗养阴生津之方，方中以能补肺益气生津的人参为主药，以养阴清肺生津的麦冬为辅药，以敛肺生津的五味子为佐使药。另加入生地自然汁

以增强养阴作用，似仿张景岳两仪膏意。如再加入天门冬则有三才汤意。总之，本方是一个治疗阴液元气两伤，以及精气太虚，或克伐太过耗损真气所致的疾患。本症以阴虚为主，由阴虚而导致阳亢，用一派养阴之品，本“壮水之主以制阳光”（王太仆语）立法。若猛浪施用牛黄，是虚以实治，危可立待。

生脉散加味证案

热病战汗

圣翁夫人，夏间病患热盛无汗，烦渴昏沾，医治旬余不解……延予视诊，脉数舌黄。谓曰：此热病也，非清不可，疏竹叶石羔汤与之。时夜将半，闯叩扉声甚急，启视，荫兄慌入而言曰，病危矣，询其故。曰妙剂，当服头渣，至暮未见动静，再服复渣，更静后，忽寒战肢抖，少顷汗出如浆，肤冷息微，闭目不语，众以为殆，归咎药性太凉，欲投参附以救其脱，亟求复诊以决之。予即随往，扪其肌肤果冷，细按脉虽虚软，然至数和缓，并不急疾。曰无妨，此战汗也，因本气不足，邪气鸱张，予重用清剂驱之，邪不能留，遂与正争，是以战而汗出。邪虽从此而解，正亦由此而亏。且任其养息，切勿惊扰，元气来复，自然肤暖神甦，若骤进参、附，诚恐余烬复炎，反为害矣。叶氏论温热病战汗解后，胃气空虚，有肤冷一昼夜之说，取书与阅，群疑始释。另立一

方，用生脉散加茯神、玉竹、白芍、甘草，嘱市药煎好，俟其苏醒与服，并啜稀粥，以养胃气……遵嘱静守逾时，汗敛神甦，忙将煎好之药服讫，复睡至晓，肌肤已温，惟形倦气怠耳，更为辅正养阴和胃，渐次而康。

安波按：斯证若脉急数，自汗如雨，躁烦不安，神志不宁，自是气脱阳越之候，速宜大剂回阳，与此大相悬绝。录自《程杏轩医案续录》

延按：本案引叶氏语解释热病战汗之病理甚佳，这是天士先生临床之宝贵经验，值得珍视。此症当肤冷战汗之际，如果医者无定识，旁人多议论，杂药乱投，必致功败垂成，仍归咎于前医之误。考生脉散系补肺敛肺滋阴生津之方，用于热病汗多纯虚无邪之症恰好。再加安神宁心之茯神，养阴润燥之玉竹，酸甘化阴之芍、甘，较原方更为有力。佐以啜热粥，借谷气以生津，治法非常周到。至善后之辅正养阴和胃方，不过沙参麦冬汤，参苓白术散之类而已。

生脉散合八味地黄汤证案

伤　风　戴　阳

许晴霁室人，患伤风咳嗽，诸医投以疏风清肺之药，渐至潮热口渴，尚不知误，更以柴、葛、知母、花粉之属进之，遂变面红目赤，舌刺无津，渴汗齐来，诂语无次。余临其帷，视之骇怖。固知其阳已戴于上也。而前医本所素信，

匆匆复至，惘惘一视，尚谓传经热症，急取雪水服之。盖仅知其上热，而不知其下寒也；知其脉洪，而不知其大空也。因令煎龙眼汤觔许，遂疏八味地黄汤合生脉散，是晚进药不辍。次早复视，俾无根飞越孤阳，才得退藏于穴。复追进附桂理阴煎，数十剂全愈。录自《谢映庐医案》

延按：王孟英先生在其伤风治案中云："此喻氏所谓伤风亦有戴阳证也，不可藐视。"本案为体虚人患伤风咳嗽，只知散邪，忽略养正，过投表散清解而致戴阳的救误治法。所谓上热，当指面红目赤，舌刺无津，渴汗齐来，诂语无次等症。所谓下寒，案中虽未明白指出，当有足膝不温下利溏便等症。再察其脉虽洪大但重按无力，更足资证明。治法用生脉散养肺生津止汗，用八味以引火归元，为肺肾兼顾之方。善后用张景岳之理阴煎加桂附，是脾肾同治之法。至用龙眼肉觔许煎汤以补养心脾气血，不外增加其营养作用而已。

犀角地黄汤证案

温毒发斑

张少卿，年22岁。感染温毒时行而发。症现面赤唇红，一身手足壮热，血毒外溃，神烦而躁，发出红斑。诊其六脉洪大，右甚于左，舌鲜红，阳明血热无疑，血为阴，气为阳，阳盛则烁血，血热则发斑矣。治法：凉血解毒以泄络热，故以犀角、生地之大寒为主药，以芍药、丹皮之微寒为

佐药，热泄火熄，则斑黄阳毒皆净尽矣。 处方：鲜生地30克，犀角尖6克，赤芍18克，丹皮7.5克，一服热清斑透，继用清养法调理而痊。

廉按：温毒发斑，犀角地黄汤，却是正治，故《千金》古方，平时不可不研究也。录自《全国名医验案类编，曾月根》

延按：如果血热而瘀，则犀角地黄逐瘀力弱，宜参考《增补评注温病条辨》下焦篇20条霖按：加入丹参、桃仁、琥珀之类药品，似更有力量。

犀角地黄汤加味证案（二例）

1、吐血厥冒

昨日所溢之血，盈盆成块而来，无怪乎其厥矣。幸得厥而即醒，夜半得寐，其气稍平。今日仍然上吐，脉来芤数，火升颧红，咳逆时作，大便不爽而黑，阳明胃府，必有伏热，防其再冒再厥。

处方：犀角地黄汤加三七、牡蛎、龟板、枇杷露 录自《清代名医医案精华，曹仁伯医案》

2、血逆阴虚阳亢

心脉独大，口干易汗，善怒血逆，此心阴不足，心阳独

亢，宜犀角地黄汤加味。

处方：犀角地黄汤加茅根、甘草、山栀，

诠按：方案均精简熨帖。录自（柳选《静香楼医案》）

延按：例一，吐血而兼颧红，咳逆，脉芤数，故于方中加牡蛎、龟板以滋阴潜阳，枇杷露以润肺降逆，三七以止血化瘀。例二，由于心脉独大，故于方中加山栀以泻心火，口干易汗，血易上逆，故加茅根凉血止血，生甘草泻火止渴。"令甘守津还之意。"（叶天士外感温热篇中语）

麦门冬汤证案

咳　血

何湘元素有痨病，咳嗽吐血，逐年未已。其子绍川，初感风寒作咳，未经疏解，即服滋阴清热药，咳更剧，辟辟中仅有些须痰出，久致杂有鲜血，又以为肺热，进紫菀汤止血润肺，病未少减，驯至神疲肌削，潮热盗汗，渐入虚劳之门。自认为是乃父遗传，无可奈何。切脉浮而细数，咳逆气短，潮热寝汗等劳证毕具。溯其初起，由先日风寒未解，内闭成热，虚火上炎，肺金受损，真阴内亏，火动其血，血随火升，故咳嗽咯血之证起。虽为火热内扰，而前感未清，可自其咳则清涕出等脉浮二者知之。但肺热当清，陈寒宜祛，法当全面兼顾，选用《千金》麦门冬汤。以麻黄、生姜宣肺祛寒，紫菀、半夏、五味镇咳敛肺，生地、麦冬、桑皮、桔

梗、竹茹清热祛痰，甘草调协其中。药后咳汗均减，夜得少卧，再服前方三剂，汗与潮热俱无，痰少血止，脉不浮而细数，是风邪去而肺热未清。改投滋阴清肺之百合固金汤（生熟地各9克，玄参15克，川贝、桔梗、麦冬、芍药、当归各9克，甘草6克），加鸡金、谷芽以和胃，四剂各症皆除，惟纳食未健，处参苓白术散以补脾益气，早晚吞服六味地黄丸以滋肾，历时月余，食欲增进，面色丰润，神采奕奕矣。

《录自赵守真治验回忆录》

延按：考《千金》麦门冬汤，是在《金匮》麦门冬汤方中，去参、枣、粳米，加生地、桑皮、桔梗、竹茹、紫菀、五味、麻黄、生姜等品组成。为治大病后火热乘肺，咳唾有血，胸膈胀满，上气羸瘦，五心烦热，渴而便秘之方。此症系由火热内扰于肺，而风寒外邪未解，遽用滋清，致邪无出路。治法必须内清肺热，外祛寒邪。或疑火热乘肺，咳唾有血，何以反用麻黄、生姜，岂知寒邪闭表，非麻黄不能开之，痰凝气结，津液不行，非姜、夏不能祛之。迨热清表解后，始转手而用滋阴清肺之法，终用补脾滋肾之剂以收功。

麦门冬汤加减证案

咳　喘

张路玉治吴江郭邑侯，喘嗽气逆。诊之两尺左关弦数，两寸右关涩数……夏暑内伏肺络，遇秋月燥收之令，发为咳

嗽也。自言每岁交秋则咳，连发四载，屡咳痰不得出则喘，至夜不能卧，咳剧则大便枯燥有血，曾服越婢汤，嗽即稍可。张曰：公肾气素强固，水亏火旺，阴火上烁肺金，金燥不能生水，咳甚则便燥有血者，肺移热于大肠也。合用《千金》麦门冬汤方，除去半夏、生姜之辛燥，易以葳蕤、白蜜之甘润，借麻黄以鼓舞麦门冬之力，与越婢汤中麻黄、石羔分解互结之燥热，同一义也。郭曰：诸医咸诋麻黄为发汗重剂不可轻试，仅用杏仁、苏子、桔梗、前胡等药，服之其咳转甚何也？曰：麻黄虽云主表，今在麦门冬汤中，不过借以开发肺气，原非发汗之谓。麻黄在大青龙汤，麻黄汤，麻杏石甘汤中，其力便峻，以其中皆有杏仁也。杏仁虽举世视为治嗽通药，虚实混用，然辛温走肺，最不纯良，耗气动血，莫此为甚，熬黑入大陷胸丸，佐甘遂等搜逐结垢，性味可知。遂用前方，连进二剂，是夜便得安睡，脉弦虽未退，按之稍软，气口则虚濡乏力，与六味、生脉，加葳蕤、白蜜作汤，四服嗽顿减，即以此方制丸恒服，至秋无复嗽之虞。录自《名医类案》

延按：本案解释麻黄加入麦门冬汤的清润剂中治咳喘，仅收到开发肺气的作用，不能发汗，与协同杏仁治咳嗽的功效不同。并列举了《伤寒论》中麻杏同用的方剂为证。其说理议药，均值得注意。

苇茎汤加味证案

肺　痈

湖北葛店，万姓妇女，患肺痈，病已危急，远道着人邀诊。入门后隔寝室尚远，即闻病者鼾喘声，至病室，见其床侧置箕箕一具，内铺柴灰，上积病者所吐之五花脓痰厚半寸许，约计不止一菜碗。询问经过，据答吐如此脓痰已一周矣。行近病榻，见其靠坐，面部微肿，眼珠外突，鼾喘如曳锯，胸前拒按，烦郁胀闷，脉劲数，时或一止，参伍不调，断为肺痈，化脓穿溃，病已濒危。……予思《金匮》有言："始萌可救，脓成则死。"玩一"则"字，有急转直下意思。今吐脓血七日不死，或有一线生机；又思《金匮》主葶苈大枣泻肺汤，是肺痈将成，乘其未集，今脓已成，原方不适宜，因又取《千金》苇茎汤合裁加减：

处方：苦葶苈18克　苡米15克　瓜瓣24克　桃仁9克　鲜竹沥24克　鲜苇茎150克　熬水煎药，三日进三服，胸痛见松，鼾喘见缓，痰浊渐稀，原方加减，嘱再服三剂。服药病机又再减缓，仍宗前方，加重其制，又日服二剂，约半月，鼾喘始止，脓血始净，前后用葶苈约450克，始意不敢多用，又泻又服，出意料外，始终未腹泻，后以瓜贝养营汤，《外台》十味煎(注)调摄收功。此病自起至愈，时仅两月，病愈后面色丰腴，皮肤润泽。

注：《外台》卷十肺痈方九首有"备急疗肠痈肺痈

方：”药为：（升麻　白敛　漏芦　芒硝　黄芩　枳实　连翘　蛇衔　栀子　蒴藋根）录自《冉雪峰医案》

延按：此案敢于如此用药，是由于患者脉症俱实，肺气壅阻日久，已有化脓穿孔现象，故采用《千金》苇茎汤为主方，加入苦葶苈之祛痰定喘，开肺窍之闭，竹沥之清热滑利，解胶结之痰，这样就增强了苇茎汤的排脓宣壅力量，此症能转危为安，良由识高，故能胆大。

苇茎汤合甘桔法证案（二例）

1、肺痈

王氏，58岁。初起喉痹，为快利药所伤，致成肺痈。胸中痛，口中燥，痹仍未痊，不食不寐，痰气腥臭，已有成脓之象，脉短而数，寒热且移于大肠而泄泻，难愈之症，勉与急急开提肺气。议《千金》苇茎汤与甘桔合法。

处方：苦桔梗60克，桃仁15克，冬瓜仁15克，生苡仁30克，甘草30克，鲜苇根120克，

水八碗，煮成三碗，渣再煮一碗，分四次服。

2、肺痈

堂伯兄，40岁。饮火酒，坐热炕，昼夜不寐，喜出汗，误服枇杷叶、麻黄等利肺药，致伤津液，遂成肺痈，臭不可

当，日吐脓二升许，用《千金》苇茎汤合甘桔法。

处方：苇茎240克，苦桔梗90克，桃仁45克，苡仁60克，冬瓜仁45克，生甘草30克，

煮成两大菜碗，昼夜服完碗半，脓去十之七八，尽剂脓去八九，又服半剂，毫无臭味，后以调理脾胃收功。录自《吴鞠通医案》

延按：以上两例，均是肺痈，同用苇茎汤合甘、桔，考《金匮·肺痿肺痈咳嗽上气病脉症治》中，治肺痈共出两方，一为葶苈大枣泻肺汤。治肺痈，喘不得卧，或咳逆上气，喘鸣迫塞。但葶苈大枣泻肺汤，并无明显肺痈症状，故所称之痈，当作壅塞之壅来理解，是治外感兼宿水之方，观其与小青龙汤并用可知。一为桔梗汤，治肺痈时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥，但桔梗汤治肺痈，终嫌药力轻薄，症较重的，必须于此方中另加药味，所以吴案以桔梗汤与《千金》苇茎汤合用来治疗本证。

又按：后世治肺痈严重症，以徐洄溪立法最佳。他说："予平日因此症甚多，集唐人以来治肺痈之法，用甘凉之药以清其火，滋润之药以养其血，滑降之药以祛其痰，芳香之药以通其气，更以珠黄之药解其毒，金石之药填其空，兼数法而行之，屡试必效。"考何廉臣曾仿徐法治一肺痈重症获效，（案长从略），可参阅《重订通俗伤寒论》第八章伤寒兼证第十七节赤膈伤寒"廉勘"条下自明。

半夏茯苓汤减味证案

妊娠呕吐

沈尧封说：车谓津治费姓妇怀妊三月，呕吐饮食，服橘皮、竹茹、黄芩等药不效。车用二陈，加旋复花、姜皮水煎，冲生地汁一杯，一剂吐止，四剂全愈。沈谓此方即《千金》半夏茯苓汤去细辛、桔梗、川芎、白芍，按呕吐不外肝胃两经病，人身脏腑，本是接壤，怀妊则腹中增了一物，脏腑机括为之不灵，水谷之精微，不能上蒸为气血，遂凝聚而为痰饮，窒塞胃口，所以食入作呕，此是胃病。又妇人既有妊，则精血养胎，无以摄纳肝阳，则肝阳易升，肝之经脉夹胃，肝阳过升，则饮食自不能下胃，此是肝病。《千金》半夏茯苓汤中用二陈，化痰以通胃也。用旋复、高者抑之也。用地黄、补阴以抑阳也。用人参、生津以养胃也。其法可谓详且尽矣。至若细辛亦能散痰，桔梗亦能理上焦之气，川芎亦能宣血中之滞，未免升提。白芍虽能平肝敛阳，仲景法胸满者去之。故车氏皆不用，斟酌尽善，四剂获安有以也。录自《续名医类案》

延按：本案分析病情，解释药理，非常详尽，深得运用古方化裁之妙。

神秘汤加麻黄证案

风水喘肿

李时珍治一人妻，自腰以下浮肿，面目亦肿，喘急欲死，不能伏枕，大便溏泻，小便短少，服药罔效。其脉沉而大，沉主水，大主虚，乃病后冒风所致，是名风水也。用《千金》神秘汤加麻黄，一服喘定十之五，再以胃苓汤吞深师薷术丸，二日小便长，肿消十之七，调理数日全安。

俞东扶曰：神秘汤人所罕用，而善用之，则奏奇功。神秘汤乃生脉散合二陈汤，去麦冬、茯苓，加紫苏、桑皮、桔梗、槟榔、生姜三片为引，施于此症恰好，加麻黄更好，并非八寸三分通行之帽也。录自《名医类案》

延按：此案由于病后冒风，虚中兼实，故以人参、五味补肺敛肺，桔梗宣肺、以紫苏、半夏、陈皮、桑皮、槟榔、生姜等芳香之品以畅利气机，气行则水自行。俞按认为此方施于此症恰好，加麻黄更好，好在何处？俞氏未明确指出。考麻黄之作用有三：1．发汗，2．定喘，3．利尿，但麻黄必须配伍桂枝，并加温服，发汗之力始峻，案中服麻黄后之反映不言汗出而云一服喘定十之五，则用麻黄之意义，在定喘而不在发汗可知。因方中既有补有敛，又有畅气行水诸药配伍应用，虚实兼顾，考虑非常周到，若无辛温力猛之麻黄入肺开其壅遏，则诸药殊难发挥其应有的作用。余意如此，当否？质诸高明。

又按：麻黄利尿作用，余无言氏在其《伤寒论新义》麻附细辛汤条下解释说："不知麻黄之用，不但发汗，更可利尿。"又说："先君子奉仙公，于逊清光绪年，为湘军记名提督董军门宝泉聘掌幕府时，董公偶冒风寒，无汗，恶寒，头痛，服麻黄9克，不得汗而小便大利，因以获愈，是麻黄一品，遇体质特异，毛窍固密之人，专走小便而不走皮毛也。"观此则麻黄利尿之说，又得一有力的证明。

温胆汤加味证案（四例）

1、痰火惊悸

惊悸易泄，腰疼足软，有似虚象，而实因痰火。盖脉不弱数，形不枯瘁，未可遽与补也。

半夏　炙草　秫米　橘红　茯苓　竹茹

远志　石菖卜

诒按：此秫夏合温胆汤加味也。认证既确立方自然入彀。彀，（音遘，张弓弩）

2、痰热痫厥

搐搦厥逆，合目则发，此肝胆痰热，得之惊恐，病名痫厥。

半夏　橘红　竹茹　胆星　炙草　石菖卜

枳实　茯苓

诒按：痰火之邪，因惊恐而直犯肝胆，故见症如此。卧则阳气入于阴，合目则发，是阳气扰动阴脏，致痰火猝发而病作也。方中拟加羚羊角、黄连，　录自（柳选《静香楼医案》）

3、痰火气郁

胃中素有酒湿，适因斗欧恼怒，引动肝胆之火，与胃中之痰相搏。致心跳少寐，食入则呕，两手脉沉，是气郁也。用温胆汤加味。

半夏　石菖卜　陈皮　甘草　枳实　枣仁

茯神　枳椇子　竹茹（姜汁炒）

诒按：既有木火内扰，则川连、栀、丹，本不可少也。录自（柳选《环溪草堂医案》）

4、春温夹痰热

高尔昌，年40余，业商。素因嗜厚味，内积痰热，又外感时邪而起。症见头痛身热，胸脘痞闷，烦躁不安，舌苔黄且渴，已延一候。诊脉浮滑且数，浮脉主表，滑脉主痰，数脉主热。以脉合症，此春温夹痰热病也。方书论温病，有伏气外感之分，此症因素嗜厚味，痰热内蕴，又值时令温暖，腠理开泄，外感时邪，肺先受病，故见头痛身热，胸脘痞闷，烦躁不安等症。前医进辛凉解表之剂，如荆芥、豆豉、卜荷、牛蒡、银、翘、甘、桔等味，服后胸烦如故，而表热

亦未尽解。考《临症指南》温热门结论云，此病夹有痰热者，用温胆汤，盖夹有痰热之人，痰热熏蒸于外，亦足以致身热而有余，必须清其痰热，则身热胸烦自解，其理甚明。治法用蒌贝温胆汤加味，以清其痰热，兼宣通气分，则诸病自除。 处方：瓜蒌霜4.5克，瓜蒌皮9克，法半夏4.5克粉丹皮、炒枳实各4.5克，通草3克，川贝9克，茯苓、神各9克，焦山栀9克，淡竹茹4.5克，六一散12克，橘红3克，冬桑叶9克，广郁金、射干各4.5克，

服两帖身热胸烦尽解，更用清养胃阴之药，调理数日而痊。

廉按：辨症既明，方亦清稳，是得力于叶法者。 录自《全国名医验案类编，魏树森》

延按：温胆汤系二陈汤加竹茹、枳实、生姜、大枣组成。后世用此方减去姜、枣较合理。本方主治胆虚痰热上扰，虚烦不寐。药用二陈燥湿祛痰，理气和胃，竹茹、枳实清胆胃热以降逆，为一清胆和胃方剂。温胆的温字，应作温和的意义去理解。（见《金鉴》名医方论罗谦甫解释）本案中例一，因惊悸为痰火所致，故以治痰火为主，不为腰疼足软的假虚症状所惑而妄施补品，识见自高人一等。例二，痫厥由痰热导致，较例一病情严重，故加入胆星、莒卜清化痰热兼开窍之品，并应参考“诒按”再加羚羊角、黄连，则药力更强。例三，因怒动肝火，引发胃中之痰与之相搏，致心跳少寐，故于宣化痰热药中加枣仁、茯神以宁心安神，又兼素有酒湿，故又用枳椇子以解酒毒，再参考“诒按”加入治木火内扰之川连、栀、丹等品。例四，春温夹痰热，故用温胆汤加蒌、贝、山栀、桑叶、通草、郁金等清热豁痰宣通气

分之品。从以上四例中可以看出，虽同属痰热引起的疾患，但因兼症不同，故随症情变化而加减药味，使之适合病情，才能达到治疗的效果。

温胆汤法证案

肝　厥

乐××，女，39岁，工人。

患者起病于第四胎产后，因亲族逝世，突受惊恐而昏厥，引起产后奶少、纳差、不寐、心悸、恐惧等症。产假满后上班，单位内发生火警，又受惊吓，使病情更增，随后时好时坏。1958年以后，即长期病休。1963年再因亲戚逝世而悒郁不欢。嗣后，整整二年零四个月卧床不起，有时一日之中发厥竟达5～6次之多。发厥时，手足冰冷，四肢抽搐，牙关紧闭。十年内，屡送急诊，并经各医院以各种药物治疗，均未见效。经中药治疗后，病情明显好转，能起床走路，仅情绪激动或气候变化时偶有小发。近十年来，未再用药物治疗，情况良好。

初诊：1965年6月3日，惊恐伤肝，肝郁化火，火炎于上，上凌心肺。寤不安寐，心悸摇荡，疑虑恐惧。胆虚则怯，怯则多疑，肝厥屡作，胸次失旷。纳钝苔厚，舌尖红刺。拟以温胆法。

处方：珍珠母30克（先煎）　苍龙齿18克（先煎）　勾

藤12克（后下） 麦冬 柏子仁 朱茯苓 炒枣仁 合欢皮各12克 半夏6克 橘皮4.5克 炒竹茹6克 小枳实3克 甘草0.24克 泡远志4.5克 七帖

二诊：6月12日。近日来肝厥不作，而身有微热，手背漫发隐疹，掀红烦痒，风热挟肝胆郁热互灼，心悸少寐，疑虑恐惧，胸次失旷，小溲色赤。舌苔较化，面有红点。续拟温胆兼清泄为治。

处方：霜桑叶 东白薇 朱连翘各9克忍冬藤 白茯苓各12克 赤芍 丹皮 郁金（生打） 半夏（杵） 炒竹茹各6克 橘皮 甘草 泡远志 佛手片 川通草各4.5克 白叩（杵）3克 滑石12克 车前子15克 银柴胡3克 朱茯苓12克 七帖

患者肝厥发作已明显减少，能起床走路。续以上方出入治之，以疏展肝胆气郁，清化下焦湿热，逢经行则以四物汤去川芎，加入紫丹参、泽兰叶、制香附之类调理月经。

再诊：8月25日。湿热已渐清利，气滞较为疏展，潮热获退，胸脘较舒。肝阳偏胜，头脑昏眩，心悸少寐，呕泛已减，脉小弦。再以清柔和展为治。

处方：生石决24克（先煎） 珍珠母30克（先煎） 明天麻 半夏各6克 焦山栀 竹茹各9克 勾藤（后下） 白蒺藜 朱茯苓各12克 橘皮 泡远志4.5克 小川连0.18克 小枳实3克 车前子15克

本例嗣后继续以黄连温胆汤合清柔及疏展之品随症出入加减治疗。其间曾因胃机不和，而参以广藿梗、鸡内金、香谷芽、佛手片、白豆叩等和胃。调治三月余，而基本痊愈。

按：本例起病于产后血虚，突受惊恐，正《内经》所谓

“恐则气下……惊则气乱。”致使产后气机紊乱，气血失其调和，而发为肝厥一症。嗣后两度受惊，竟至一病不起，病历十年之久。《临证指南医案》华岫云指出：“惊之所伤，由心猝及乎胆，由胆即及于肝。”可见，本病发展至今，主要是由于肝胆郁结，失于疏泄，郁久化火化风，凌心横逆，东犯西窜，而迭变诸症。

综观本案处方用药，始终以温胆汤随症加减治疗而取效。温胆汤，据《千金方》记载，功用很明显，是治疗心气不足、胆虚不宁的良方。而施治于本例，在前阶段，由于身有潮热、湿热下注，故加入退虚热、清湿热之剂；后阶段，由于肝阳偏胜，则加入清柔之品；但温胆法始终坚守不变。可见在临床上，必须抓住疾病发生的根源，同时，随着病情的变化，而灵活地随症施治，但消除根源仍是主要的。录自（内科临证录，陈道隆医案）

延按：本案对因惊恐引起昏厥的疾患，运用温胆汤为基础方，随症情变化，佐入清柔疏化药物，收到治疗效果，案后对病机分析，明白晓畅，可供临床参考。

鲤鱼汤证案

膨胀

太阴所致，发为膨胀①者，“脾主散津”②，脾病不能散津。“土曰敦阜”③，斯膨胀矣。厥阴所致，发为膨胀

者④，肝主疏泄，肝病不能疏泄，木穿土位，亦膨胀矣。此证起于肝经郁勃，从头面肿起，腹固胀大，的系虫胀，而非水肿，何以知之？满腹青筋暴起如虫纹，并非本身筋骨之筋，故知之。治法以行太阳之阳，泄厥阴之阴为要。医者误用八味丸，反摄少阴之阴，又重加牡蛎，涩阴恋阳，使阳不得行，而阴凝日甚，六脉沉弦而细，耳无所闻，目无所见，口中血块，累累续出，经所谓血脉凝泣者⑤是也。势太危急，不敢骤然用药，……惟鲤鱼孙真人曾用之。但孙真人原方，去鳞甲，用醋煮，兹改用活鲤鱼，大者一尾得六斤，不去鳞甲，不破肚，加葱一斤，水煮熟透，加醋一斤，任服之。

处方：鲤鱼一尾

注：①《素问·阴阳应象大论篇》"浊气在上，则生膨胀。"

②《素问·经脉别论篇》"脾气散精，上归于肺。"

③《素问·五常政大论篇》"土曰敦阜。"

④《素问·五脏生成论篇》"过在足少阳、厥阴，甚则入肝，腹满膨胀，支膈胠胁。"

⑤《素问·离合真邪论篇》"寒则血凝泣。"

录自《清代名医医案精华·吴鞠通医案》

延按：考鲤鱼汤载《千金要方》治妊娠腹胀满，或遍身浮肿，胎间有水气，小便赤涩。药用鲤鱼，（重斤许者，去鳞）一尾，白术150克，茯苓120克，当归、芍药各90克，橘红3克，生姜7片，本案借用此方，只取鲤鱼一味，佐入葱、醋，以治此证。查《千金翼方》载："鲤鱼肉味甘，主咳逆上气，黄疸，止渴，生者主水肿脚满下气。《本草纲目

求真》谓："鲤鱼气味甘平，每于急流之水，跳跃而下，是鲤已有治水之功，且甘能入脾，故书载能下气利水。"葱外实中空，能入肺兼入肝，气味辛散，宣通上下之阳。醋气温味酸苦，故书多载散瘀解毒下气消食。"观此三味合用，共奏行水通阳散瘀之功，故不必伍以利水药品，更力专而效宏也。

鲤 鱼 汤 证 案

妊 娠 子 肿

吕××，女，29岁，工人。1974年8月6日初诊。患者1968年结婚，曾于1970年、1971年及1973年三次怀孕，均因妊娠中毒症（妊娠水肿）伴羊水过多，致胎腹胀大畸形，娩出死胎，并产后大流血，三次均须输血抢救。产科谓为"孕卵发育畸形，"为母体安全计，建议绝育。因患者求子心切，心情矛盾苦闷，乃求诊于我院。其时患者精神颓唐，少气懒言，自诉口淡，胸闷，食少便溏，容易疲乏。诊其面色萎黄虚胖，苔薄白而润，脉虚滑，为一派脾虚湿盛的脉证。……治疗先以参苓白术散加减：党参30克，白术、茯苓、苡仁、扁豆、淮山各30克，莲肉、北芪各15克，陈皮、春砂各6克，以健脾渗湿。连服20余剂。自觉饮食增进，疲乏渐减，乃停止服药。1975年经停受孕（末次月经1月3日），伴有恶心呕吐等早孕反应，与往次妊娠相比虽稍有减轻，但

仍觉四肢重坠，并有小便短少现象，与往次妊娠水肿前的感觉有相似。为预防水肿再发，乃嘱其用《千金》鲤鱼汤治疗。处方：鲤鱼一条（半斤以上）去鳞肠，水煮取汁，入白术、茯苓各15克，当归12克，白芍9克，大枣30克，陈皮3克，生姜8片同煎服。患者从怀孕第二个月就开始按医嘱每月服4～5次，一直服到妊娠九个月，未加用其他药物治疗。整个孕期轻松愉快，食欲增进，肢坠减轻至消失，一改过去孕三个月就开始浮肿的现象。产前多次检查血压，尿常规均正常，浮肿（一）。1975年10月18日作产，入××医院，（因检阅过去病历，仍疑有胎儿畸形，乃拍腹部平片两张，未发现异常）。1975年10月20日顺产一男婴，重7.8市斤，未有任何先天畸形。该婴儿现已二周岁，体格及智力发育正常。

讨论：查妊娠中毒症合并羊水过多为产科常见急症之一，严重危害着母子的安全。据文献报导，羊水过多，有40%胎儿发生畸形，故胎儿娩出的死亡率很高。且一次发病有多次复发的趋向（本例连续三次，且都是畸形死胎）。由于发病机制不明，故防治不易。祖国医学虽无妊娠中毒症名称，但对妊娠呕吐、浮肿及子痫等早晚期妊娠中毒症的表现则远在《金匮要略》、《巢氏病源》、《千金》、《外台》等古籍中已有记载。《金匮·妊娠病脉证并治》篇中就有，“妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之。”可说是关于妊娠水肿最早的记载。后世医家根据水肿的症状、部位等特征，将其分为子肿、子气、子满、脆脚、皱脚等名称。……本例全身浮肿，腹胀气喘，小便短少属“子满”，“子肿”范畴。先以参苓白术散加减补

气健脾，和胃渗湿以举其脾阳；后以《千金》鲤鱼汤安胎理脾，去湿行水；使脾得健运，水气散精，上归于肺，下输膀胱而收良效。

鲤鱼属本经上品。《别录》"治怀妊身肿及胎气不安"。李时珍谓："鲤乃阴中之阳，其功长于利小便，故能消肿胀。历代医家相继用鲤鱼治各种水病，用法各异。兹录一、二以资参考。《范汪》用大鲤鱼一头，醋三升，煮干食，一日一作。《外台》用大鲤鱼一尾，赤小豆一斤，水二升，煮食饮汁。

笔者通过此例的实践，尝以此方介绍给一些曾有浮肿孕史的妇女服用，均能减轻或避免浮肿而毫无副作用。因此认为本方在预防妊娠期间浮肿或妊娠中毒症方面有实用价值，可起到安胎行水的卓著功效。录自（新中医1979，2，"《千金》鲤鱼汤的应用"，沈鼎荪）

延按：本案用《千金》鲤鱼汤治疗妊娠子肿，获得良好效果。鲤鱼是本方中起主要作用的药品，经引据《别录》和李时珍的解释，功效更见明确。最后又介绍了《范汪方》及《外台》治各种水病服鲤鱼的方法，更觉简捷易行，且属食物，既有营养价值，更少不良的副作用，临床之工，盍试用之。

备急丸证案（二例）

1、食伤太阴

罗谦甫治博儿赤马剌，年卅余，因猎得兔，以火炙食颇多，抵暮至营，极困倦，渴饮潼乳斗余。是夜腹胀如鼓，疼痛闷乱，卧起不安，欲吐不吐，欲泻不泻，（此症不发热，无外症），手足无所措，举家惊惶。罗诊其脉，气口大二倍于人迎。乃应食伤太阴经之候也。右手关脉又且有力。盖烧肉干燥，因而多食，则致渴饮，干肉得潼乳之湿，是以滂满于肠胃，非峻急之剂则不能去。遂以备急丸五粒，觉腹中转失气，欲利不利。复投备急丸五粒，又与无忧散15克，须臾大吐，又利十余行，皆物与清水，相合而下，约二斗余，腹中空快，气渐调，至平旦，以薄粥饮少少与之，三日后，再以参术等药，调其中气，七日而愈。录自《名医类案》

2、食厥

许细长，石工。病少腹胀痛，坚硬如石，医用消导药，转至吐蛔，便尿俱闭。更医目为寒凝厥阴，投以姜、附、吴萸，痛剧而厥，肢冷脉伏。急来延予，予以手按其少腹，见其眉攒难忍之状，谓其妇曰：此食厥症也。妇曰：病果因食冷面而起，然已服过消导药无效，或药力不及，亦未可知。第停食小恙，何至厥逆吐蛔，便尿俱闭。予曰：谷食下行，由少腹右角后出广肠，今食积不下，故大便不通，直肠紧

张，撑迫膀胱，小溲因而不利，下既不通，气反上行，故为呕吐。呕多胃逆，蛔必上攻，是以随呕而出。务得大便一通，通则不痛，诸症自释矣。但病经多日，凝滞已坚，非精锐之品，不能奏绩，旋进备急丸9克，顷之腹中雷鸣，下结粪数枚，再与4.5克，复泻十余行，厥回脉出，痛减腹软，后畏药不服，将息而起。录自《程杏轩医案初集》

延按：案中所用之三物备急丸，见《千金翼方》卷卅，药为：大黄　干姜　巴豆　主暴病胀满。若中恶客忤，心腹胀满刺痛，口噤气急，停尸卒死者，以水若酒服大豆许，三四枚，捧头起令得下喉，须臾不差，更服三枚，腹中转鸣，得吐利即差。方中用辛热峻下，开通闭塞之巴豆为主药，温中祛寒以顾脾阳之干姜为辅药，既能通大便，又能监制巴豆辛热毒性之大黄为佐使药。凡寒滞食积阻结肠胃，升降气机痞塞，致卒然腹痛，脘腹胀满高起，甚至面青气喘，不属温热暑邪所致的疾患，均有捷效。柯韵伯谓："备急丸治寒结在肠胃，以攻不化之糟粕也。"观以上两案，一为食伤太阴，一为食冷面致厥，都有肠胃闭结症状，均用此方，均收到满意效果，真深得张子和心法者也。至1例中所用之无忧散，据《中国医学大辞典》载：一，《儒门事亲》方：药为　黄芪　木通　桑白皮　陈皮　胡椒　白术　木香　牵牛头末，二，《证治准绳》方：(甲)药为　人牙　雄黄　珍珠（一方加牛黄），(乙)药为　当归　川芎　白芍　枳壳　乳香　木香　甘草　血余　予意本案当以用《儒门事亲》方为佳。

三物备急丸证案（二例）

食　滞

1．蒋××，女，52岁，业农。

因食团子6个，当夜即觉脘腹疼痛，伴有恶心嗳气及水泻，一日4～5次，泻出粪水液量不多，纳食不思，苔黄腻，前已用过保和丸、枳实导滞丸、承气汤一类方剂，毫无应验，延已五天，精神疲乏，消瘦显著，乃用三物备急丸3克，分二次吞服，药后腹中如雷鸣，泄泻二次，有粘物性的粪便，腹痛即止，翌日已思纳谷，调理数日而愈。

2．居××，男，60岁，搬运工人。

因食尚未煮烂的野豆半升许，当夜即觉腹中胀而不适，渐则胀而疼痛，大便秘结不通，先服消导承气汤之类而未见效，又用西药润肠通便剂及灌肠等法亦无效。病延至6天，躁烦不安，因胀痛呻吟不绝，有恶心而未吐；乃用三物备急丸3.6克，分二次吞服，初服后约20分钟，即腹中雷响而便，便时因粪干结而肛门疼痛，3小时后又服一次，渐呈软便，翌日诸恙均除，惟肢体乏力，调养数日而愈。

体　会

三物备急丸是巴豆、大黄和干姜三味组成。巴豆辛热有大毒，功能开窍宣滞，去脏腑之沉寒及生冷硬物所伤，为斩关夺门之将药；大黄味苦性寒，功能荡涤肠胃，下燥结而除

瘀热，因其药性苦寒而与巴豆同用，可以中和巴豆辛热之弊，使药性缓和；干姜性辛温，有止呕作用，故本方之三味药物，初观似乎药物猛烈，但配合得宜，只要诊断无误，可放胆使用。

方书载：本方主治寒积，而对可治坚硬燥矢不下之症，则人多忽视。例如上述病案，都已用过保和丸、枳实导滞丸、承气汤以及润肠、灌肠等法，皆未能取得效果，而改用本方后积滞即得下逐，症状亦就缓解。录自（上海中医药杂志1964年，5，“用三物备急丸治疗食滞的经验。”邹维德）

延按：《千金》三物备急丸与《伤寒论》中治寒实结胸之三物白散，虽同属温通寒结方剂。但一则用巴豆而伍以桔梗、贝母，治寒痰结聚在胸，故用之以温开其上；一则用巴豆而伍以大黄、干姜，治寒结肠胃，故用之以温下其寒。考巴豆一物，《珍珠囊》谓其能“导气消积去脏腑停寒，治生冷硬物所伤，”与本案病情相符，故借用之以治服一般下剂无效者，竟能获效，但峻猛下剂，应中病即止，无使过之伤其正也。

独活寄生汤证案（二例）

1、痢后腰痛

陈三农治一士，痢后腰腿挛痛，不能俯仰，此肾虚风寒

湿所乘也。用独活寄生汤，二剂愈。录自《名医类案》

2、腿足挛痛

朱丹溪治一妇人，患腿兼足胫弯挛痛，服发散药愈甚，尺脉弦紧，此肝肾虚弱，风湿内侵也。以独活寄生汤治之痛止。录自《续名医类案》

延按：独活寄生汤方：药为独活、防风、细辛、桑寄生、杜仲、牛夕、桂心、当归、川芎、芍药、熟地、党参、茯苓、秦艽、甘草等15味组成，能补虚宣痹，有祛风湿、止痹痛、益肝肾，补气血之功。方中以独活、桑寄生为主药，能祛风胜湿，养血和营，活络通痹。牛夕、杜仲、熟地为辅药，能补益肝肾，强壮筋骨。川芎、当归、芍药补血活血，党参、茯苓、甘草益气扶脾为佐药，又用细辛以搜肾经风痹，桂心以温肝经血寒，秦艽、防风祛周身风寒湿邪从外解为使药。本案两例，一为痢后肾虚为风寒湿所乘，一为肝肾虚弱，风湿内侵，病属本虚标实，非用此标本兼治之方剂，殊难见功也。

独活寄生汤证案

风湿肢体肿痛

孙建民，男，10岁，1957年6月18日初诊。

患儿于50年，左脚忽然肿痛，用中药外敷治愈。52年复发，左脚外踝骨发现微肿，未与注意。至53年扩展至左膝及周身骨节亦发现肿痛，屡治未效。56年12月来京，经各医院诊治，认为系血液病或血小板减少紫斑症，历久不愈。周身现有紫色肿块，肢体疼痛，游走不定，脉浮缓。此症系由于风寒湿毒侵入腠理，有流注之势，宜急与除湿导滞祛风散瘀之剂。

处方：松节　木瓜各9克　秦艽　独活　白芍各6克　牛夕　川芎各3克　茵陈　毛术　防风　茯苓各6克　桑寄生6克　甘草1.5克

二诊：服前方两剂，膝部仍然肿痛，肿处蓄有瘀血，皮肉赤紫，脉现沉缓。由于肝肾虚弱，风邪流入脚膝，寒湿注于关节，故有此症。用《千金》独活寄生汤为治。

处方：独活　桑寄生　杜仲　沙参　秦艽　生地　桂枝　白芍　防风　牛夕　当归　茯苓各6克，川芎3克　甘草　细辛各1.5克

三诊：寒湿渐去，膝部肿痛轻减，中间因饮食减少，脉来沉细，另以培本和胃之品，香砂六君子汤加味。

处方：沙参　白术　茯苓　法夏　陈皮　藿香　神曲　焦曲各6克　谷芽9克　砂仁　炙甘草各1.5克

按：服药后肢体疼痛已轻减，饮食亦增进。9月2日又因积食滞胃，兼染疟疾，用达原饮加减治之。疟疾愈后，饮食睡眠均好，神情活泼，膝部痛减。只肿未全消，两足经常发凉，不良于行，续拟温中散寒之剂。

处方：制附片4.5克　炮姜3克　沙参9克　白术　法夏　松节　木瓜各6克　桑寄生6克　砂仁1.8克　甘草1.5克

服药后，精神、眠食均有增进。10月20日，右肘部又发现肿块，经一昼夜即消，右腿能屈伸自如，痛亦轻减，两足亦已回暖。由于身体虚怯，气血乖违，虚邪与血气相搏，以致聚于关节筋络间之风寒湿邪散而不尽，仍以独活寄生汤为治，外用虎骨膏贴患处。中间一次因嬉戏过劳，左脚外踝又现轻微肿痛，与以培元固肾之剂。两月后肢体关节肿痛及瘀血均已次第消失，未见复发，嘱其每早晚服六味地黄丸6克，以滋水培木助其恢复，由于为日过久，气血大亏，除加意调护外，佐以人参归脾，连服十剂，不再反复。录自现代医案选第一集（原载中医杂志1968年6月号，王朴诚医案）

延按：本案系一十岁小孩，患了严重的风湿症，初服一般除湿导滞祛风散瘀之剂，效不显。二诊根据病程达数年之久，病久皮肉紫赤，认为有瘀阻，脉现沉缓，断为肝肾虚，风邪流入脚膝，寒湿注于关节。故用独活寄生汤，益肝肾、补气血、祛风湿、止痹痛药品，即收到明显效果，俟病情好转，续见他症，再随症情变化处以对症方药。可见治疗儿科疾病，不可一概视为纯阳之体，仅用平淡之方，不敢用温通滋补之剂，就不能愈此痼疾。

独活寄生汤加味证案

风 湿 脚 痿

卅年前，有一潘姓病人，年四十余岁，业建筑，患两脚

痿痹不能行走。遍请中西医诊治，因其形瘦体弱，认为操劳过度，宗筋驰缓，肝肾虚损所致。进服大量滋腻补药，如鹿茸、狗肾、熟地、首乌之类，并注射睾丸激素，未能见效，复患大便秘结，沮丧万分，乃延先君诊治。视其形色尚无败象，闻其声音正气尚好，诊脉弦滑，舌苔厚白，询其始末，得之患者病前曾淋雨受湿，恍然悟知症系风湿浸淫，进补过早，外邪内困，表见虚象，内为实症，乃处独活寄生汤加熟军。

独活　防风　芍药　党参各6克　秦艽　当归　地黄　杜仲　牛夕　茯苓各9克　桑寄生12克　甘草　肉桂各0.24克　细辛0.12克　川芎　酒军各4.5克

药后，大便畅通，两脚亦见松动；连服五剂，病情日渐好转，不旬日即能行走如常，其病若失。

独活寄生汤治风寒湿侵袭的痿痹症，兼久病后肝肾亏损者，有祛风湿、止痹痛、补气血、益肝肾的功效。方以独活、细辛、防风、秦艽、祛风湿、止疼痛，以地黄、牛夕、杜仲、寄生益肝肾，归、芍、川芎活血补阴，参、苓、甘草益气健脾，肉桂温中，若患者大便艰难或便秘，则加熟军通便行滞。录自（近代中医流派经验选集《朱南山先生的医学成就，朱小南》）

延按：本案患者系一壮年，又业建筑，因职业关系，经常接触水湿，自在意中，病因又由淋雨受湿引发，诊脉弦滑，舌苔厚白，均与水湿症相符，无阳痿遗泄腰酸耳鸣等肾虚症状，则内服滋腻补品，外注射睾丸激素，是药不对症，当然无效。本症属风湿浸淫，自应祛除风湿为主，但患者形瘦体弱，又不能不从虚处考虑，本例属实中兼虚，故用此虚

实兼顾之方，患者有大便秘结，当系进补太早，阻滞里气不通，浊气不降，故用熟军加入本方内以推陈致新，使浊降清升，内外气机畅达，故能获效。

独活寄生汤加减证案

风 湿 腰 痛

郑××，男，40岁。

症状：1953年夏月，腰痛不能转侧，膝疼不可屈伸，四肢沉重，倦怠无力，脉象濡细，舌苔白腻。

诊断：肾气虚弱，风湿相乘，流于腰膝，着而作痛。

疗法：法宜和血脉，疏风湿，补肝肾，强筋骨，以独活寄生汤加减治之。

处方：独活　川芎各6克　干地黄　白芍　茯苓　杜仲　怀夕　金狗脊各9克　党参　当归各12克　桑寄生18克　水煎服。并送服小活络丹半粒。服十剂疼痛减轻，原方加减再进。

处方：独活6克　干地黄　杜仲　怀牛夕　狗脊　淫羊藿　巴戟天各9克　党参　当归各12克　桑寄生18克　水煎服。

自按：经云："腰者肾之府，转摇不能，肾将惫矣；膝者筋之府，屈伸不能，行则偻俯，筋将惫矣。"（注）肾主骨而肝主筋，腰膝疼痛，不能俯仰屈伸，症属肝肾两虚，虚

而兼挟风湿，故在补肝肾药中，取独活理少阴之风湿，桑寄生驱厥阴之风湿，以为引经之报使。注：《素问·脉要精微论篇》录自（蒲园医案）

延按：本案用独活寄生汤去秦艽、防风、细辛，加入狗脊、淫羊藿、巴戟天等品，是在紧密结合脉舌症状上，判断为肝肾两虚，虚中兼挟风湿，故着重以滋养强壮腰膝为主，稍佐一二味祛风湿药足矣。因为化裁得当，并不拘泥成方，所以能收到良好效果。

独活寄生汤加减证案

寒湿腰痛

腰为肾之府，肾主骨髓，与膀胱相表里，由于肾气不足，寒湿乘虚侵犯下焦，导致腰痛，牵引小腹，应于温通剂中兼补其肾。

处方：独活6克　桑寄生12克　细辛　肉桂各3克　生白术　炒白芍　茯苓各9克　炒小茴　炮干姜各6克　炒杜仲　补骨脂　淫羊藿各12克

按：本例乃肾虚寒湿导致之腰痛，用独活寄生汤加减以温肾祛寒；因肾气旺盛，气化水行，则湿自去，故不以治湿为重。录自（沈绍九医话）

延按：独活寄生汤原方为独活、桑寄生、秦艽、防风、细辛、川芎、当归、地黄、芍药、桂心、茯苓、杜仲、牛

夕、人参、甘草十五味药物组成。本案于此方中去归、芎、地黄、芄、防、牛夕、人参、甘草，加白术、炮姜、炒小茴、补骨脂、淫羊藿。因本案病原是寒湿乘虚侵犯下焦，治疗重点应以温肾祛寒为主。

故减去原方中祛风的芄、防，温通血脉的归、芎、牛夕，补益气血的参、草、地黄，而加白术通腰脐之气，炮姜佐白术以温运沉寒痼冷，（师肾着汤意），炒小茴走下焦以理气止痛，淫羊藿补肾壮阳，祛风除湿，补骨脂壮元阳而治腰膝冷痛。因其方中药味增减，处处针对病情，故能收良效。

驻车丸证案（二例）

1、里急便血

嗔怒动肝，络血乃下，按痛减为虚。夫肝木上升，必犯胃口，遂胀欲呕，清阳下陷，门户失藏，致里急便血，参、术、炮姜，辛甘温暖，乃太阴脾药，焉能和及肝胃……。

处方：驻车丸　黄连、当归、干姜、阿胶，

录自《清代名医医案精华，叶天士医案》

2、赤痢腹痛

经云："代则气衰，细则气少。"（注）多指阳气而言。今下痢而得是脉，脾肾之阳微特著。况形衰畏冷，而小便清

长乎。惟下痢赤者属血分，腹中痛者为有积，立方当从此设想。盖寻其罅而通之补之，亦治病之巧机也。

处方：驻车丸　附子枳实理中汤送下。

注：《素问·脉要精微论篇》　录自《清代名医医案精华·王旭高医案》

延按：驻车丸药仅四味，方中黄连、阿胶，坚阴止痢，当归和血止痛，干姜温中化湿。治湿热羁留，日久伤阴之痢，是标本两治，虚实兼顾之方。例一，仅用辛甘温暖药，未配合养血坚阴之品，所以无效。例二，赤痢而兼见脾肾阳微兼有积的脉症，故用附子枳实理中汤送驻车丸获效。

驻车丸加味证案

痢转便血

红白痢变为便血，当时血色尚鲜，后又转为紫黑，或带血水而不了结。暑湿深入营中，气虚无力以化，降而不升也。

处方：驻车丸　加广木香、党参、甘草、灶心土、荠菜花，

诒按：此证血分中有留邪，尚宜参用和血之品。　录自（柳选《继志堂医案》）

延按：考案中所用荠菜花，载《别录》上品，性味甘温无毒，能治久痢。至和血之品，当不外生地、赤芍、丹皮、

地榆、旱莲草一类药物，加入驻车丸中，以除血分中留邪，更能增强疗效。

硝石丸证案

积　块

朱丹溪治一婢，色紫稍肥，性沉多忧。年四十，经不行三月矣。小腹当中有一气块，初如栗，渐如盏。脉涩重取却有，按之痛甚，而扪之高半寸。与《千金》硝石丸，四五次，忽乳头黑且汁，恐孕也。朱曰：涩脉无孕，又与三五帖，脉稍虚豁，知药峻矣。令其止前药，与四物汤倍加白术，佐以陈皮，三十帖，俟脉完，再与硝石丸数次，块消一半，止药又半月，经行痛甚，下出黑血半升，内有如椒核者数十粒，已消一半，累求药不与，待其自消。（琇按：即大积大聚，衰其大半而止之义），至经行三次，每下小黑块乃尽消。凡攻击之药，有病则病受之，邪轻则胃受伤矣。夫胃气清纯中和者也，惟与五谷肉果菜相宜，药石皆偏胜之气，虽参、芪性亦偏，况攻击者乎。此妇胃气弱，血亦少，若待块尽而却药，则胃气之存者几稀矣。录自《名医类案》

延按：硝石丸治痞块症瘕，药为：硝石180克，大黄240克，人参、甘草各90克，丸如鸡子大者，每服一丸。丸如梧桐子大者，每服卅丸，米饮送下。观丹溪此案，治积块不消，还是主张用峻药攻破的。然用药进退得法，如用硝石丸

后，脉见虚豁，即转手施以调补气血之品，俟脉完，再予硝石丸。如此攻补兼施，使病去而正不伤，庶无流弊。最后论养胃之法，不在药补而重食补，深合内经之旨，不愧为金元名家。

温脾汤证案（四例）

《千金要方》心腹痛门，温脾汤条下说："治腹痛，脐下绞结，绕脐不止。"但笔者通过临床体验并观察吸取他人治验，认为在中医辨证论治的基础上，本方到不必局限在千金所说治疗腹痛这一基本症候上。为了方便讨论，且选四个病例记述于下：

1、腹腔积水

张××，男，46岁，农民。患者于1956年6月间，初觉消化不良，腹部不适，双脚发生轻度浮肿，请中医治疗，服五苓，五皮饮之类未效。病渐加重，腹胀渐渐膨隆，乃就医于南昌某医院，住院月余未愈。后转赴湖南医学院附属医院，诊断为肝硬变，用药后小便增多，腹围渐次缩减。约经二个多月的治疗，脚肿全消，腹部平复如常。但患者出院不久又复发。11月14日就诊于赤山区张宗舜中医师，当时的症候是："脉实，舌黄赤，腹满，绵绵而痛，间有脐下阵痛，喜按，小便清短，大便秘结，自觉渴喜极热，开水越热，喝下去腹内越觉好受，并思饮热酒，食欲不振，吃稍多，脘闷

胀痛，颜面瘦削，精神甚感惫困。”张医师开了一张温脾汤。初服一剂，矢气频频，腹内稍感舒畅。续进五剂，仍是矢气不止，腹满日见消减，口渴喜热的现象，也有所减轻。续用原方再十剂。服药期间溏泄数次，药服完后，腹胀满和口渴的现象，完全消失，最后给四君子加味调补以善后，病未复发。

初诊处方：党参厚附块各9克　干姜6克　秦当归12克　生川军18克　元明粉12克　甘草3克

次诊：生军减为12克　元明粉减为9克　连服十剂，一日一剂。

2、虫积

张××，男，10岁。患者间发绕脐痛已近一年。1942年9月间病发，就诊于利慕贤中医师，病孩腹痛甚剧，喜按，四肢微厥，头面部微有冷汗，口吐沫，面色㿠白，唇红，舌苔薄白微夹朱点，不渴，小便清长，大便秘结，脉搏沉迟，身体瘦弱。认为沉寒久积，给温脾汤。第一剂初煎服下，痛未减，服完二煎，痛反增剧，过四小时后，下蛔虫数十条，痛即旋止，续进十剂，后转予乌梅丸加调理脾胃竟功，从未复作。

处方：条参　附块各9克　当归6克　大黄　元明粉各9克　干姜　甘草各3克

3、虫积

梁××，女，8岁。患者腹痛绕脐，喜按，十余天来，

昼夜阵发不停，曾在县卫生院检查，粪便中有虫卵，该院予服驱虫药未排出虫体，痛反益剧，来萍镇联合诊所就诊时，患儿唇红便秘，舌苔白夹朱点，不渴，脉沉数，腹痛持续绵绵，阵发绕脐，时欲以手抚脐。

处方：西党参　当归各9克　附块6克　干姜3克　甘草0.8克　大黄　元明粉各12克

一剂后便通，痛大减，二剂痛全止，愈后迄今未发过腹痛。

4、食积

姚，女，24岁。患者产后已个多月，因伤食诱发胃痛，治未愈，续发脐周痛，并牵连小腹，日渐加重。遂入萍乡县中医院住诊。入院时日夜发作一次，腹剧痛时放射至腰，季肋部、或泛游于满腹，以手紧压稍减。痛作每于阵泄（微有热感）后减轻。脉沉弦而紧，唇红，舌白有津夹朱点，不渴。

处方：西党参　熟附块各9克　干姜3克　当归9克　酒大黄6克　元明粉9克　甘草4.5克　服药一剂后，稍发阵痛，未几即止，晚上腹泄十次，黑黄色稀便，白天痛苦消失，晚上痛也减轻了，续进一剂，基本消除了疼痛，以后给调理之剂，第四天出院，之后胃痛虽未根除，但脐腹痛已未复作。　录自（1958年3期《中医杂志》“温脾汤疗效的探讨”一文，钟新渊）

延按：本方属于用温药攻下之例。汪讱庵汤头歌诀曾载此方。并谓：方中硝、黄以荡其积，姜、附以祛其寒，参、

草、当归以保其血气。观案中叙述的四个病例，虽然病因不同，但病候都属里实壅滞之象。此方系在调胃承气汤的基础上，加入调补气血兼温中下药品。符合泻实不伤正，补虚不壅邪，逐寒不助热，泄热不生寒，所以能发挥其治疗效果。

漏芦汤加减证案（六例）

漏芦汤方出《备急千金要方》（唐孙思邈撰），本方先后见于该书。其一，卷五下小儿篇载：漏芦汤治小儿热毒痈疽赤白诸丹毒疮疖方（漏芦　连翘　白蔹　芒硝　甘草　大黄　升麻　枳实　麻黄　黄芩），其二，卷廿二痈疽篇载：漏芦汤方，（漏芦　白芨　黄芩　麻黄　白薇　枳实　升麻　芍药　甘草　大黄）。

近年来运用《千金》漏芦汤治疗一些诊断明确，但缺乏理想治疗措施的各科疾病；如急慢性骨髓炎、血栓闭塞性脉管炎、乳腺小叶增生、肺脓疡、败血症等，获得显效。

方剂组成及意义：

我使用本方，根据临床效果，将方剂作如下调整：漏芦12～15克，白薇、枳实、白芍各9克，蒲公英15克，制军、升麻各4.5克，黄芩、甘草各3克，随症加减药味及剂量。

方义：本方以漏芦为主药，具有清热解毒、消痈散结之功；黄芩、白蔹载药入血，清里热而消痈肿以辅主药；大黄

荡涤陈积，清解热毒以助药力；方中升麻在此决非升提，与蒲公英相伍可清血中热毒；枳实利气，破症坚积聚；白芍、甘草清热和血调中。

临 床 应 用

《千金》漏芦汤原为治疗痈、疔、附骨疽、脱疽而设。痈疽之病因据《灵枢·痈疽篇》述："寒邪客于经络之中则血泣，血泣则不通，不通则卫气归之，不得复反，故痈肿。寒气化为热，热胜则腐肉，肉腐则为脓，脓不泻则烂筋，筋烂则伤骨，骨伤则髓消，不当骨空，不得泄泻，血枯空虚，则筋骨肌肉不相荣，经脉败漏，熏于五脏，脏伤故死矣。"这里阐述了形成痈疽的病因和病理，并指出"热"是发生痈疽的主要因素。……《千金》漏芦汤之功在于清热解毒、散结化瘀。根据中医辨证论治，不但能疗外证，也能治内证。

治 验 举 例

1．脱疽，（血栓闭塞性脉管炎）：

颜××，男，53岁，农民。患者于1976年9月下水田劳作后，自觉右下肢寒冷胀重，数日后下肢红肿胀疼，间歇跛行。5个月后右足大趾发紫溃烂，第一节趾骨外露，疼痛难忍，来我处求治，诊为"血管闭塞性脉管炎。"中医诊脉象滑数，舌苔黄腻。辨症为热毒壅滞经脉，发为脱疽，宜投《千金》漏芦汤合四妙勇安汤加减：漏芦　赤芍　元参　牛夕各12克　白蔹　枳实　当归　桑枝各9克　银花　茯苓各

15克　川芎　甘草各4.5克　另用乌梅炭研末外敷以蚀腐肉，溃疡面涂三黄紫冰膏。前方加减治疗一月后症愈溃痊。一年零二个月后随访未复发，可参加体力劳动。

2．附骨疽。（骨髓炎）：

蔡××，男，36岁，农民。高烧寒战，右臀部红肿疼痛三月入院。入院后用青霉素，庆大霉素及强的松等静滴廿余天，体温仍40℃左右持续不退，并出现烦躁谵语，神志不清，X光片：右股骨骨髓炎。白细胞13800，中性85%，诊断为骨髓炎并发败血症。转中医诊治，脉洪数，舌灰腻。辨证为热毒壅络，逆传心包。拟漏芦汤合仙方活命饮：漏芦　白芍各15克　白蔹　制军　黄芩　枳实　炮山甲各9克　天花粉12克　皂角刺6克　防风　制乳没各4.5克　另每日加六神丸60粒，分三次服。上方增损服30余剂，病情好转，继以六味地黄丸吞服善后调理一月，恢复劳动能力。

3．乳癖，（乳腺小叶增生症）：

林××，女，18岁，未婚，中药调剂员。形体羸瘦，情志多郁，双乳发现蚕豆大小肿块四、五个，已有三月，诊为：乳腺小叶增生症。于1975年9月来中医就诊，脉象弦数，舌质绛苔薄白。辨证为肝郁气结，阴虚内热，拟《千金》漏芦汤合逍遥散加减：漏芦12克　白蔹　白芍　当归　夏枯草各9克　黄芩2克　柴胡　枳实　炙草各6克　茯苓　仙灵脾　鲜麦冬各15克　生地18克　桔叶　皂角刺各4.5克　牡蛎30克　治疗2月余，乳癖消失。

4．腮痈，（急性颌下腺炎）：

杨××，男，13岁，学生。发热（39.5℃），恶寒，呕吐，烦躁，右下颌部肿痛难忍三天，脉沉数，苔黄腻。辨证

为肝胆郁热，痰火阻结。拟《千金》漏芦汤加减：漏芦　柴胡　野菊花　夏枯草各9克　黄芩　法夏各3克　制军　升麻4.5克　胆南星2.4克　白芍12克　紫地丁15克　牡蛎18克　另六神丸20丸，日服三次。外用紫金锭研末麻油调敷。五日后热退肿消。

5．肺痈，（肺脓疡）：

周××，男，5岁。持续高热（39℃～40℃）20余天，恶寒，胸胁痛，咳脓痰，口渴多饮，X光透视为肺脓疡。指绞青紫过气关，苔黄腻，中央灰褐。温毒炽盛，痰蕴肺络。宜《千金》漏芦汤合《千金》苇茎汤加减；漏芦6克　芙蓉花7.5克　白薇　桔梗各4.5克　苇茎　鱼腥草　一枝黄花　紫地丁各9克　黄芩2克　野荞麦根15克　炒谷芽12克　共服药25剂，痊愈出院。

6．痛淋，（肾盂肾炎）：

舒××，女，36岁，工人。患者有肾盂肾炎病史。近一周来因感冒发热诱发，头痛、畏寒、腰疼、腹胀、尿急、尿频、尿后刺痛。脉濡数，舌苔厚腻有齿痕。尿检：RBC1～8，WBC（廿），旦白（±）。诊为慢性肾盂肾炎急性发作，拟清热通淋，漏芦汤合导赤散意；漏芦　白芍　白蒺藜各12克　白薇　黄芩　淡竹叶　滑石各6克　生地18克　通草。甘草梢各3克　柴胡6克　茵陈24克　忍冬藤　白茅根各30克　服上药13剂痊愈。

体　会

笔者用《千金》漏芦汤加减治疗各科疾病50余例，中医

辨证均属湿热蕴滞，痰浊结阻的病症，获较佳疗效。且长期使用未见任何反应。录自（浙江中医药 1978，5，“《千金》漏芦汤的临床应用”潘毓仁）

延按：本案运用《千金》漏芦汤加减，提出了六个较典型的病例来讨论。前四例属外部疾患，后两例属内脏疾患。虽症状各有不同，但都系湿热痰浊等壅阻所导致，故以漏芦汤为基础方，并根据病情变化加入对症药品，至于本方方义及其临床应用，笔者在案中已叙述得非常详尽，可供读者参考。

（二）《外台》方医案

桔梗白散证案（二例）

1、肺痈

钱梅福，男，28岁。主诉：咳嗽，胸痛，已四十多天，近日痰有臭气。患者于一月半前在田间工作回来，觉怕冷发热，伴有咳嗽四肢疼痛，即延中医诊治，服药数剂后，怕冷四肢痛解而咳嗽不已，并增胸痛，痰色稀白混有血液，痰量不很多，咳嗽甚剧，夜难成寐，发热不退，精神困疲，以致卧床不起，经廿多天的中药治疗，咳嗽较减，晚上较能入睡，一般情况较好，乃能离床。但热度时有波动，胸仍有隐痛，痰中虽无血液而增臭气，多药调理，效力不佳。体温37.8C，咳嗽不甚剧，痰色稀黄，量中等，略有臭气，口干，脉数，舌被黄腻薄苔，营养较差，诉胸有隐痛。拟诊为肺痈。经予苇茎汤，葶苈大枣泻肺汤，桔梗汤，泻白散加减，以及犀黄醒消丸等治疗。兼为注射油剂青霉素30万单位三针，经十多日病情持续，未见显著改善，乃停止诊治，一周后又来门诊，热升至39.2C，痰中臭气加重，痰量增多，杂有脓状，胸闷不畅，神疲乏力，凡事扫兴，胃口殊差，见其病势转剧，测其病灶化脓可能正在进行，乃试用桔梗白散峻剂。 巴豆霜0.018克，象贝，桔梗各0.9克，共研，开水

送服。嘱服后泻不已吃冷粥一碗，下午服药，至晚大便泄泻十多次，服冷粥一碗而泻止。热已退，咳嗽大减，痰无臭气，胸中甚畅，诸恙如释。检体温37.3C，脉平，舌净，偶有咳嗽，而无臭痰，精神表情都良好，为处肃肺化痰剂，以搜余患，自觉病已好，迄今健壮如常人。

2、肺痈

钱阿堂，男，32岁。主诉：咳嗽三月，伴有发热。患者于三月前患伤风咳嗽，因不甚重而未服药，其后咳嗽不已，胸中觉有隐痛，且觉发热，乃延中医诊治，咳嗽发热时轻时重，不得退解。约一月后稀白痰渐转黄色，并发觉有臭气，服药少效，且于午后发热较增重，因疑为肺结核而服些营养品卧榻静养。检查体温38C，比较消瘦，面色憔悴，呈久病贫血状，咳不甚剧，吐稀黄痰，有臭气，量不多，舌红润无苔，脉数，诉胸部不畅有隐痛，家中无结核病史。拟诊：1．肺痈，2．肺结核。处甘凉清肺剂：如南北沙参 生地 麦冬 石斛 杏仁 茯苓 山药 桃仁 苡仁 冬瓜子等八剂后，咳嗽较好，精神略有进步，但胸中隐痛未除，痰中臭气依然，体温37.8C，决断为肺痈，考虑用桔梗白散，但顾虑其体力较差，决用较轻的剂量：巴豆霜0.015克，桔梗 象贝各0.9克，共研，开水送吞，嘱服后泻不止吃冷粥。翌日来复诊，谓服药后大便欲解不畅，症情未觉轻减，亦未觉有其他不快副作用，乃加重剂量，巴豆霜0.024克，象贝桔梗各0.12克，次日患者来诉服药后大便泻了八九次自已精神未为泄泻而疲，反觉诸恙都已轻解。检查热退，脉静，

舌仍红润，略有咳嗽，无臭痰，处清养药二剂，从此告痊。

总结两例患者，都是30岁左右的壮年人，都在后期应用桔梗白散。前用于病延一月半，体温骤升，病灶化脓进行之时，而体格较壮健。后者病延三月，体格较虚弱，初疑有肺结核可能，但因抓住了胸痛痰臭肺痛特有的症象。诊断为肺痈，而后放胆应用。桔梗白散下注谓："服后病在膈上者吐脓，在膈下者泻出。"两例服后都泻，无吐，并且都在泻后诸恙顿失，未有若何副作用。录自《1955年4月号中医杂志王焕庭桔梗白散治愈肺痈的经验》

延按：考本方一见于《伤寒论》太阳篇下146条名为三物小白散，治寒实结胸。一见于《金匮·肺痿肺痈咳嗽上气病脉症治》附方《外台》名桔梗白散，药味剂量与《伤寒论》相同。治"咳而胸满，振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者为肺痈。"惟《金匮》治此症用桔梗汤，肺痈重症，药力似过轻微，不如桔梗白散力猛功宏，可补《金匮》治法之不足。特录出以备临床参考。

茯苓饮加减证案（二例）

1、痰饮阻滞，肝胃不和

脉弦右大，弦则为饮，大则胃阳已虚，缘操持萦思，积劳阳虚，致不饥不食，勉纳食物不运，瞋怒，兼以夜卧不安，多寤少寐，恍惚中心懊侬，忽而腹鸣气震，四肢筋骱，痿弱

无力，起病时晨必寒痉，足跗微冷，按是脉症有年，阳虚为本，而痰饮气逆，因虚而聚，……议通补理胃阳为主，疏肝为辅，气宣阳甦，何虑痰浊之蒙昧，以茯苓饮法减术，合薛氏星附六君子意，

处方：人参　茯苓　香附　苏梗　白附　半夏　姜汁　陈皮　录自《清代名医医案精华·叶天士》

2、阳微浊逆

朱，气逆浊饮上升，甚则中夜起坐。医用二陈兼旋复代赭汤不应，诊脉乃阳微浊逆，用外台茯苓饮加干姜、沉香汁，愈。录自《类证治裁·林珮琴案》

延按：本案两例俱属痰饮致病，同用外台茯苓饮加减化裁。例一，为痰饮阻胃，兼夹肝郁，故于茯苓饮中去壅气之白术，只采方中之人参、茯苓、橘皮，以姜汁易原方中之生姜，更加半夏、白附以宣化痰饮，香附、苏梗以舒肝解郁，使气宣阳甦，则痰浊自散。例二，根据脉症断为阳微浊逆，想其脉必弦滑，舌必胖大多津，用二陈旋赭化痰降逆不应，当系药轻病重之故，本证不夹肝郁，故用原方加干姜以温运脾阳，沉香汁以降逆气，药证相应，故愈。考外台茯苓饮方，见《古方医案选编》上集十枣汤证案例二下。薛氏星附六君，即六君子汤加南星、白附，为薛立斋常用方。

黄连解毒汤证案

阳证似阴误服热药

郭雍治一人，年逾五十，五月间，因房后入水，得伤寒证，误过服热药，汗出如油，喘声如雷，昼夜不寐，凡数日，或时惊悸发狂。（汗出喘而不寐，果是无虚欲脱之象，不能数日之后，反见惊悸发狂之证也。）口中气自外出，诸医莫措手。郭诊之曰：六脉虽沉无力，然昼夜不得安卧，人倦则脉无力耳。细察之，尚有胃气不涩，（直格云，脉浮洪而见汗如油气喘者死，今脉沉而不涩，所以可救。）可治也。夫阳动阴静，观其不得安卧，气自外出，乃阳证也。又误服热药，宜用黄连解毒汤。（黄连　黄芩　黄柏　栀子），众皆危之。一服尚未效，或以为宜用大青龙汤，郭曰：此积热之久，病邪未退，药力未至也。再服病减半，喘定汗止而愈。录自《名医类案》

延按：本案从表面脉症分析，既有汗出如油，六脉沉而无力的虚脱现象，又有惊悸发狂，昼夜不寐，口中气自外出等非虚脱证，况又误服热药，故直断为阳证，并不因房后入水而有所顾虑，迳用黄连解毒汤以泻火解毒，一服病未减，认为药力未至，放胆再服，病始减而喘定汗止，然非胆识兼备者，不敢如此用药。

黄连解毒汤加味证案（三例）

黄连解毒汤方出《外台》，为黄连、黄芩、黄柏、山栀子四味组成。《活人书》列于火证门，主治三焦之实火，内外皆热，烦渴，小便赤，口舌疮。《医方集解》主治一切火热，表里俱盛，口燥咽干，大热狂躁，烦心不眠，吐血衄血，热盛发斑等症，笔者尝用此方于咯血、衄血以及诸出血而属阳证实热者，屡获卓效。

1、鼻衄

一女性患者，发热头疼，鼻出血，出血量甚多。曾用京墨纸卷塞鼻孔，血仍从鼻道流出，咽下或满口吐出。经服中药以及西医注射种种止血针剂，虽得暂时止血，但须臾又复流血。予诊得脉象有力而滑数，外观上虽无重症高热现象，但测量体温始终在38℃度之间。患者感觉头胀、心烦、并不口渴，大便尚正常，但稍稍倾向于干结。舌布腻苔，因墨汁及血液而染成灰褐色。平时月经正规，此次逾期数天，未见来潮。患者过去既无鼻衄史，现在又无其他兼症，只开始时微觉感冒样头疼、头胀，反复思考，摸不着头路，初疑为月经之代偿性出血，投以桃仁、红花、茜草根等通经之剂无效，继思既有头疼，又有微热，流血虽多，面色并不苍白，参以色脉，当属阳证实证。因决定以黄连解毒汤加味，嘱予冷服，药后，血不复再出，只数服而痊。

2、麻疹

一个十来岁的麻疹患儿，发疹期高热咳嗽气急，麻疹出密、色赤带紫。疹后身热不退、烦渴、咳嗽、鼻衄、齿龈出血、口臭龈肿，脉细弦数、舌质绛红，根有黄苔，小便赤涩、大便色黑呈恶臭，但不干结。显属麻疹余毒，颇有并发牙疳的危险。初拟用犀角地黄汤，以患儿家庭经济关系，改用黄连解毒汤加鲜生地、丹皮、赤芍等。数剂顺利治愈。

3、肺结核咯血

一肺结核患者，男，40岁，咳嗽，多量咯血，用滋阴降火止血之剂，屡治无效。因头痛发热，有口疮，脉滑数，舌苔黄，改用黄连解毒汤加味，血即止。临床经验证明，肺结核患者之咯血，往往兼有发热。在一般情况下，宜滋阴降火法，但在另一种情况下，即患者咯血发热，兼有头疼头胀，脉数而滑，或带浮，心烦、口渴、睡眠不安，小便色黄，或排尿有热感，大便倾向于干结者，属阳证热证。此时用滋阴降火法则无效，用本方加味，往往应手而愈。一般说来，肺病发热吐血，属阴虚者较多，但事实上确有属阳证实热证的。……实践表明，中医辨证，必须参合色脉，根据具体病情，辨别表里虚实寒热而用药。

本方方义：黄连降心火，黄芩清肺火，黄柏泻肾火，山栀子凉血热，且四味均具强烈的消炎作用，组合一方，协同而奏清热解毒凉血消炎之功。此方不仅用于吐衄，其他如诸种热性疾患之充血性炎症，胆囊炎，黄疸，膀胱及尿道炎，

赤淋尿血，眼结膜炎，急性脑充血，烦热躁狂等，如方证相适应即有效。中医整体治疗之所以能够“同病异治，“异病同治”的道理，就在这里。录自（《江苏中医》1961．12，38页黄连解毒汤的应用，”叶橘泉）

延按：本案运用《外台》黄连解毒汤治疗了三个不同的病例，均获效果，体现了“异病同治”的典型。如例一的鼻衄患者，根据滑数有力之脉和流血虽多，面色并不苍白等症状上着眼，断为阳证实证，而用本方加味治疗，余意拟加牛夕、丹皮、茅根、藕节等品以凉血清热，引血下行。例二的高热不退的麻疹，有鼻衄、齿衄、舌质红绛、脉细弦数等脉症，为热盛化火伤阴的现象，故用本方以泻火解毒，合犀角地黄汤去犀角（以价昂无力购买）甘苦合化，是泻火养阴并用之法。例三的肺结核患者，主要治法，当然以养阴为主，但案中所述脉症，确属阳热实所引起，则治疗自当以清热泻火为主，仍用本方。为了照顾肺结核的咳嗽咯血，可适当加入南沙参、枇杷叶、苇茎、冬瓜仁、兜铃、阿胶之类，则泻火而不伤阴，两者兼顾，似更妥当。

黄连解毒汤合普济消毒饮证案

阳 症 似 阴

熊清平乃郎，将冠得温热病，自以感冒法治之，已不中病，延医更谓阴虚，投以六味地黄汤，益不中病。迁延旬

日，胸腹饱胀，稍按甚痛，潮热渐退，四肢冰冷，手足爪甲皆黑，舌胎干燥，口不知渴，与之以水则咽，大便五日未通，小便赤涩而少。咽喉肿塞，口不能言，耳聋不知所问六脉举按皆无。医者不审热深厥深之旨，郁热蓄盛，脉反滞涩之变，热甚神昏，口不知渴之情，复不将望闻问切四字较勘，仅守发厥脉伏之假象，冒为真据，且将胸腹饱胀，为阴寒上逆，而可按拒按，置之不辨。咽喉肿塞，妄为虚阳上浮，而色之赤白，口气温冷，又置之不辨。又以大便燥结，谬为阴凝不化，而痞满实坚全具，又置之不察，直将一切内热明症，概为假热，竟用四逆汤，附子用到一两。余内外一探，知为温热重病，阳邪亢热已极，反兼寒化，如酷暑雨雹之象，势亦在危，而细勘详洵，明是在表失表，在里失里，酿成极重热症。再诊其脉，举按虽无，而沉候至骨，劲指甚坚，极蒂未绝，喜其可治。因谓曰：此大热症也，遂疏黄连解毒汤合普济消毒饮，重加大黄，嘱其日夜两剂，务俾大便通则火不伏，而厥可回，脉可出……将药徐灌，约二时之久，一剂已终，小水甚长，即索水饮，见人事清醒，复煎一剂，是夜连得大利，果厥回脉出，次早复视，更以凉膈散，重服清胃药而健。　录自《谢映庐医案》

延按：本案由于患温热病，治不得法，妄用表散滋腻，致热深厥深，又妄施辛热之剂，造成表里气机闭郁，故用普济消毒饮宣透表热，黄连解毒汤加大黄通泄里热，迨病势减退，再以凉膈散搜剔胸膈余热，因其判断病情准确，处方用药恰当，始克挽救此一危重之症。

解急蜀椒汤证案

虚寒腹痛

杨大昭，六旬老翁。人肥胖而精神不佳，顷病腹鸣攻痛，上下走逐，胸满欲呕，脉沉紧而迟，此系水寒之气相搏于中，脾肾失调所致。曾服理中汤、附子粳米汤多剂无效。思本病实为脾肾阳衰不胜阴寒，前方不效，乃力不及之故。乃改用大建中汤，但呕痛未略减，且四肢有厥意，人亦虚弱已极，是时不唯宜温而且宜补。因再疏《外台》解急蜀椒汤。

处方：蜀椒6克，大枣5枚　甘草6克　干姜　半夏各12克　附子15克　党参18克　饴糖30克　煎好冲服。药后阳回厥止，痛呕大减，再二剂遂愈。随用肾气丸，大补汤间服，渐次康复。录自《赵守真治验回忆录》

延按：本案根据患者年龄，体征，脉症等，断为脾肾阳衰。大建中汤虽能起到温健中阳的作用，但温肾止呕之力不足，故复于方中再加附子、半夏以温肾止呕，甘草、大枣以增强补中之力，故效。

秦皮汤加味证案

温病下血

曾遇一病者，发热甫八天，体温仅摄氏卅八度，他无所苦，苔黄，脉细弦。论证状似极轻浅，但精神极为委顿。问其大便，答曰方解，略带溏薄。询其色泽，谓未加注意。再细询之，则谓裤上曾有污染。因即掀被视之，则已满沾血污。设当时稍一疏忽，其后患不堪设想矣。故凡临床上见面色㿠白，或精神委靡，腹痛便溏等，必须注意其大便色泽，庶免贻误。至于治法，以《外台》秦皮汤为主，（范汪疗伤寒腹中微痛不止，下利，秦皮汤方：秦皮　黄连　白头翁　阿胶）①随证加人参、西洋参、生地、银花炭等味。按本方即白头翁汤去黄柏、加阿胶。先父所以选用此方者，以出血之后，阴津大伤，黄柏过于苦寒，殊非所宜，而黄连却有一特点，即是厚肠。按刘潜江云："愚谓《别录》谓黄连调胃厚肠，不得混而称之曰厚肠胃也。夫肠胃中皆有脂膜一道，包裹其内，所以护导滓秽使下行者。若有湿热混于其间，则脂膜消熔，随滓秽而下，……胃体广大，容垢纳污，虽有所留，亦未必剥及脂膜，故但和其中之所有，边际自不受伤，故曰调。肠势曲折盘旋，惟其曲折盘旋之处，更为湿气留聚，湿阻热益生，热阻脂膜亦消，去其所阻，则消烁之源绝而薄者厚矣，故曰厚。"②如此一比，则连优于柏，且阿胶可以止血。先父常用此方以治温病下血，颇见功效，因而

得以挽救者，为数不少。录自（近代中医流派选集，夏应堂氏临床经验介绍，夏理彬）

注：①《外台秘要，卷二，伤寒下利及脓血黄赤方》

②《本经疏证，卷三，黄连》

延按：白头翁汤见《伤寒论，厥阴病》370条为治热利下重之方。《金匮·妇人产后病脉症治》篇，于上方加甘草、阿胶，又治产后下利虚极。本案采用《外台》秦皮汤，（白头翁汤变方）以治温病下血，再佐益气生津之人参、西洋参，补血养阴之生地，清热解毒之银花炭，似较原方更能针对病情。其解释黄连厚肠胃之理，黄连与黄柏功用优劣之比较，分晰明畅，真可谓读书得间，学古有获者矣。观此案更可悟出药物取舍之间，俱有至理，否则难免苓、术、归、芍到手便撮之诮。

编　后　记

中医古典著作的研读，是学习中医基础课的必修科目。在粉碎“四人帮”后，迎接四化建设的今天，为了加强中医基础理论的学习，并使之紧密联系临床实践，尤其具有重要意义。编者有鉴于此，特将中医古典著作中有关《伤寒》、《金匮》的主要方剂及其加减运用，搜集古今医家验案若干则，加以汇编，旨在说明古方如果能针对病情，剪裁得当，是能够治今病的。至于《金匮》中附有《千金》、《外台》方，足见此两书是能羽翼《伤寒》、《金匮》的，故亦选录若干常用方剂的医案，作为附篇，借省读者翻阅之劳。惟编者学识有限，搜罗不广，取材不精之处，在所难免，不过希望在建设四化大厦中，作一点添砖加瓦的工作罢了。并盼医界贤达阅后提出宝贵意见，以便不断改进和提高。

编　者　1980年5月24日